



 Direktoratet for e-helse  Helsedirektoratet

Utredning av «Én innbygger – én journal»

V3.1 E-helsekapabiliteter

Oktober 2015

Innhold

Innledning.....	3
1 Virksomhetskapabiliteter	5
1.1 Innledning	5
1.2 Overordnet virksomhetsmodell for helse- og omsorgssektoren.....	9
2 E-helsekapabiliteter	49
2.1 Innledning	49
2.2 E-helsekapabilitet 1: Dokumentasjon av forløp og tilstand.....	50
2.3 E-helsekapabilitet 2: Pasient-, tjeneste- og ressursadministrasjon.....	59
2.4 E-helsekapabilitet 3: Plan, oppgaveadministrasjon og fagfellestøtte	67
2.5 E-helsekapabilitet 4: Kunnskaps- og beslutningsstøtte	77
2.6 E-helsekapabilitet 5: Kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap ...	80
2.7 E-helsekapabilitet 6: Innbyggertjenester.....	86
2.8 E-helsekapabilitet 7: Personverntjenester.....	95
2.9 E-helsekapabilitet 8: Brukervennlig IKT	98
3 Bibliografi.....	100

Innledning

Dette dokumentet er et vedlegg til Mulighetsstudien, og beskriver de arkitekturmodellene som brukes for å avgrense omfanget for tjenester og funksjonalitet i utredningen for Meld. St. 9 «Én innbygger – én journal». Dokumentet beskriver følgende modeller:

- **Kapittel 1: Virksomhetskapabiliteter.** Dette er kapabiliteter på et overordnet nivå som beskriver hva virksomhetene i sektoren leverer.
- **Kapittel 2: E-helsekapabiliteter.** Dette er kapabiliteter som utføres av e-helseløsninger (IKT-løsninger) og beskriver den funksjonalitet som på et overordnet nivå understøtter virksomhetskapabilitetene.

Dokumentet brukes til følgende formål:

1. Å beskrive den funksjonalitet som er nødvendig for å **understøtte analyse av kostnads- og nyttevirkinger** i den samfunnsøkonomiske analysen.
2. Brukes i **modellering av den IT-arkitektur** i de ulike konseptene som er nødvendig for å realisere den funksjonelle nytten. IT-arkitekturen er grunnlaget for å analysere investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader i den samfunnsøkonomiske analysen.

Merk: Dette er et foreløpig dokument som det forventes vil utvikles videre i forprosjektfasen.

Kapittel 1

VIRKSOMHETSKAPABILITETER



1 Virksomhetskapabiliteter

1.1 Innledning

Dette kapitlet beskriver de virksomhetskapabiliteter som aktørene i helse- og omsorgssektoren samlet trenger for å levere på samfunns målet for sektoren. Dette er i utgangspunktet en kompleks oppgave ettersom sektoren over tid har utviklet seg til å omfatte mange aktører med til dels overlappende virksomhetskapabiliteter og til dels spesialiserte oppgaver. Vi har derfor i størst mulig grad tatt utgangspunkt i eksisterende modeller og gjort nødvendige forenklinger for å kunne opprettholde den oversikten som er hensiktsmessig i beskrivelse av konseptene. Modellene skal i utgangspunktet brukes for å analysere behovet for informasjonstjenester (e-helsekapabiliteter) og dette betyr at det ikke er vår ambisjon å beskrive alle arbeidsoppgaver/prosesser som utføres av alle aktører og helsepersonell i sektoren.

1.1.1 Definerings av kapabiliteter

I arbeidet med definering av kapabiliteter er det lagt vekt på konsistens og overholdelse av spesifikke retningslinjer for å sikre et produkt av høy kvalitet. Retningslinjene har blitt videreutviklet gjennom prosessen, og har vært inspirert av The Open Groups arbeid med standarden *The Exploration & Mining Business Capability Reference Map* (1). En overordnet føring har likevel vært at både modellen i seg selv og begrepene så langt som det er mulig skal være gjenkjennbare i helse- og omsorgssektoren.

Bruk av substantiver

Alle kapabiliteter er uttrykt som substantiver og ikke verb. Verb assosieres med prosesser og ikke kapabiliteter. For prosessperspektivet vises det til Healthcare Delivery Reference Model, utviklet i regi av Helse Sør-Øst RHF.

Komplette navn

Kapabilitetene er forsøkt navngitt med komplette navn slik at en kapabilitet skal kunne forstås også når den ses på isolert uten omkringliggende kontekst i figuren.

1.1.2 Referansemodeller

Det finnes i dag mange ulike modeller som har til hensikt å gi en samlet oversikt over sektorens verdiskaping, men det finnes ingen standardisert sektormodell. Vi har gjennomgått en rekke modeller for å vurdere om noen av disse kan gjenbrukes i sin helhet eller delvis. Her følger en oversikt over de modeller som er gjennomgått.

Generisk modell for helse- og omsorgssektor

Modell: IN1284 ISO DTR 14639-2 Health informatics Capacity-based eHealth architecture roadmap Part 2 Architectural components and maturity model

- Modellen er et resultat av drøftinger mellom ISO TC 215 Expert Group, inviterte eksperter, og representanter fra ulike land. Det var representanter fra høy, middels og lav-inntektsland samt fra folkehelse.
- Rapporten er for tilfellet distribuert for å innhente kommentarer og kan derfor ikke ennå refereres til som en standard.

Fordeler	Ulemper
☒ Det etableres en standardisert måte å dele inn sektoren i hovedprosesser	☐ Det er en prosessorientert måte å se verdiskaping på
☒ Det etableres en standardisert måte å organisere informasjon på	☐ Det er allerede besluttet på hvordan oppgaver skal fordeles mellom ulike aktører

Modeller utviklet for spesialisthelsetjenesten

Modell: Nasjonal IKT - Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

- Beskriver spesialisthelsetjenestens virksomhetsarkitektur. Arkitekturen skal:
 - Gi grunnlag for mer effektiv samhandling innen og mellom helseforetak spesielt og i helsesektoren generelt
 - Gi et forslag til overordnet inndeling i applikasjonsområder (gruppering av tjenester, funksjonalitet og data) for spesialisthelsetjenesten.
 - Identifisere og anvende standarder for grensesnitt mellom løsninger.
- Beskriver spesialisthelsetjenestenes overordnede tjenester og prosesser innen området forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Fordeler	Ulemper
☒ Har hatt bred involvering og forankring i IKT-miljøene i spesialisthelsetjenesten	☐ Lav gjenbruk av internasjonale standarder
	☐ Begrenset til spesialisthelsetjenesten

Modell: Helse Vest IKT Virksomhetsmodell

- For å gi økt støtte til arbeidet med strategisk planlegging og program- og porteføljestyling i Helse Vest, ble det utviklet en virksomhetsmodell som verktøy til dette arbeidet. Initiativet var tuftet på konseptet om Capability Based Planning, som beskrevet i arkitekturrammeverket TOGAF. Virksomhetsmodellen er bygget opp av kapabiliteter.

Fordeler	Ulemper
☒ Bruker beste praksis arkitekturartefakter	☐ Begrenset til spesialisthelsetjenesten
☒ Utarbeidet i Helse Sør-Øst, som del av Healthcare Delivery Framework. En arbeidsgruppe bestående av virksomhetsarkitekter og klinisk personell under veiledning av ekstern konsulent identifiserte i første omgang hvilke kapabiliteter som er nødvendige for å understøtte en pasientorientert syklus for helsetjenester.	
☒ Resultatet av arbeidet er bearbeidet og kvalitetssikret med en bredere referansegruppe, og etter ytterligere justeringer ble en første utgave av modellen tatt i bruk i forbindelse med vurderinger og prioriteringer av prosjektporteføljen for 2015 i Helse Vest.	

Modeller for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Gjennom kartleggingen har vi ikke funnet en kapabilitetsmodell som beskriver kommunal helse- og omsorgstjeneste. For å få tilstrekkelig grunnlag til å utvikle en generisk virksomhetsmodell har vi

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

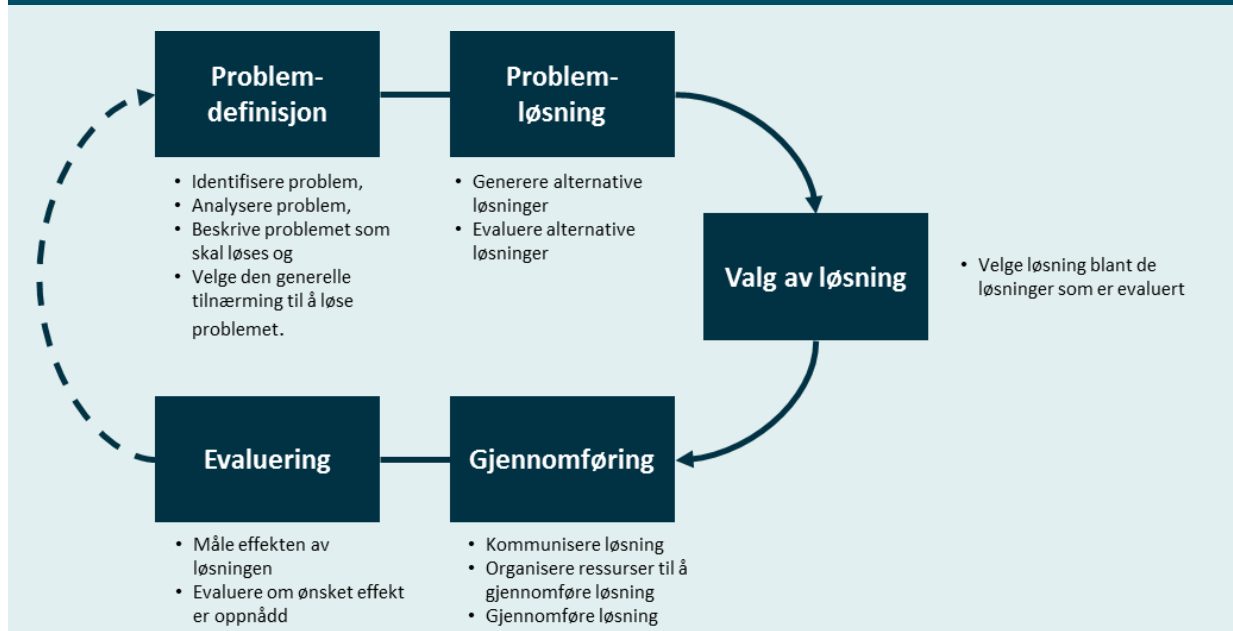
kartlagt tjenesteomfanget i en rekke utvalgte kommuner, samt tatt en gjennomgang av «International Classification of Health Interventions» (ICHI) fra WHO og «Klassifisering av sosialtjenstens insatser og aktiviteter» (KSI) fra Socialstyrelsen i Sverige. Klassifiseringen av disse tjenestene i kapabiliteter er kvalitetssikret gjennom gjennomgang i en bredere referansegruppe.

1.1.3 Modell for verdiskaping i helse- og omsorgssektoren

Virksomhetsmodellen beskriver på et konseptuelt nivå hvilken verdiskaping (effekt) en sektor skal realisere og hvilken verdikonfigurasjon (verdiskapende mekanismer) som understøtter verdiskapingen. Verdiskapende mekanismer er en kombinasjon av virksomhetskapabiliteter, strukturer og samhandlingsmodeller som til sammen realiserer de overordnede målene for en sektor.

Tradisjonelt er det blitt brukt prosessmodellering for å identifisere de overordnede verdiskapende mekanismene, og Michael Porters verdikjedeverk, beskrevet i *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* fra 1985, var lenge den eneste aksepterte modellen for å representere og analysere verdiskaping på virksomhets- eller sektornivå. I en verdikjede er den underliggende logikken at en rekke prosesser/aktiviteter er koblete i en kjede, der hver enkelt steg i kjeden verdiøker et produkt eller en tjeneste. Denne formen for verdiskapning er svært vanlig innen produksjonsvirksomheter, herunder alt fra bilbransjen til masseproduksjon av klær, husholdningsgjenstander mv. I en artikkel fra 1998 (2) ble det argumentert for at verdikjede som modell ikke var dekkende for å beskrive hvordan. Forfatterne argumenterte for at to nye modeller var nødvendige. En av disse modellene ble referert til som verdiverksted (value shop). I et verdiverksted er evnen til å forstå og definere enkelte problemer og sette sammen «skreddersydde» løsninger på problemene utfra et sett av mulige løsningskomponenter. Figur 1 gir en overordnet beskrivelse av de verdiskapende mekanismene i en virksomhet der virksomheten kan kjennetegnes som et verdiverksted.

Figur 1. Verdiskapende mekanismer i et verdiverksted

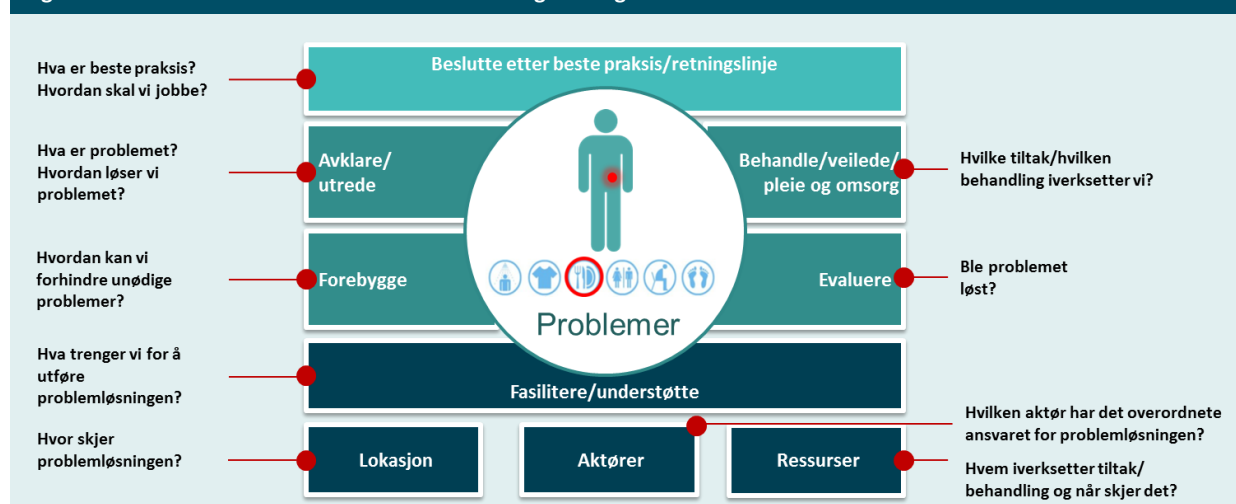


Det mangler internasjonal konsensus på hvordan man best modellerer helse- og omsorgstjenester. Mye kan tyde på at verdiverkstedmodellen kan være egnet som modell. Utgangspunktet for verdiskaping i helse- og omsorgstjenesten er tre typer problemer:

- Problemer knyttet til kroppen (patofysiologiske). Patofysiologiske problemer klassifiseres gjennom ICD-10. ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.
- Problemer knyttet til å håndtere daglige aktiviteter (funksjonsevne). Funksjonsevne blir definert ved å bruke ICF. ICF er en klassifikasjon som utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer.
- Problemer knyttet til sosiale relasjoner og psyke. Disse problemene klassifiseres gjennom ICD-10, men kan også klassifiseres gjennom DSM-V. DSM er den amerikanske psykiatriforeningens diagnosemanual for psykiatriske lidelser.

Med dette som utgangspunkt har vi valgt problemløsning som utgangspunkt for virksomhetsmodellen. Det betyr ikke at det ikke finnes prosesser innen helse- og omsorgstjenesten, men den grunnleggende verdiskapingen er å adressere helseproblemer. Vi har tilpasset de generiske verdiskapende mekanismene som er definert i definisjonen av verdiverksted til sektoren, se Figur 2.

Figur 2. Overordnet virksomhetsmodell for helse- og omsorgssektoren



På overordnet nivå er følgende verdiskapende mekanismer definert i virksomhetsmodellen:

Verdiskapende mekanisme	Beskrivelse
Avklare/utrede	Dette er tjenestens evne til å identifisere og avklare helseproblemer på individ- og gruppenivå.
Behandle/veilede/pleie og omsorg	Dette er tjenestens evne til å iverksette tiltak for å avhjelpe helseproblemer både på individnivå og gruppenivå.
Evaluere	Dette er tjenestens evne til å vurdere effekten av tiltak samt å bekrefte/avkrefte om problemet fortsatt er til stede (eller gir plager på et akseptabelt nivå).
Forebygge	Dette er tjenestens evne til å iverksette tiltak på individ- og gruppenivå med hensikt å hindre at uønskede problemer oppstår eller utvikler seg videre.
Beslutte etter beste praksis/retningslinje	Dette er tjenestens evne til å forvalte og utvikle kunnskap, samt å bruke beste medisinske praksis i å velge de til enhver tid beste tilgjengelige løsningene både på et individ- og gruppenivå.

Verdiskapende mekanisme	Beskrivelse
Fasilitere	Dette er tjenestens evne til å fasilitere problemløsningen. Dette innebærer blant annet at de riktige menneskelige ressursene med den riktige kompetansen, de riktige materielle ressursene og den riktige informasjonen er tilgjengelig på riktig lokasjon til riktig tid for å utføre de aktivitetene som er nødvendig for å avklare/diagnostisere, iverksette tiltak/behandle, evaluere eller forebygge.

Det skjer en kontinuerlig endring av helseproblemspanoramaet som skyldes at folk lever lenger samtidig som endringer i samfunn og levestett medfører endringer i helsebildet. Disse endringene går langsomt, men er synlige fra generasjon til generasjon. Endringer i medisinsk kunnskap og teknologi går vesentlig raskere og åpner muligheter for nye behandlingsopplegg og endring i måten helse- og omsorgstjenester kan leveres. Begge disse utviklingstrekkene krever kontinuerlig endringer i helse- og omsorgstjenesten og dens teknologi.

1.2 Overordnet virksomhetsmodell for helse- og omsorgssektoren

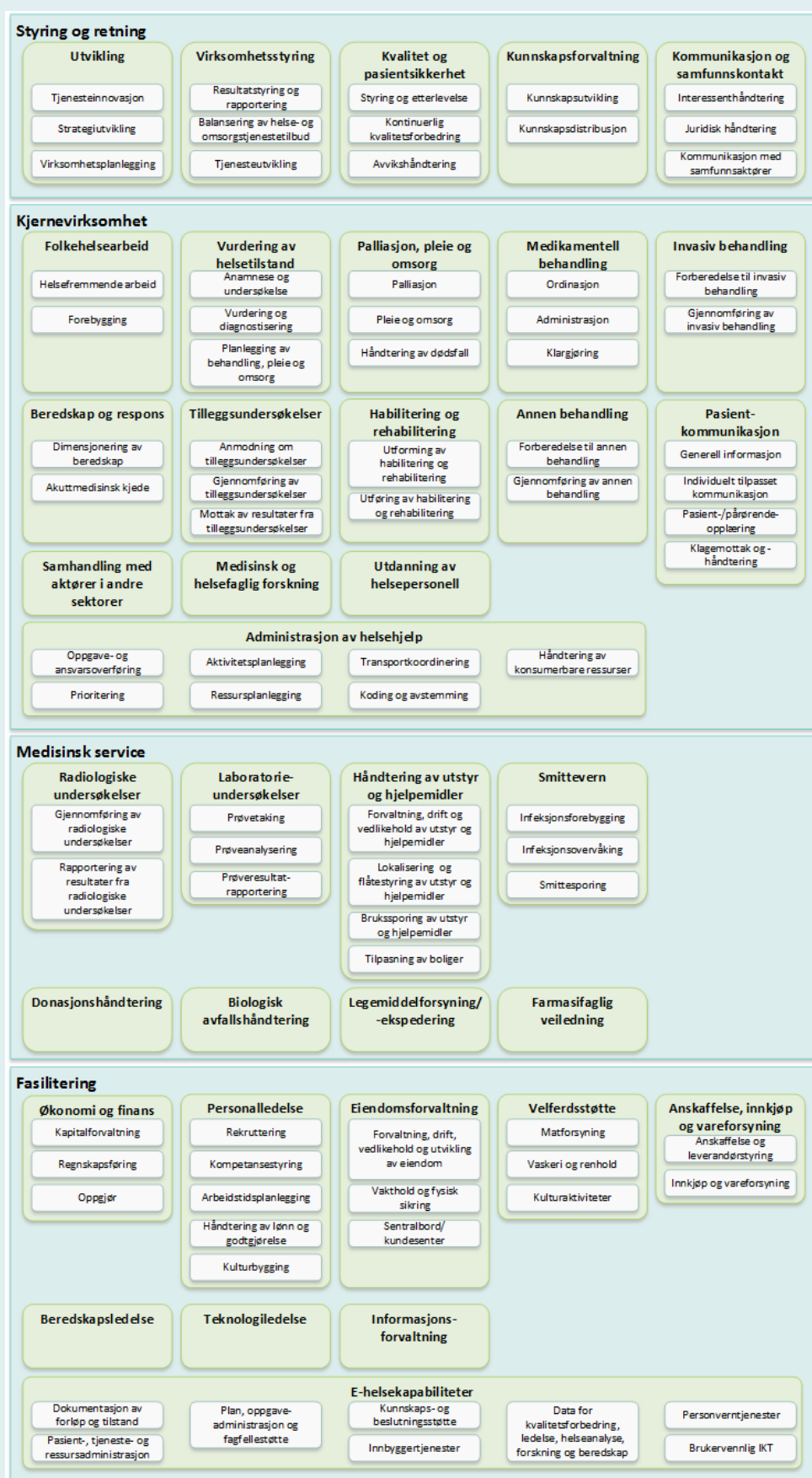
I dette avsnittet beskriver vi ordnet virksomhetsmodellen for helse- og omsorgssektoren. Modellen består av helse- og omsorgssektorens virksomhetskapabiliteter, presentert i kapittel 1.2.1 og detaljert i kapittel 1.2.2-1.2.5, helse- og omsorgssektorens tjenester, presentert i kapittel 0, samt helse- og omsorgssektorens aktører, presentert i kapittel 1.2.7.

1.2.1 Virksomhetskapabiliteter

Helse- og omsorgssektorens virksomhetskapabiliteter, presentert i Figur 3, er gruppert på bakgrunn av hvilken rolle de spiller i sektoren. Følgende grupper er definert:

- **Styring og retning.** Disse kapabilitetene responderer til interne og eksterne drivere, og gir rammer og retning for planlegging og endring slik at utvikling av helse- og omsorgstjenestene skjer innenfor og i tråd med disse.
- **Kjernevirksomhet.** Disse kapabilitetene er spesifikke for sektorens evne til å yte helsehjelp.
- **Medisinsk service.** Disse kapabilitetene er direkte muliggjørende for, og dermed tett knyttet til, kjernevirksomheten.
- **Fasilitering.** Disse kapabilitetene skal understøtte kjernevirksomheten og sikre en stabil og velfungerende daglig drift. Som det fremgår i de mer detaljerte beskrivelsene, er enkelte virksomhetskapabiliteter, som velferdsstøtte, plassert i denne grupperingen. Når det gjelder omsorgstjenester i kommunen er enkelte av disse kapabilitetene en del av primæroppgavene.

Figur 3. Virksomhetskapabiliteter



1.2.2 Definisjon: Styring og retning

Grupperingen styring og retning inneholder virksomhetskapabiliteter som er nødvendige for å kunne utnytte det politiske, teknologiske, kunnskapsmessige, finansielle og organisatoriske mulighetsrommet for å sikre innbyggerne best mulig helse- og omsorgstjenester.

Figur 4. Virksomhetskapabiliteter innen hovedområde Styring og retning



Utvikling

Evnen til å utvikle virksomhetene i sektoren for at innbyggerne skal sikres helse- og omsorgstjenester slik det er fastsett i lover og forskrifter, og detaljert i oppdragsdokument og proposisjoner.

Med helse- og omsorgstjenester menes de tjenester som ytes av private og offentlige institusjoner og virksomheter i samfunnet som har til formål å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom, å yte pleie og omsorg til syke mennesker eller å rehabilitere og utføre pasienter etter sykdom og skade.

Denne kapabiliteten kan deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Tjenesteinnovasjon.** Evnen til systematisk å innhente, frembringe og implementere nye ideer eller muligheter som skaper verdi for helsesektoren eller pasient og bruker. Dette kan være en ny eller forbedret vare, en tjeneste, en arbeidsprosess eller en organisasjonsform.
- **Strategiutvikling.** Evnen til å definere spesifikke mål og beskrive retning og prioritering for å nå disse. Dette inkluderer også evnen til å sette mål og handlingsplan i kontekst av eksterne og interne drivere, og sørge for fleksibilitet i henhold til dette.
- **Virksomhetsplanlegging.** Evnen til å planlegge organisasjonens arbeid i tråd med prioriteringer, mål og vedtatte rammer, samt å sørge for effektiv utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser. Dette inkluderer kapasitetsplanlegging i forhold til pasienter og brukergruppers behov, og budsjettering som en følge av dette.

Virksomhetsstyring

Evnen til å håndtere mekanismer, prosesser og relasjoner som kontrollerer og gir retning til virksomheten. Dette inkluderer styring i forhold til lover, regler og retningslinjer, styring av risiko, tjenestetilbud, resultat og prosjektportefølje, samt sørge for endringsledelse og realisering av gevinster.

Helse- og omsorgstjenesten beskrevne verdigrunnlag skal ligge i bunn for styring, planlegging og prioritering av helsehjelp. Verdierne rettferdighet, likeverdighet, lik tilgang til helse- og omsorgstjenester, åpenhet, kvalitet, brukermedvirkning, respekt for enkeltmennesket og nestekjærlighet skal ivaretas av alle deler av virksomheten.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Resultatstyring og rapportering.** Evnen til å definere, innhente, analysere og rapportere styringsdata som grunnlag for å sikre at virksomhetenes resultatmål nås. I dette inngår både utarbeiding av prognoser og myndighetsrapportering. Resultatstyring kan fokusere på resultatene til en organisasjon, organisasjonsenhet, prosesser og tjenester, så vel som til en individuell medarbeider. Måling basert på pasientopplevd kvalitet er også inkludert her.
- **Balansering av helse- og omsorgstjenestetilbud.** Evnen til å balansere virksomhetenes tjenestetilbud i henhold til samfunnets og befolkningens behov og krav til helse- og omsorgstjenester innen rammene for organisasjonens oppdrag. Dette omfatter også å endre oppgavefordelingen mellom ulike virksomheter.
- **Tjenesteutvikling.** Evnen til å implementere strategier gjennom programmer og prosjekter slik at virksomhetene kan nå sine mål. Dette omfatter også evnen til å håndtere drivkreftene, visjonene og prosessene som driver endringer i virksomheten, samt å sørge for at forventede gevinster av prosjekter eller endringstiltak blir realisert.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Evnen til å sikre et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud, satsning på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Styring og etterlevelse.** Evnen til å sikre og etterse at virksomheten har prosedyrer og rutiner som reflekterer gjeldende lover og forskrifter, prinsipper og retningslinjer. Omfatter evnen til å sørge for at dens medarbeidere vet om og følger disse prosedyrene. Dette gjelder også evnen å kunne fange opp avvik i behandling, pleie eller omsorg som er ytet.
- **Kontinuerlig kvalitetsforbedring.** Evnen til prosessledelse, utvikling og tjenesteutvikling i virksomheten og med samarbeidspartnere. Dette inkluderer evnen til å drive gjentakende evaluering og forbedring av behandlingsforløp, prosesser og prosedyrer, samt benchmarking mot andre tilsvarende organisasjoner eller beste praksis med formål om forbedring.
- **Avvikshåndtering.** Evnen til å kunne samle inn avvik, feil og uhensiktsmessigheter, klassifisere og analysere disse og sørge for tilbakemelding for justering av prosedyrer og rutiner og andre forhold for å redusere sannsynlighet eller konsekvens av oppståtte avvik.

Kunnskapsforvaltning

Evnen til å samle, dele og effektivt ta i bruk kunnskap. Inkludert i dette er en flerfaglig tilnærming for å oppnå organisatoriske mål ved best mulig bruk av den samlede kunnskapen i organisasjonen.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Kunnskapsutvikling.** Evnen til å utvikle retningslinjer og veiledere for beste medisinske praksis. Dette omfatter både kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte og prosessstøtte.
- **Kunnskapsdistribusjon.** Evnen til å distribuere felles beste medisinske praksis i hele helse- og omsorgssektoren.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Evnen til å håndtere interessenter og omdømmebygging til nåværende og fremtidig nytte.

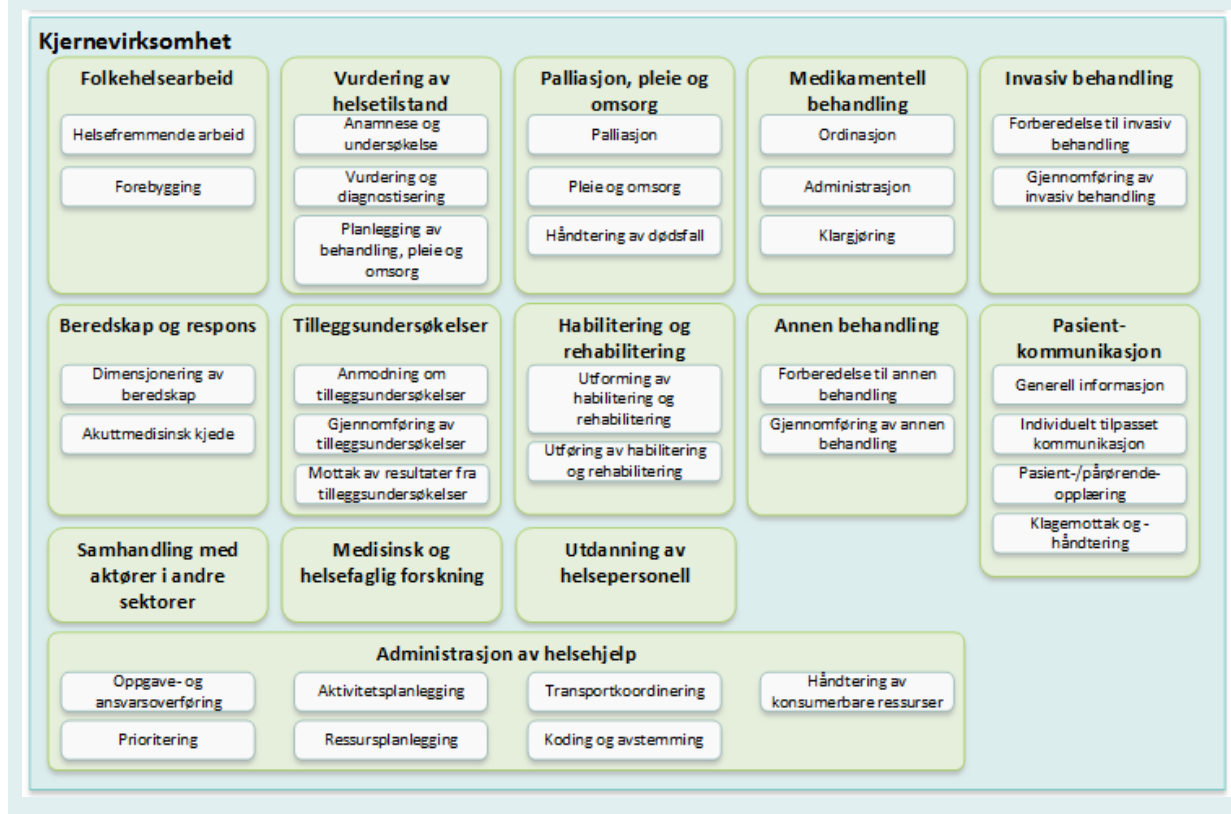
Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Interessenthåndtering.** Evnen til å håndtere forholdet mellom organisasjonen og dens interessenter. Interessenter kan eksempelvis være både interne (enheter, medarbeidere), pasienter og pårørende, samfunnet, foreninger og interessegrupper. Målet er å ta hensyn til og påvirke interessentenes holdning, beslutninger og handlinger for gjensidig nytte.
- **Juridisk håndtering.** Evnen til å håndtere alle juridiske aspekter. Dette omfatter å evaluere gjeldende regelverk med hensyn til hensiktsmessighet og utvikle nytt regelverk for å utnytte det mulighetsrom som foreligger teknologisk, finansielt og organisatorisk.
- **Kommunikasjon med samfunnsaktører.** Evnen til å sørge for informasjon til medarbeidere, ha kontakt med media og formidle kontakt mellom media og medarbeidere. Inkluderte i dette er håndtering av innkommende henvendelser gjennom ulike kanaler fra media, brukere og andre interessenter, og formidling av saker til ulike interessenter. Omdømmebygging, profilering og kommunikasjonsrådgivning er også viktige deler av kapabiliteten.

1.2.3 Definisjon: Kjernevirksomhet

Dette hovedområdet omfatter de virksomhetskapabiliteter som er nødvendige for å kunne yte den helsehjelpen som en innbygger har rett og behov for.

Figur 5. Virksomhetskapabiliteter innen hovedområde Kjernevirksomhet



Folkehelsearbeid

Evnen til å utvikle kunnskap, ferdigheter, forpliktelser, strukturer, systemer og lederskap for å muliggjøre eller støtte initiativer knyttet til folkehelse. Dette inkluderer evne til både å arbeide forebyggende og å håndtere folkesykdommer.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Helsefremmende arbeid.** Evnen til å fremme tiltak som styrker helsen, eksempelvis en sunn livsstil, ved å øke kunnskap og ferdigheter blant befolkningen, støtte helsefremmende arbeid i organisasjoner, og utvikle samhørighet og samarbeid om helse i lokalsamfunn.
- **Forebygging.** Evnen til å endre faktorer som truer helsen, eksempelvis gjennom tidlig diagnostisering, kartlegging og identifisering av risikogrupper for ulike sykdommer. Rådgivning og annen nødvendig intervensjon for å avverge et helseproblem er også virkemidler i dette arbeidet. Screening-undersøkelser, opplysningsarbeid om helse, og vaksineringsprogrammer er vanlige eksempler på forebyggende arbeid, men også kampanjer for mindre tobakksbruk. Forebygging deles ofte opp i tiltak som forhindrer sykdom å oppstå (primærforebygging), tiltak som begrenser allerede oppstått sykdom (sekundærforebygging) og rehabilitering (tertiærforebygging).

Vurdering av helsetilstand

Evnen til å innhente nødvendige informasjon om pasienten eller brukerens helsetilstand og totalsituasjon, vurdere denne, stille diagnose, planlegge og koordinere pleie, omsorg og behandling, samt evaluere effekter og resultat av igangsatte tiltak.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Anamnese og undersøkelse.** Evnen til å systematisk innhente informasjon om pasient eller bruker relevante til behandling, pleie og omsorg. Relevante opplysninger kan være pasientens oppfattelse av aktuell problemstilling og egen helse, sykehistorie, legemiddelbruk, livsstil, bosituasjon, pasientens egne målinger og observasjoner, spesielle behov, ønsker, ressurser og kunnskap. Inkludert er også evnen til å bestille og ev. utføre ulike typer diagnostiske undersøkelser, observasjoner, målinger (for eksempel blodtrykk, temperatur, blodsukker og EKG), tester eller tiltak, samt innhente vurderinger fra annet helsepersonell.
- **Vurdering og diagnostisering.** Evnen til å vurdere og sammenstille innhentede opplysninger om pasientens eller brukerens helsetilstand og totalsituasjon, beslutte eventuelle ytterligere diagnostiske tiltak, og fastsette foreløpig eller "endelig" diagnose eller beskrivelse av pasientens symptomer som grunnlag for å planlegge et behandlingsforløp i dialog med pasienten/brukeren. Evnen til å evaluere effekt og resultat av utførte tiltak vedrørende behandling, pleie og omsorg er også en del av dette.
- **Planlegging av behandling, pleie og omsorg.** Evnen til å utarbeide koordinerte planer for behandling, pleie og omsorg sammen med pasient eller bruker og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere/omsorgsnivå. Dette inkluderer evnen til å prioritere mellom pasientens ulike sykdommer eller skader, vurdere ulike behandlingsalternativer, veilede pasient eller bruker i valg mellom disse, samt gi informasjon til, og skape en god dialog med, pasient og pårørende. Kapabiliteten er viktig i alle iterasjoner av behandlingsplanlegging, og inkluderer evne til utarbeiding av plan for det enkelte behandlingsforløp, og planlegging av oppfølging og egenomsorg etter behandlingsforløpet.

Utredning av «En innbygger – én journal»

Palliasjon, pleie og omsorg

Evnen til å ta vare på og støtte pasienter og familier slik at de kan oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og livskvalitet. Dette betyr å støtte pasienter og familier som mangler ferdigheter, styrke, kunnskap eller vilje til å ivareta sine egne grunnleggende behov. Det skal også legges til rette for god symptomlindring og god terminalpleie og omsorg for alle pasienter.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Palliasjon.** Evnen til aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Disse prinsippene er anvendbare overfor alle pasienter med livstruende sykdom og kan anvendes tidlig i sykdomsforløpet. (3) (4)
- **Pleie og omsorg.** Evnen til å påse at pasientens/brukernes behov blir ivaretatt, eller å ivareta disse dersom pasienten/brukeren ikke er i stand til det selv. Det innebærer å utføre aktiv behandling, pleie og omsorg med utgangspunkt i pasientens helsetilstand og iverksette riktig behandlingsalternativ. Det innebærer evnen til problemprioritering, målsetting, valg av tiltak og utarbeiding av plan, samt evnen til å gjøre klart utstyr og nødvendig ressurser for pleie- og omsorgsaktivitetene. De fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle behovene skal ivaretas og målet med pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.
- **Håndtering av dødsfall.** Evnen til håndtering av den avdøde, samt de etterlatte. Evne til å utarbeide dødsattest og melde dødsfall til nasjonale registre som dødsårsaksregister og folkeregisteret.

Medikamentell behandling

Evnen til å løse eller begrense et helseproblem med legemidler som behandling. Behandling i hjemmet og på institusjon er inkludert. Evnen forutsetter en legemiddelsløyfe som er en prosess som løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via produksjon og forsyning, klargjøring og administrering av legemiddelet, frem til evaluering av effekt.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Ordinasjon.** Ordinasjon er den delen av legemiddelsløyfen der en rekvirent tar stilling til hvilke legemidler pasienten skal behandles med, og rekvirenten gjennomfører selve ordineringen. Dette er en formell beslutning om og bestilling av legemiddelutdeling. Rekvirenten har det endelige ansvaret for hvilke legemidler som blir ordinert til en pasient. I denne kapabiliteten ligger også evnen til å endre, pause og avslutte (seponere) en ordinasjon.
- **Klargjøring.** Klargjøring, eller istandgjøring, er den delen av legemiddelsløyfen der legemidler blir gjort i stand til den enkelte pasient, eller at standardpakker blir klargjort til for eksempel operasjon. Med dette menes blanding av infusjoner, opptrekk i sprøyter mv. Andre eksempler er pakking av multidose. Legemiddelforsyning er beskrevet i kapittel 1.2.4.
- **Administrasjon.** Administrering er den delen av legemiddelsløyfen der legemidler mottas av pasient via ulike administrasjonsveier. Administreringen kan dokumenteres detaljert per

dose legemiddel eller mer overordnet. Administrering kan utføres av helsepersonell slik som på institusjon eller i hjemmesykepleien, men vanligst er at pasient administrerer legemidler selv i hjemmet.

Invasiv behandling

Evnen til å løse eller begrense et helseproblem ved hjelp av kirurgi, på andre måter perforere hud, eller benytte spesielle prosedyrer som kateterisering, endoskopi, laparoskopi. Behandling i hjemmet er også inkludert.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Forberedelse til invasiv behandling.** Evnen til å sikre at nødvendig utstyr og alle nødvendige ressurser er klargjort for bruk i invasiv behandling. Dette inkluderer evnen til å sikre forberedning og iscenesettelse av nødvendige materialer i forkant av den kliniske prosedyren.
- **Gjennomføring av invasiv behandling.** Evnen til å utføre invasive aktiviteter i behandlingsplanen avtalt mellom behandler og pasient.

Beredskap og respons

Evnen til å kunne opprette beredskapsplaner og respondere på akutte hendelser.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Dimensjonering av beredskap.** Evnen til å kunne utarbeide nødvendige beredskapsplaner, samt å kunne dimensjonere beredskapsteam. Dette omfatter både de nasjonale beredskapsplanene og virksomhetenes egne beredskapsplaner. I tillegg omfatter dette den løpende beredskapen for situasjoner som er avhengig av øyeblikkelig hjelp (legevakt, akuttmottak).
- **Akuttmedisinsk kjede.** Evnen til aktører med plikt å yte øyeblikkelig hjelp til å kunne motta, utrede, behandle eller yte omsorg til de innbyggere som har behov for dette.

Tilleggsundersøkelser

Evnen til å kunne anmode (henvise til, rekvirere, søke) om tilleggsundersøkelser fra helsepersonell som ikke er en del av det team som har ansvaret for pasienten.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Anmodning om tilleggsundersøkelser.** Evnen til å kunne henvise til, rekvirere eller søke om tilleggsundersøkelser som er vurdert som nødvendige for å kunne foreta endelig evaluering og diagnostisering.
- **Gjennomføring av tilleggsundersøkelser.** Evnen til å kunne gjennomføre tilleggsundersøkelser. Dette er i mange tilfeller å involvere en spesialist som da foretar egen undersøkelse, men kan også innebære iverksettelse av virksomhetskapabiliteter under medisinsk service (jf. kapittel 1.2.4).
- **Mottak av resultater fra tilleggsundersøkelser.** Evnen til å kunne motta resultater og sørge for at alle resultater blir sett og eventuelt håndtert.

Habilitering og rehabilitering

Evnen til å tilby tidsavgrensede, planlagte tjenester satt sammen til en helhet med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet (5). Brukermedvirkningen skal være optimal og tilpasset den enkeltes forutsetninger. Tjenester fra ulike fag og sektorer må ses i sammenheng og bidra til å realisere brukers mål.

Selve aktivitetene i habilitering/rehabilitering vil være overlappende med aktiviteter i de andre behandlingskapabilitetene samt pleie- og omsorgskapabiliteten. Ulikheten ligger i et særegent fokus på pasient eller brukers egenaktiviteter og egenomsorg, og samhandling over faggrenser, omsorgsnivå eller andre tjenester fra det offentlige. I tillegg skal habilitering og rehabilitering forstås som flere tjenester satt sammen til en helhet. (6)

Habilitering:

Å redusere konsekvensene av medfødt eller tidlig ervervet helseproblem.

Rehabilitering:

Å redusere konsekvensene av helseproblem som har oppstått etter normalutvikling.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Utforming av habilitering og rehabilitering.** Evnen til å sikre at pasient eller bruker og alle nødvendige ressurser og ev. utstyr, er forberedt og klargjort for gjennomføring av habilitering og rehabilitering.
- **Utføring av habilitering og rehabilitering.** Evnen til å medvirke i rehabiliteringsaktiviteter eller habiliteringsaktiviteter etter plan.

Annen behandling

Evnen til å løse eller begrense et helseproblem gjennom behandling som ikke er medikamentell eller invasiv. Behandling i hjemmet er også inkludert. Eksempler på annen behandling er miljøterapi, stråleterapi, livsstilsendringer, diett, fysisk terapi, samtaleterapi, kognitiv terapi og ergoterapi.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Forberedelse til annen behandling.** Evnen til å sikre at alt nødvendig utstyr og alle nødvendige ressurser er forberedt og klargjort for bruk i behandlingsøyemed. Dette innbefatter evnen til å sikre iscenesettelse av nødvendige ressurser og/eller utstyr i forkant av behandlingsstart.
- **Gjennomføring av annen behandling.** Evnen til å utføre andre aktiviteter i behandlingsplanen avtalt mellom behandler og pasient.

Pasientkommunikasjon

Evnen til å tilby pasienter og deres pårørende informasjon og kunnskap for å kunne medvirke og ta eierskap til egen helse, samt for å kunne ha en forutsigbar og tilgjengelig relasjon med aktørene i helse- og omsorgstjenesten.

Denne kapabiliteten deles opp i fire underkapabiliteter:

- **Generell kommunikasjon.** Evnen til å gi innbyggerne tilgang til kvalitetssikret og oppdatert informasjon om ulike diagnoser, deres rettigheter og hvordan forholde seg til helse- og

omsorgstjenesten. Dette omfatter også muligheten til å kunne administrere sitt forhold til helse- og omsorgstjenesten (bestilling av timer, valg av behandlingssted mv.).

- **Individuelt tilpasset kommunikasjon.** Evnen til å gi innbyggere tilgang til tilpasset informasjon og tjenester tilpassede innbyggerens egen situasjon. Dette omfatter også støtte til å ta egne beslutninger, samt å selv kunne registrere informasjon.
- **Pasient-/pårørendeopplæring.** Evnen til å gi pasient og pårørende kunnskap og ferdigheter til mestring av langvarig sykdom og helseforandringer. Pasienten er medvirkende med sin erfaring og forståelse for egen situasjon og det skal brukes arbeidsformer som stimulerer til økt selvstendighet og fokus på ressursene hos pasienten/brukeren.
- **Klagemottak og -håndtering.** Evnen til å gi innbyggerne mulighet til å klage på de tjenester helse- omsorgstjenesten yter i tråd med rettigheten nedfelt i lover og regler.

Samhandling med aktører i andre sektorer

Evnen til å kunne samhandle med aktører i andre sektorer i forbindelse med tjenester som ytes til en individuell innbygger. Dette omfatter for eksempel barnevern, skole, barnehage, PP-tjenesten, NAV (bl.a. hjelpemidler, sykefravær, arbeidsevnevurdering), Folkeregisteret, Kreftregisteret og andre sentrale helseregistre, arbeidsgiver, politi, UDI, forsikringsselskaper.

Medisinsk og helsefaglig forskning

Evnen til å frembringe ny kunnskap om helse og sykdom gjennom vitenskapelig metodikk som grunnlag for forbedring av diagnostisering, behandling og pleie av pasienter. Evnen omfatter muligheten til å gjennomføre kliniske studier, inkludert rekruttering av pasienter, blinding m.m. Evnen resulterer i publikasjoner og doktorgrader.

Utdanning av helsepersonell

Evnen til å sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes. I tillegg skal ansatt helsepersonell gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig.

Administrasjon av helsehjelp

Evnen til å håndtere den administrative delen av å tilby helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer all form for kontakthåndtering, prioritering og planlegging av aktiviteter og ressurser knyttet til diagnostisering og behandling, samt forvaltning av helseinformasjon og ferdigstilling av grunnlag for økonomisk oppgjør og aktivitetsrapportering.

Denne kapabiliteten deles opp i syv underkapabiliteter:

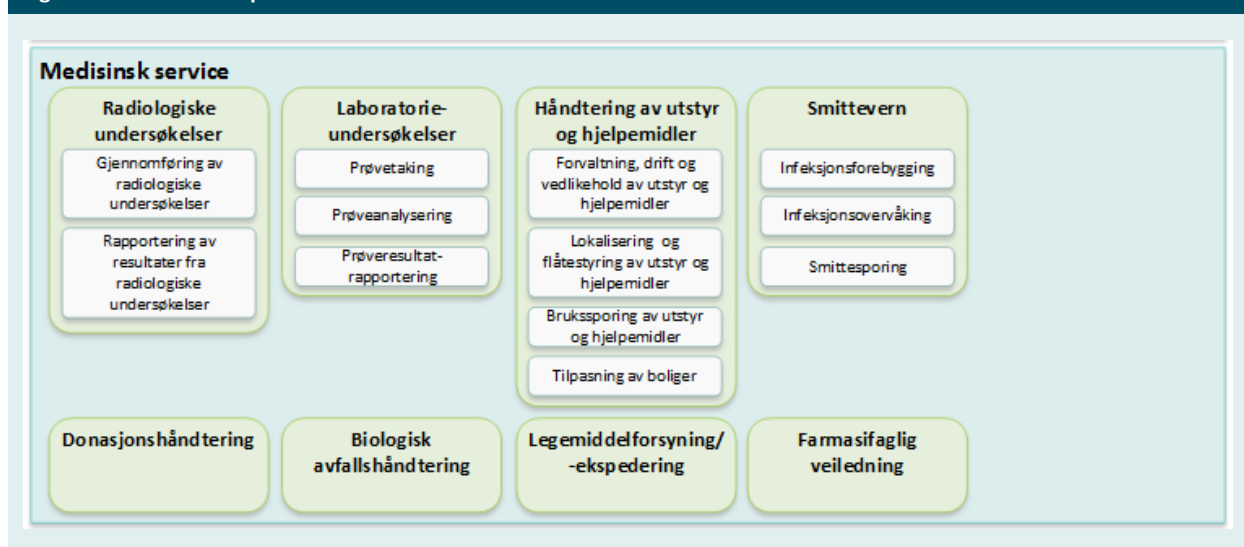
- **Oppgave- og ansvarsoverføring.** Evnen for helsepersonell til å effektivt kunne overføre oppgaver og ansvar mellom hverandre. Dette foregår i dag gjennom epikriser, sammenfatninger, henvisninger, rekvisisjoner, søknader med etterfølgende saksbehandling og eventuelle vedtak, samt andre ordinære meldinger på ulike media.
- **Prioritering.** Evnen til å utføre prioritering ut fra hastegrad, rettigheter og kapasitet. Dette inkluderer også prioritering mellom pasienter og prioritering mellom ulike pasientgrupper (sykdomsgrupper). Denne kapabiliteten er en essensiell del av prosess for vurderinger av søknader, henvisninger og håndtering av ventelister.

- **Aktivitetsplanlegging.** Evnen til å planlegge den individuelle pasient sine aktiviteter, inkludert
 - Avtaler: dato, tid, sted og helsepersonell, og pasient for kontakt/konsultasjon
 - Undersøkelser: dato, tid, sted, og nødvendige ressurser (mennesker, utstyr, kapasitet) for å gjennomføre en spesifikk undersøkelse
 - Innleggelse, overføring og utskrivning
 - Mottak av pleie- og omsorgstjenester i hjemmet
 - Behandling: dato, tid, sted og nødvendige ressurser (mennesker, utstyr, rom, annet utstyr) som er nødvendig for å gjennomføre kirurgisk eller terapeutisk behandling
 - Koordinering og kommunikasjon med pasient og pårørende.
- **Ressursplanlegging.** Evnen til å fordele personell, arealer og utstyr i forhold til planlagt aktivitetsnivå og tilgjengelig kapasitet.
- **Transportkoordinering.** Evne til å tilby innbyggere som har rett til det, transport til og fra hjemmet og mellom behandlingssteder, enten ved å tilby dekning av utgifter eller ved å bistå med egnet transport. Kapabiliteten handler om å bestille transport av riktig type til riktig sted. Transporttjenestene som bestilles kan være både interne og eksterne, og det kan innebære til dels mye koordinering på tvers av ulike transportleverandører.
- **Koding og avstemming.** Evnen til å sørge for riktig koding og relevant informasjon om diagnoser og utført helsehjelp. Informasjonen benyttes til rapportering og fakturering, og kapabiliteten dekker også evnen til å identifisere, analysere og håndtere avvik mellom planlagte og faktiske resultater.
- **Håndtering av konsumerbare ressurser.** Evnen om å kunne bestille og forsyne ressurser som forbrukes, altså ressurser som bare kan brukes én gang, slik som sprøyter, kompresser mv. En ressurs som er spesielt tilpasset til en enkelt pasient regnes også som konsumerbar, for eksempel proteser. De kan bare brukes én gang, for én pasient, men den kan likevel være i bruk av pasienten over en lang periode.

1.2.4 Definisjon: Medisinsk service

Dette hovedområdet definerer virksomhetskapabiliteter som er direkte muliggjørende for, og dermed tett knyttet til, kjernevirksomheten.

Figur 6. Virksomhetskapabiliteter innen hovedområde Medisinsk service



Radiologiske undersøkelser

Evnen til å høste, prosessere, og rapportere klinisk informasjon gjennom bruk av bildeteknologi for å få informasjon om helsen til en pasient i forbindelse med diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom eller skade. Dette omfatter bruk av røntgenstråler, ultralyd eller magnetresonans i diagnostikk og behandling.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Gjennomføring av radiologiske undersøkelser.** Evnen til å fange og lagre bilder av menneskekroppen, eller deler av denne, for kliniske formål, samt prosessere og evaluere bilder i sammenheng med annen klinisk informasjon.
- **Rapportering av resultater fra radiologiske undersøkelser.** Evnen til å presentere og gi råd i forhold til resultatet av analysen av bildeinformasjon, med henvisninger til kilde og annen klinisk informasjon, for helsepersonell og/eller pasient eller pårørende.

Laboratorieundersøkelser

Evnen til å ta prøver og utføre analyser på disse for å få informasjon om helsen til en pasient i forbindelse med diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom eller skade. Dette omfatter medisinsk biokjemiske, patologiske og mikrobiologiske undersøkelser.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Prøvetaking.** Evnen til å utføre innsamling av prøver i henhold til en definert prosedyre.
- **Prøveanalysering.** Evnen til å utføre og evaluere analyser av prøver for å få informasjon om helsen til en pasient ved bruk av standardiserte metoder.
- **Prøveresultatrapportering.** Evnen til å presentere resultatet av analysene og gi råd til helsepersonell og/eller pasient eller pårørende slik at de kan brukes korrekt til diagnostikk, oppfølging eller behandling.

Håndtering av utstyr og hjelpemidler

Evnen til å planlegge anskaffelse og vedlikehold av, identifisere, vedlikeholde, teste og avhende medisinsk, medisinsk-teknisk og ikke-medisinsk utstyr og hjelpemidler.

Denne kapabiliteten deles opp i fire underkapabiliteter:

- **Forvaltning, drift og vedlikehold av utstyr og hjelpemidler.** Evnen til å planlegge anskaffelse og vedlikehold av, kontrollere, overvåke, teste, vedlikeholde og avhende medisinsk, medisinsk-teknisk og ikke-medisinsk utstyr og hjelpemidler.
- **Lokalisering og flåtestyring av utstyr og hjelpemidler.** Evnen til å stedfeste fysisk hvor medisinsk, medisinsk-teknisk og ikke-medisinsk utstyr og hjelpemidler til enhver tid befinner seg.
- **Brukssporing av utstyr og hjelpemidler.** Evnen til å logge bruk av medisinsk, medisinsk-teknisk og ikke-medisinsk utstyr og hjelpemidler, samt å gjenfinne informasjon om dette.
- **Tilpasning av boliger.** Evnen til å klargjøre hjem eller boliger for å kunne tilby pasienter best mulig livskvalitet og sikkerhet.

Smittevern

Evnen til å forebygge, overvåke og begrense forekomsten av infeksjoner i helse- og omsorgstjenesten.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Infeksjonsforebygging.**
 - Utstyssterilisering: Evnen til å sikre at utstyr og rom ikke inneholder mikroorganismer, inkludert bakterielle sporer.
 - Isolasjonshåndtering: Evnen til å unngå spredning av smittsomme sykdommer mellom en pasient og andre pasienter, helsearbeidere eller besøkende.
 - Hygienehåndtering: Evnen til å etablere og opprettholde forhold eller praksiser som bidrar til helse, og for å forebygge infeksjoner.
- **Infeksjonsovervåking.** Evnen til å kunne melde allmennfarlige smittsomme sykdommer (slik definert i Smittevernloven) til Folkehelseinstituttet, samt melde om sykdommer oppstått under eller som følge av behandling på sykehus (NOIS).
- **Smittesporing.** Evnen til å identifisere smitteutsatte innbyggere for kontroll eller behandling, finne årsak til utbrudd av smittsomme sykdommer der det er relevant, og varsle aktuelle instanser.

Donasjonshåndtering

Evnen til å håndtere donasjon av biologisk materiale fra en levende eller død person til en levende mottaker. Dette inkluderer dokumentasjon og sporing av hvem som har gitt hva til hvem, eksempelvis ved blodoverføring eller donasjon av morsmelk, sæd eller organer.

Biologisk avfallshåndtering

Evnen til å oppbevare, behandle og destruere organer, deler av organer, væsker, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker på en forsvarlig måte.

Legemiddelforsyning og ekspedering

Legemiddelforsyning/-ekspedering er den delen av legemiddelsløyfen der en bestilling av legemidler blir mottatt og behandlet på apotek eller hos grossist, og hvor legemidlene blir sluttpakket, merket og fraktet fra apoteket til post/legemiddelrom/legemiddeltralle/legemiddelkabinett eller til vaktentral eller pasient. Det vanligste er at pasienten selv anskaffer legemidler på apotek.

Evnen omfatter kontroll av forbruk og restlager, etterbestilling for å ha tilstrekkelig lager og håndtering av beredskapslager med tanke på eventuelle masseskader eller pandemier.

Det er i hovedsak farmasøytisk industri som produserer legemidler, men utvalgte legemidler produseres lokalt i apotek. Denne evnen omfatter begge deler.

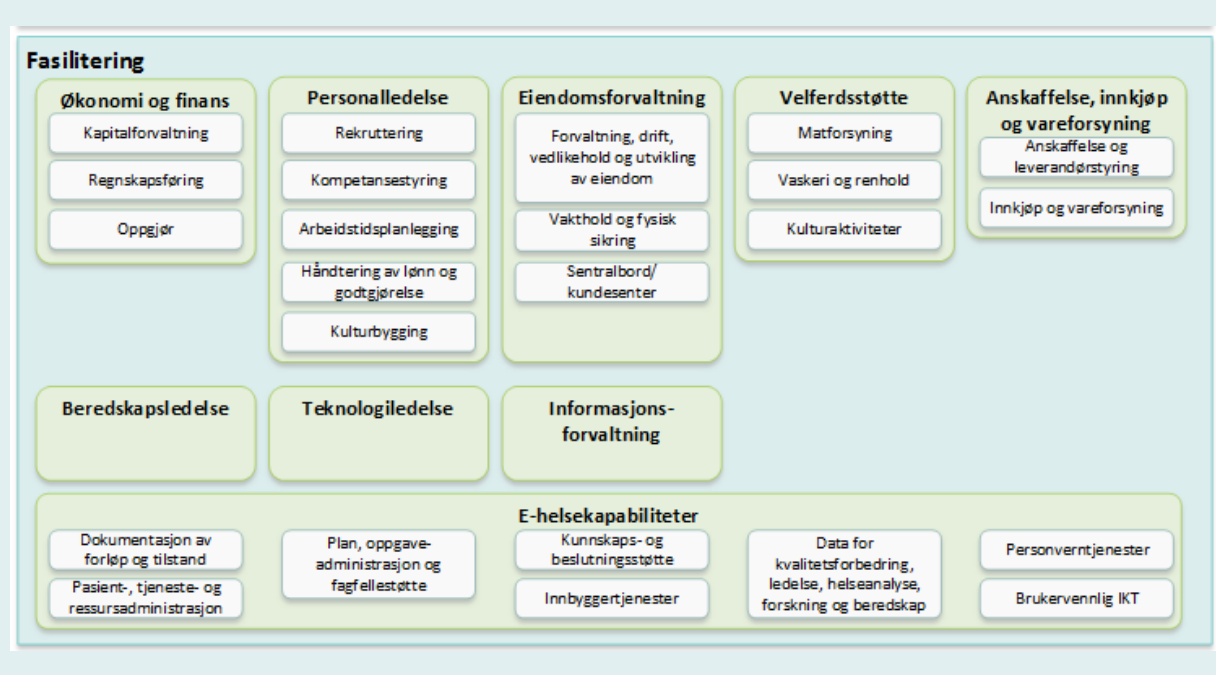
Farmasifaglig veiledning

Evnen til å gi råd og veiledning til pasienter og helsepersonell i bruk av legemidler. Dette for å bidra til økt pasientsikkerhet gjennom å legge til rette for god kvalitet i alle ledd av legemiddelhåndteringen og behandling med legemidler.

1.2.5 Definisjon: Fasilitering

Dette hovedområdet omfatter de fysiske virksomhetskapabiliteter som må på plass for å kunne drive en helsestasjon, et sykehus, en poliklinikk, et legekontor, en institusjon, eller å yte helse- og omsorgstjenester i hjemmet/omsorgsbolig. I tillegg omhandler området virksomhetskapabiliteter som omhandler økonomi, finans og personalledelse.

Figur 7. Virksomhetskapabiliteter innen hovedområde Fasilitering



Økonomi og finans

Evnen til å håndtere økonomiske beslutninger gjennom forvaltning av kapital og styring av regnskap og økonomisk rapportering.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Kapitalforvaltning.** Evnen til aktivt å forvalte virksomhetens finansielle eiendeler, inkludert håndtering av lån. På engelsk benyttes vanligvis begrepet (financial) asset management.
- **Regnskapsføring.** Evnen til å registrere og postere transaksjoner, utføre interne revisjoner, og gi råd i skattespørsmål. Inkludert i dette er håndtering av leverandørgjeld (accounts payable) og kundefordringer (accounts receivable).
- **Oppgjør.** Evnen til å sende refusjonskrav med tilhørende dokumentasjon og motta utbetalingsvedtak. Refusjonskrav kan opprettes, endres og slettes. Evne til å håndtere pasienters egenandel/-betaling for tjenester og utstyr.

Personalledelse

Evnen til å rekruttere, sikre kompetanse, følge opp, evaluere og belønne medarbeidere, bygge organisasjonskultur, samt føre tilsyn over organisatorisk ledelse og sikre etterlevelse av lover og regler for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Denne kapabiliteten deles opp i fem underkapabiliteter:

- **Rekruttering.** Evnen til å tiltrekke seg, velge ut og ansette kvalifisert personell.
- **Kompetansestyring.** Evnen til å sørge for at virksomhetens medarbeidere, både individuelt og samlet, har riktige og tilstrekkelige ferdigheter og kunnskap til å dekke virksomhetens behov i forhold til de oppgaver som må gjøres for å nå dens mål.
- **Arbeidstidsplanlegging.** Evnen til å utarbeide aktivitets-, bemannings-, og arbeidsplaner for turnus som samlet gir et best mulig tjenestetilbud til pasienter og brukere og samtidig ivaretar den enkelte medarbeiders livssituasjon og behov på en best mulig måte.
- **Håndtering av lønn og godtgjørelse.** Evnen til å kompensere medarbeidere for tjenesten de utfører for arbeidsgiver.
- **Kulturbygging og arbeidsmiljø.** Evnen til systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten. Evnen til å påvirke medarbeideres handlinger og valg gjennom aktivt arbeid med verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som preger virksomheten.

Eiendomsforvaltning

Evnen til å utvikle, opprettholde og legge til rette de fysiske elementene av arbeidsplasser slik at disse støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter. Deler av de fysiske tjenestene som er pasientrettede omhandles i kapabiliteten Velferdsstøtte.

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.** Evnen til å ivareta nødvendige aktiviteter i byggets levetid: Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service. Inkludert i dette er leietakeradministrasjon, herunder evnen til å inneha oversikt over samtlige tilgjengelige arealer og styre bruk og disponering av disse, og annet administrativt ansvar, sørge for at bygningen med tekniske installasjoner fungerer som planlagt, opprettholde kvaliteten på bygg/eiendom og tekniske installasjoner innen gitt levetid, håndtere ombygginger og oppgraderinger for å holde bygg/eiendom i takt med brukernes behov og realisere dets/dens potensiale, herunder:
 - Avfallshåndtering. Evnen til å sikre at avfall tas hånd om på en forskriftsmessig måte i forhold til kildesortering til gjenvinning, forbrenning, eller på annen måte forsvarlig avhending.
 - Energiforsyning
 - Vann-, ventilasjons- og avløpshåndtering. Evnen til å forsyne brukere av eiendom med tilfredsstillende vann-, ventilasjon- og sanitæranlegg og tjenester.
- **Vakthold og fysisk sikring.** Evnen til å sørge for at ikke uvedkommende har tilgang til bygg, installasjoner eller eiendom, samt sikring mot brann og eventuelle andre faktorer som kan føre til skade på eller ødeleggelse av bygg, installasjon eller eiendom.
- **Sentralbord/kundesenter.** Evnen til å håndtere henvendelser som er relatert til Fasilitetsstyring, eventuelt rute henvendelsen videre til riktig person eller instans.

Velferdsstøtte

Evnen til å tilby pasienter og pårørende kultur- og velferdstjenester på sykehuset, sykehjem eller i hjemmet for å sikre best mulig livskvalitet, samt rådgivning og støtte til pasienter og pårørende vedrørende deres rettigheter i forhold til helserelatert livssituasjon.

Uttredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Denne kapabiliteten deles opp i tre underkapabiliteter:

- **Matforsyning.** Evnen til å produsere og servere mat til pasienter, pårørende og medarbeidere. Inkludert i dette er også å sørge for riktig tilpasset mat. Kantinedrift omfattes også.
- **Vaskeri og renhold.** Evnen til å vaske tekstiler og gjennomføre renhold av bygg (sykehjem og sykehus) og hjem for de pasienter som har behov for det. Dette inkluderer vask av sengetøy, pasienttøy, personaltøy, dyner, puter og gardiner.
- **Kulturaktiviteter.** Evnen til å tilby pasienter og pårørende kulturaktiviteter.

Anskaffelse, innkjøp og vareforsyning

Evnen til å anskaffe og levere varer og tjenester, samt å forvalte leverandørkontrakter i tråd med virksomhetens behov.

Denne kapabiliteten deles opp i to underkapabiliteter:

- **Anskaffelse og leverandørstyring.** Evnen til å sikre at alle leverandørkontrakter støtter virksomhetens behov, og at alle leverandører oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser. Inkludert i dette er all kontraktsforvaltning (fornyinger, endringer, oppsigelser).
- **Innkjøp og vareforsyning.** Evnen til å kjøpe varer og tjenester som kreves i organisasjonen, inkludert all planlegging, innkjøp, varemottak, lagerstyring, og utlevering.

Beredskapsledelse

Evnen til å sikre at organisasjonens kritiske funksjoner enten vil fortsette å fungere på tross av alvorlige hendelser eller ulykker som ellers ville ha forstyrret dem, eller vil bli gjenopprettet til en forsvarlig driftstilstand innen rimelig tid.

Teknologiledelse

Evnen til å planlegge, utvikle, drifte og forvalte infrastruktur og løsninger for IKT, telekommunikasjon, signal og video slik at disse bidrar til kvalitet og effektivitet i kjernevirksomheten og tilhørende arbeid. Dette inkluderer også håndtering av teknisk sikkerhet.

Informasjonsforvaltning

Evnen til å spesifisere beslutningsmyndighet og et rammeverk for å sikre hensiktsmessig atferd i verdsettelsen, oppretting, lagring, bruk, arkivering og sletting av informasjon. Det inkluderer prosesser, roller og retningslinjer, standarder og målinger som sikrer effektiv bruk av informasjon i virksomheten for å realisere virksomhetens mål.

Dette inkluderer også tilrettelegging av data til analyse og rapportering. Sikring av informasjon (informasjonssikkerhet – tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet) er omfattet av dette.

E-helsekapabiliteter

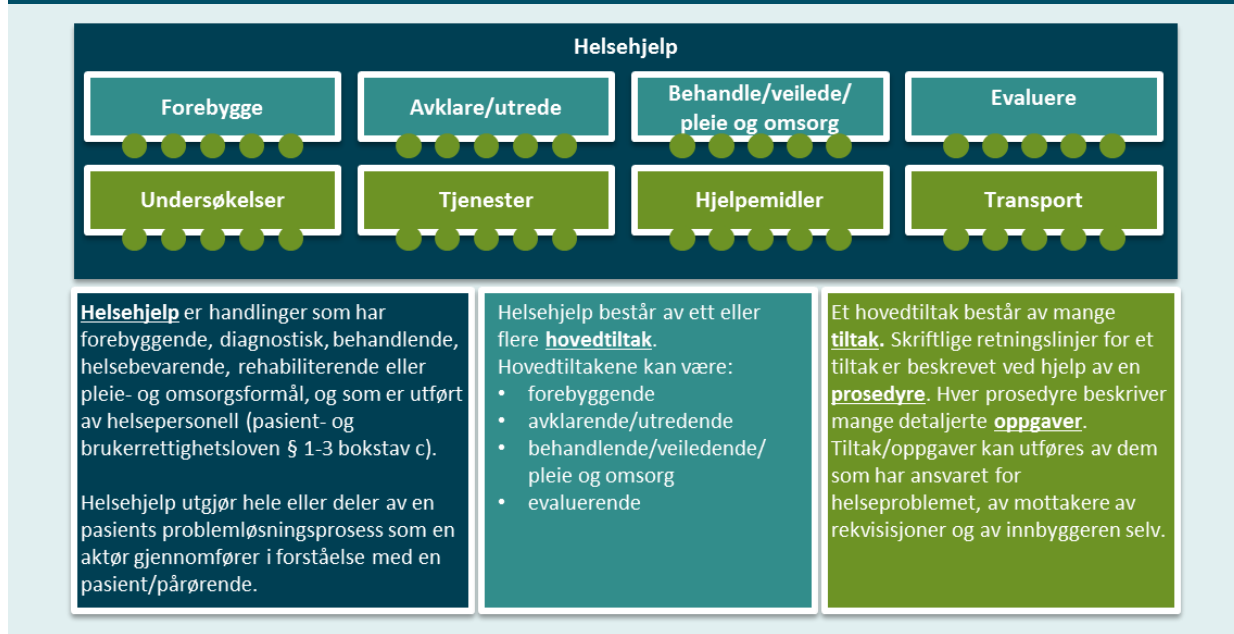
E-helsekapabilitetene er beskrevet i kapittel 2.

1.2.6 Tjenester i helse- og omsorgssektoren

Tjenestebegrepet

En tjeneste i helse- og omsorgssektoren dekkes av definisjonen av helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c: *Handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell.* Dette omfatter de fleste virksomhetskapabilitetene innen hovedområdene *Kjernevirksomhet* og *Medisinsk service*.

Figur 8. Begreper for helse- og omsorgstjenester



Hovedtiltak, tiltak og oppgaver (jf. Figur 8) er tjenester som er definert på ulikt detaljeringsnivå og kan være koblet mot spesifikke problemstillinger. Disse danner grunnlaget for aktørenes tjenestekataloger og -kalendre. En definert tjeneste utgjør hele eller deler av et standardisert behandlingsforløp, som er en normativ beskrivelse av et planlagt og forventet behandlingsforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater (7). Når en spesifikk tjeneste til et spesifikt tidspunkt tildeles en spesifikk pasient, kalles det en avtale.

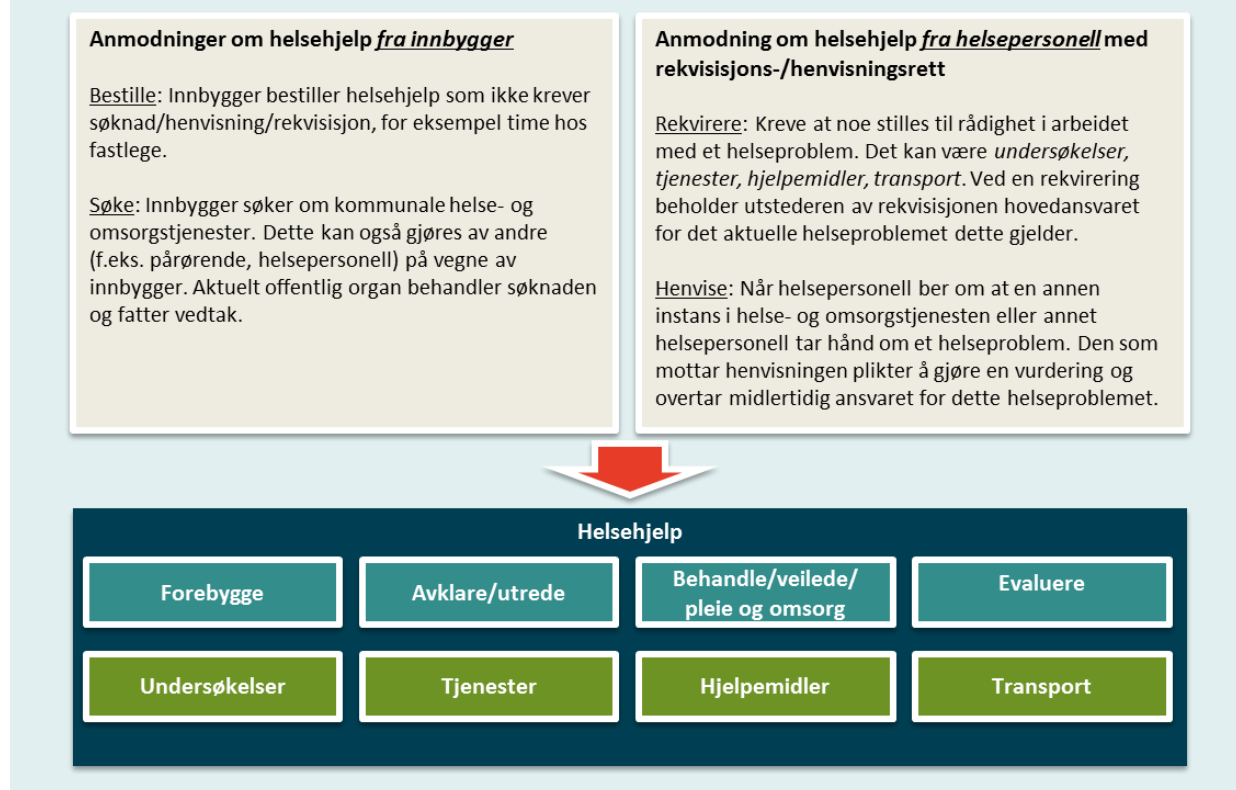
Anmodningsformer

Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven, skal helsehjelp, av hensyn til pasienten og riktig bruk av offentlige ressurser, i størst mulig grad ytes på laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Det innebærer blant annet at helsehjelp som ikke krever tilgang til spesialisthelsetjenestens spesielle kompetanse ideelt sett bør gis av den kommunale helsetjenesten. (8)

Spesialisthelsetjenesten skal sørge for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager. En stor andel av pasientene i spesialisthelsetjenesten har behov for øyeblikkelig hjelp og mottar direkte behandling uten å ha vært innom den kommunale førstelinjen. Elektiv behandling skjer hovedsakelig gjennom henvisning, som oftest fra fastlegetjenesten.

For å få utført helse- og omsorgstjenester er det nødvendig med en anmodning om hvilke tjenester som ønskes utført, fra innbygger selv eller fra annet helsepersonell. Anmodningsformene *henvisning* og *rekvirering* (jf. Figur 9) benyttes i samhandlingen mellom ulike aktører i helse- og omsorgstjenesten, og er svært sentrale for koordineringen. Dette gjelder både samhandling mellom aktører på samme omsorgsnivå, og samhandling mellom aktører på ulikt omsorgsnivå.

Figur 9. Samhandling innad i og på tvers av aktører



Flere helsepersonellgrupper har de siste årene fått delvis sykemeldings-, rekvisisjons- og/eller henvisningsrett. Manuellterapeuter og kiropraktorer fikk i 2006 status som primærkontakter for pasienter med muskel- og skjelettlidelser med henvisningsrett til spesialister, fysioterapi og radiologiske undersøkelser. De fikk da også rett til å sykmelde i inntil tolv uker, samt mulighet for refusjon fra Helfo (9). Optikere fikk i 2009 rett til å henvise til øyelege. I februar 2015 fremmet regjeringen for Stortinget Prop. 59 L (2014–2015) Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog), med forslag om at psykologer skal ha adgang til å skrive henvisninger til spesialisthelsetjenesten (10). Forslag om å gi tannleger henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten er på høring med frist i juni 2015.

Volum

Volumet av pasienter som har kontakt med helse- og omsorgstjenesten er desidert høyest hos fastlegen. I 2012 var 80 prosent av befolkningen innom sin fastlege og gjennomførte til sammen 13,5 millioner ordinære konsultasjoner. 2,2 millioner av innbyggerne hadde minst én konsultasjon i spesialisthelsetjenesten (NPR). En stor andel av pasientene løser med andre ord sine helsefaglige problemstillinger i førstelinjen uten behov for spesialiserte helsetjenester.

Figur 10. Pasienter og mottakere av helse- og omsorgstjenester i spesialist- og primærhelsetjenesten 2009-2013 (11)

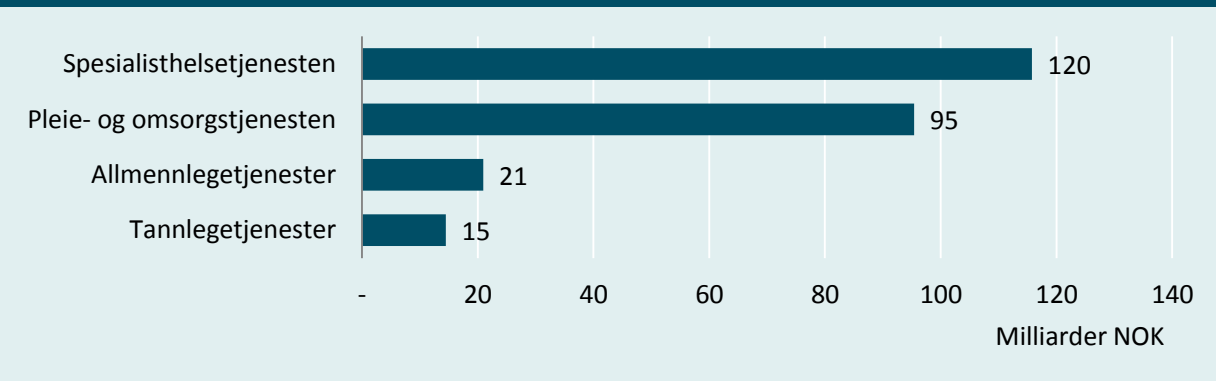
Pasienter/mottakere	2009	2011	2012	2013	Endring 2009-2011	Endring 2011-2013
Pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste ¹	1 718 712	1 767 166	1 785 141	1 803 497	2,8 %	2,1 %
Mottakere av omsorgstjenester ²	332 811	334 763	341 519	345 254	0,6 %	3,1 %
- Praktisk bistand	138 876	137 117	136 255	135 309	-1,3 %	-1,3 %
- Hjemmesykepleie	192 069	197 054	204 315	208 263	2,6 %	5,7 %
- Andre tjenester i hjemmet	243 581	201 723	202 038	194 388	-17,2 %	-3,6 %
- Langtidsopphold i institusjon	49 263	48 619	48 822	48 284	-1,3 %	-0,7 %
- Tidsbegrenset opphold i institusjon	52 177	54 091	60 513	61 920	3,7 %	14,5 %
Pasienter i øvrig primærhelsetjeneste ³						
- Fastlege/fastlønnet lege	-	3 842 921	3 887 992	3 944 346	-	2,6 %
- Fysioterapeut	250 385	373 245	389 554	451 311	-	20,9 %
- Legevakt	906 334	1 007 098	1 037 786	1 127 766	11,1	12,0 %

Kostnader til og finansiering av helsehjelp

I 2014 var de løpende helseutgiftene på 290 milliarder kroner. Dette utgjør 9,2 prosent av BNP. Helseutgiftene steg med 1,3 prosent fra 2013, målt i volum. Denne økningen er omtrent like stor som befolkningsveksten, og helseutgiftene per innbygger, 56.447 kroner, er derfor ganske lik som året før, dersom man korrejerer for prisstigning. (12)

Om lag 85 prosent av helseutgiftene, 247 milliarder kroner, finansieres av det offentlige. Av disse er om lag 120 milliarder kroner knyttet til spesialisthelsetjenester og 116 milliarder kroner til kommunale helse- og omsorgstjenester. Til sammenligning var de totale offentlige utgiftene på 1.418 milliarder; helseutgiftene utgjør dermed drøyt 17 prosent av det offentliges totale utgifter.

Figur 11. Fordeling av kostnader (i mrd NOK) i helse- og omsorgstjenesten. Kilde: SSB



¹ Data fra Norsk pasientregister

² Data fra SSB-IPLOS. Antall mottakere i løpet av året.

³ Data fra KUHR-HELFO. Tall for fastlege er ikke tilgjengelig for 2009. KUHR inneholder kun elektronisk registrerte krav fra fysioterapeuter. Andelen elektroniske krav har økt frem mot 2011 og gitt en kunstig vekst for disse områdene. Endringstall er derfor ikke med i tabellen.

Den offentlige finansieringsandelen på 85 prosent er godt over gjennomsnittet i EU-landene, som i 2012 var på 73 prosent. De nordiske landene har generelt en høy andel offentlig finansiering. Norge og Danmark er de to landene med høyest andel, begge med 85 prosent. Finland er det nordiske landet med lavest andel; her blir 75 prosent av helseutgiftene finansiert av det offentlige. (12)

Hvor stor andel av utgiftene som finansieres av det offentlige, varierer mellom ulike typer helse- og omsorgstjenester. Noen tjenester betaler husholdningene i stor grad for selv, mens andre helse- og omsorgstjenester hovedsakelig betales av det offentlige. Tannlegetjenester er den typen med høyest andel privat finansiering. I den andre enden av skalaen finner vi heldøgnsopphold på sykehus, som nesten utelukkende betales av det offentlige. Også sykehjemstjenester og rehabilitering har en høy andel offentlig finansiering. Det offentlige finansierer over 90 prosent av utgiftene for begge disse tjenestetypene. (12)

Det er en økning av pasienter med private behandlingsforsikringer. I andre kvartal 2014 hadde om lag 9 % (450 000) av befolkningen privat behandlingsforsikring. De aller fleste har tilgang til dette gjennom arbeidsgiver.

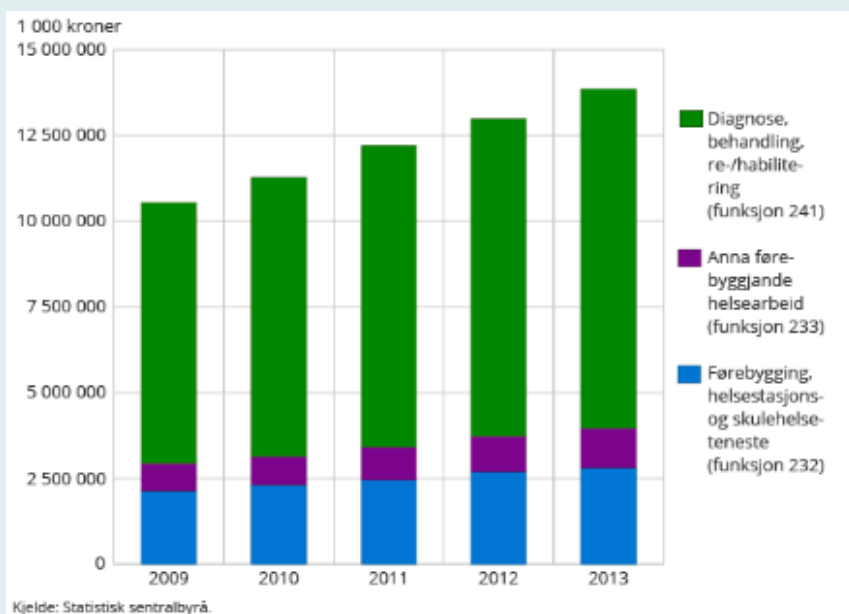
Finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunenes utgifter til helse- og omsorgstjenester er dels finansiert gjennom kommunens frie inntekter og øremerkede tilskudd, og dels gjennom statlige trygderefusjoner til blant annet allmennlegetjenester og fysioterapi. Det betales egenandeler for både helsetjenester og omsorgstjenester. For kommunene utgjorde brukerbetaling både for opphold i institusjon og for praktisk bistand til sammen om lag 6 milliarder kroner (13) i 2012.

Det er ulike regler for kommunens adgang til å ta betaling for tjenester i og utenfor institusjon. Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis. Tjenester det kan kreves betaling for er blant annet hjemmehjelpstjenester som rengjøring og annen praktisk hjelp til brukeren. Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene for praktisk bistand. Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere. Egenandelene skal ses i sammenheng med brukerens inntekter, slik at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Kommunen kan heller ikke ta mer enn et maksimalbeløp fastsatt i forskrift i egenandel for praktisk bistand av personer i husholdninger med en samlet skattbar nettoinntekt under 2G.

Kommunen kan ta betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelene av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget, dersom beboeren har forsørgeransvar eller på grunn av hensynet til hjemmeboende ektefelle. For korttidsopphold i institusjon kan kommunen kreve egenandel som fastsatt i forskrift.

Figur 12. Kommunehelsetjenester. Brutto driftsutgifter etter tjeneste 2009-2013. Absolutte tall.



Finansiering av spesialisthelsetjenester

Utgiftene til spesialisthelsetjenesten utgjorde 120 milliarder kroner i 2013 (14).

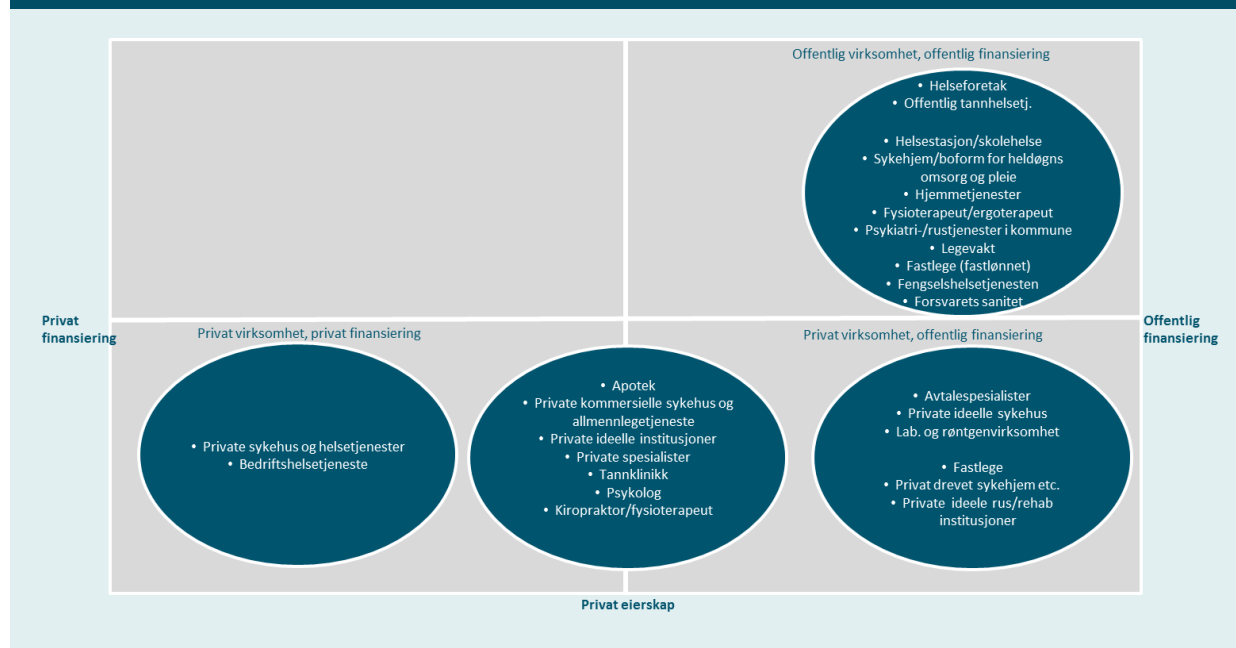
Systemet for fordeling av inntekter fra staten til de regionale helseforetakene kan i hovedsak deles i to. Inntekter i basisbevilgningen er uavhengige av aktivitet, mens inntekter via Innsatsstyrt finansiering (ISF) og poliklinikk er aktivitetsavhengig. Psykisk helsevern og rusbehandling finansieres i hovedsak gjennom basisbevilgning, mens somatiske sykehus finansieres gjennom basisbevilgning og ISF. Forholdet mellom basisbevilgning og ISF-inntekter har variert de senere årene. Siden 2006 har somatisk pasientbehandling blitt finansiert med 60 prosent basisbevilgning og 40 prosent aktivitetsbasert bevilgning. For 2015 utgjør ISF om lag 30 milliarder kroner og skal dekke 50 prosent av finansieringen (15).

Fra 2014 ble det innført kvalitetsbasert finansiering (KBF), som kommer i tillegg til basisbevilgning og Innsatsstyrt finansiering (ISF). Det er bevilget 509,3 millioner kroner til KBF i statsbudsjettet for 2015 og for 2016 er det foreslått bevilget 520 millioner kroner. KBF er en kvalitetsbasert finansieringsordning som bevilges over statsbudsjettet til de regionale helseforetakene hvert år. En andel av de regionale helseforetakenes totale inntekter gjøres avhengig av måloppnåelse ved bruk av kvalitetsindikatorer og prestasjonskriterier. Slik skal KBF spesielt vektlegge og fremme kvalitet i pasientbehandlingen. I første omgang er det snakk om en treårig forsøksordning som vil videreutvikles underveis. Det foretas en helhetlig evaluering av ordningen etter tre år. Evaluering pågår nå i regi av Helsedirektoratet.

Eierskap og finansiering

Figur 13 viser en overordnet oversikt over eierskap av aktører og finansiering av tjenestene i helse- og omsorgssektoren.

Figur 13. Eierskap og finansiering av aktører i helse- og omsorgssektoren

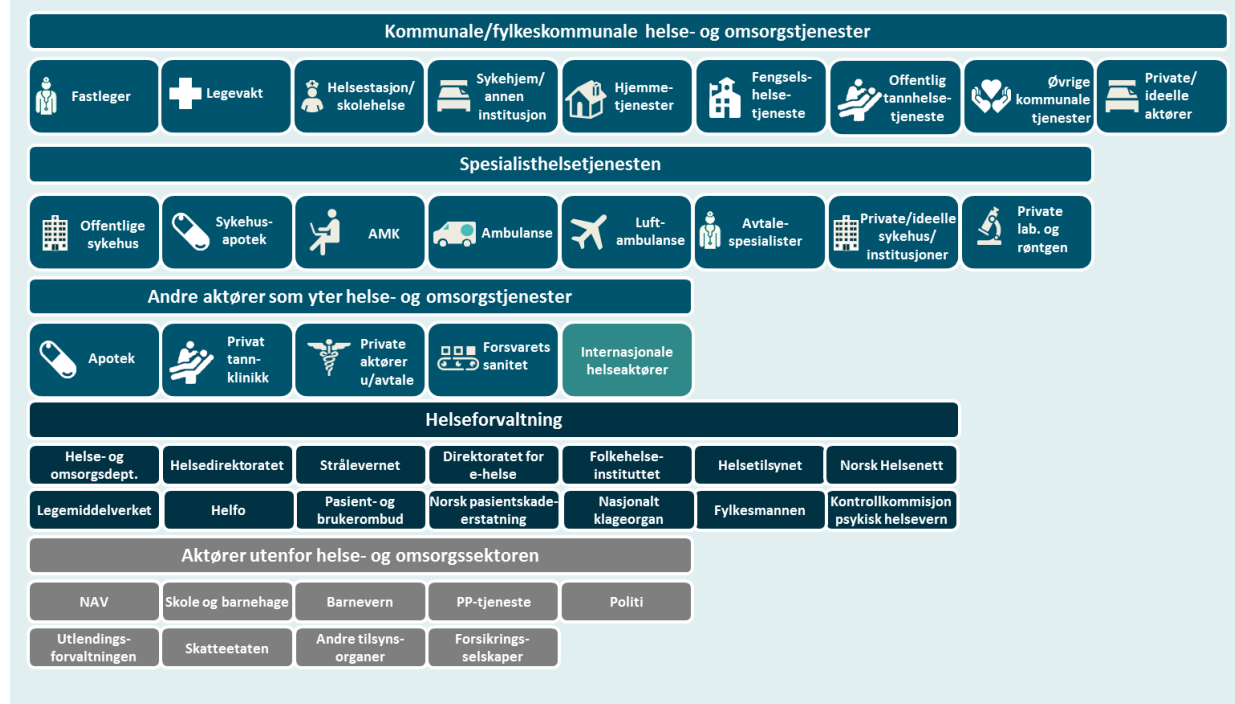


1.2.7 Aktører i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren er betydelig i omfang og kompleksitet, både når det gjelder totalt antall virksomheter og antall ulike typer virksomheter. Tjenestetilbudet har vært i kontinuerlig vekst i flere tiår, og organiseringen av dem er i stadig endring. Det norske helsesystemet er delvis desentralisert og ansvarsfordelingen er spredt mellom organisasjonsnivåene kommune, fylkeskommune og stat. Totalt er det over 300.000 ansatte i sektoren fordelt på omkring 17.000 virksomheter.

Helse- og omsorgstjenestene kan deles i to; primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Kommunene er ansvarlige for at det finnes gode primærhelsetjenester, eller kommunale helse- og omsorgstjenester, for sine innbyggere, mens staten er ansvarlig for spesialisthelsetjenestene, styrt gjennom fire regionale helseforetak. Ansvarsdelingen mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for avgrensningen av kommunenes samfunnsoppdrag. Kommunereformen legger opp til at større og mer kompetente kommuner skal ivareta og eventuelt overta flere oppgaver (16). Dette vil også påvirke tjenesteyterne i kommunene. Tilsvarende peker primærhelsemeldingen på behov for endringer knyttet til organisering, arbeidsdeling og arbeidsformer, med større grad av samlokalisering og mer teambasert helse- og omsorgstjeneste. (17) Figur 14 gir en overordnet oversikt over aktører i helse- og omsorgssektoren og andre aktører som yter helse- og omsorgstjenester.

Figur 14. Aktører i helse- og omsorgssektoren



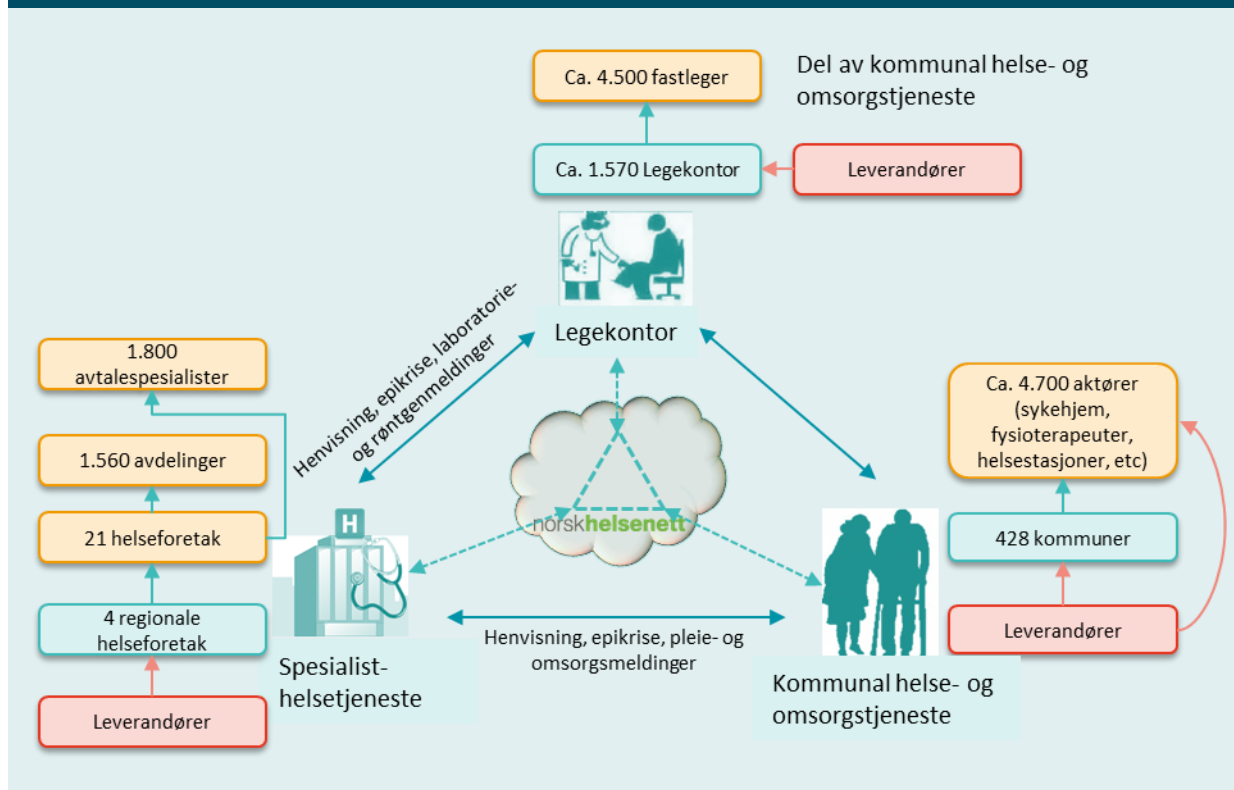
Figur 15 gir en oversikt over private og offentlige virksomheter i helse- og omsorgssektoren.

Figur 15. Private og offentlige virksomheter i helse- og omsorgssektoren

	Aktører	Antall virksomheter	Kilde
Spesialisthelse-tjeneste	Regionale helseforetak	4	
	Helseforetak	27	
	Offentlige sykehus	70	
	Ideelle organisasjoner	38	SSB, 2009 (18)
	Privateide foretak	81	SSB, 2009 (18)
	Avtalespesialister innen somatiske fagområder	728	NPR, 2014 (19)
	Avtalespesialister innen psykisk helsevern	764	NPR, 2014 (19)
	Private laboratorier og røntgeninstitutt	11	Helsedirektoratet, 2015
Kommunale helse- og omsorgstjenester	Kommuner	428	
	Fastleger	4.500	Helsedirektoratet, 2014 (14)
	Legekantor	1.570	
	Legevakt	191	Helsedirektoratet, 2014 (14)
	Helsestasjoner	378	Helsedirektoratet, 2015
	Helse- og omsorgsinstitusjoner	979	SSB, 2014 (20)
	Kiropraktorer som har avtale med HELFO	759	Helsedirektoratet, 2015
	Fysioterapeuter som har avtale med HELFO	4.351	Helsedirektoratet, 2015
	Frisklivssentraler	210	Helsenorge.no, 2015
	Fengselshelsetjeneste	47 fengsler i 42 kommuner	Helsedirektoratet, 2013 (21)
Andre aktører	Private tannklinikker	1.600	Tannlegeforeningen, 2014
	Tannleger som har avtale med HELFO	3.736	Helsedirektoratet, 2015
	Sykehusapotek	32	SLV, 2013 (22)
	Apotek	770	SLV, 2013 (22)

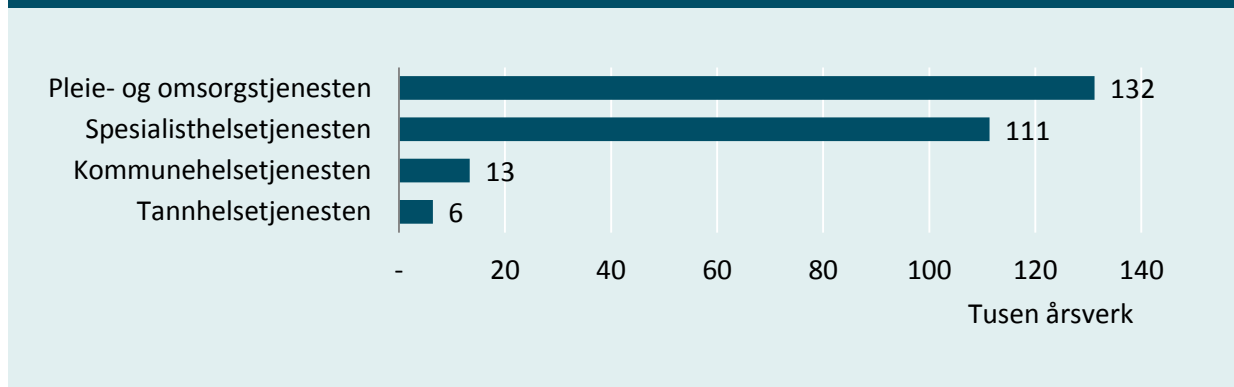
Økende grad av spesialisering og samhandling fører til at det er flere virksomheter som er løpende involvert i behandlingen av samme pasient, som illustrert i Figur 16.

Figur 16. Behandling av en pasient fordrer som regel samhandling mellom mange aktører



Totalt er det over 300.000 ansatte i sektoren. Offentlig helse- og omsorgstjeneste har ca. 260.000 ansatte. 131.000 er ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og 111.000 i spesialisthelsetjenesten, jf. Figur 17.

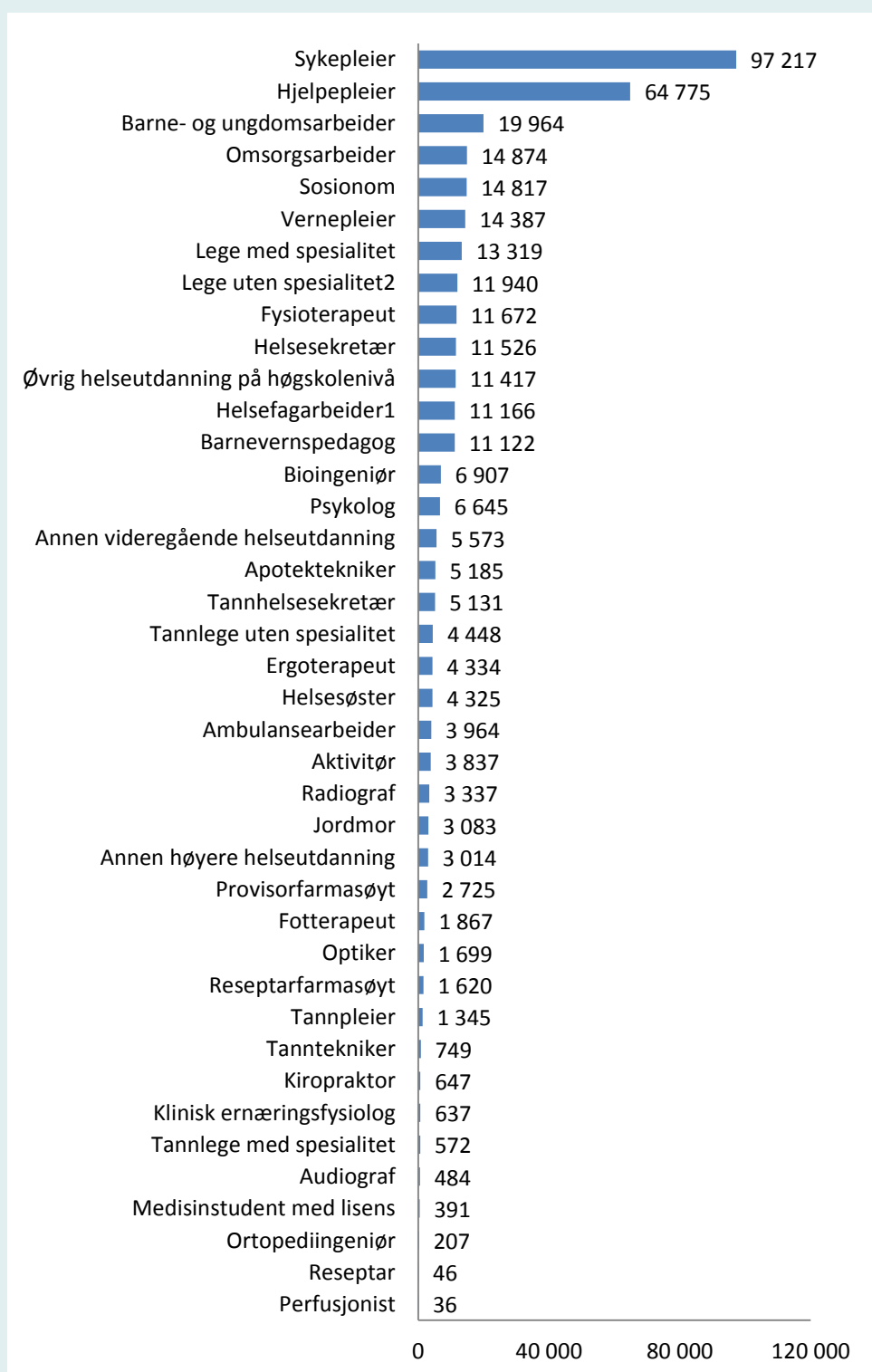
Figur 17. Fordeling av årsverk (i 1000) i offentlig helse- og omsorgstjeneste. Kilde: SSB



Totalt er det det rundt 380.000 personer med helse- og sosialfaglig utdanning i arbeidsstyrken i Norge. Figur 18 viser fordeling per fagutdanning.

Figur 18. Personer med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning. I arbeidsstyrken totalt, alle aldre (23)

Helse- og sosialfagutdanning i alt (2013): 381 004 personer



¹ Helsefagarbeider er ny fagutdanning fra 2009

² Fra kun kliniske psykologer er inkludert. Øvrige psykologiutdannede er inkludert i «Annen helsefaglig utdanning på universitetsnivå»

Det finnes en rekke spesialiseringer innen norsk medisin. Spesialisering er en faglig fordypning innenfor et område av medisinen som er naturlig avgrenset. Det er egne utdanningsprogrammer for å bli spesialist, og det kreves en godkjenning av Helsedirektoratet. Felles for spesialistutdanningene er krav til praksis og gjennomførte prosedyrer/aktiviteter innenfor fagområdet og deltakelse på et bestemt antall kurs.

Figur 19. Oversikt over kliniske spesialistområder (24)

• Allmennmedisin	• Hjertesykdommer	• Nukleærmedisin
• Anestesiologi	• Hud- og veneriske sykdommer	• Nyresykdommer
• Arbeidsmedisin	• Immunologi og transfusjonsmedisin	• Onkologi
• Barne- og ungdomspsykiatri	• Indremedisin	• Ortopedisk kirurgi
• Barnekirurgi	• Infeksjonssykdommer	• Patologi
• Barnesykdommer	• Karkirurgi	• Plastikkirurgi
• Blodsykdommer	• Klinisk farmakologi	• Psykiatri
• Bryst- og endokrinkirurgi	• Klinisk nevrofysiologi	• Radiologi
• Endokrinologi	• Lungesykdommer	• Revmatologi
• Fordøyelsessykdommer	• Maxillofacial kirurgi	• Rus- og avhengighetsmedisin
• Fysikalsk medisin og rehabilitering	• Medisinsk biokjemi	• Samfunnsmedisin
• Fødselshjelp og kvinnesykdommer	• Medisinsk genetikk	• Thoraxkirurgi
• Gastroenterologisk kirurgi	• Medisinsk mikrobiologi	• Urologi
• Generell kirurgi	• Nevrokirurgi	• Øre-nese-halssykdommer
• Geriatri	• Nevrologi	• Øyesykdommer

Kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen står relativt fritt til å organisere tilbudet slik de selv ønsker, men helse- og omsorgstjenesteloven angir hvilke tjenester kommunen som minimum må tilby. Norge har 428 kommuner med store variasjoner og forskjeller knyttet til geografi, innbyggertall og demografi, areal og sentralitet. Det mediane innbyggertallet er om lag 4.700, men det varierer fra drøyt 200 innbyggere i landets minste kommune til omtrent 650.000 innbyggere i Oslo kommune. Variasjonene bidrar til ulike utfordringsbilder og ulik utforming av tjenestetilbudet i kommunene.

I tråd med internasjonal utvikling foregår en økende andel av behandling i dag i kommunen. Samhandlingsreformen har som hovedmål å forebygge fremfor å reparere, samt å flytte tjenester nærmere der innbyggerne bor. Kommunene har fått et utvidet ansvar, blant annet har de fått ansvar for å tilby kommunale døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform med mål om større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet (16). Kommunereformen vil medføre endringer i organisering og ansvarsforhold innad i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Primærhelsemeldingen peker på behovet for endringer i organisering av kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder mer teambasert helse- og omsorgstjeneste og samlokalisering av tjenester (17).

Figur 20. Aktører i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester

Aktør	Beskrivelse
 Fastleger	Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen, uavhengig av om legen er ansatt i kommunen eller er selvstendig næringsdrivende. Fastlegeordningen utgjør sammen med kommunal legevakt en betydelig del av primærhelsetjenesten. Formålet med ordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegene er sentrale i kommunens ansvar for å tilby utredning, diagnostisering og behandling inkludert både planlagt og øyeblikkelig hjelp, men også ved svangerskaps- og barselomsorgstjenester. Fastlegen kan altså benyttes ved både kroniske og akutte helseproblemer. Fastlegene er ofte pasientens første møte med helsetjenesten, og fyller en portvaktfunksjon for mer spesialiserte former for helsetjenester. Fastlegeordningen er regulert i «Forskrift om fastlegeordningen i kommunene». Det var ved utgangen av 2014 rundt 4.500 fastleger i Norge. Størstedelen av fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Nesten 100 prosent av befolkningen deltar i fastlegeordningen. I 2013 hadde hver innbygger gjennomsnittlig 2,6 konsultasjoner hos fastlegen. Fastlege brukes oftest i aldersgruppen 67-89 år, hvor over 8 av 10 var i kontakt med fastlegen i 2013. (14)
 Legevakt	Legevakten skal ta i mot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, det vil si behandling av sykdom og skade som ikke kan vente til neste hverdag. Legevaktsentraler er en del av den medisinske nødmeldetjenesten og skal gi medisinske råd og veiledning. Den er en lovpålagt kommunal tjeneste som skal prioritere, registrere, iverksette og følge opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp fra personer som befinner seg innenfor legevaktdistriktet. Den skal kunne videreformidle henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. De siste årene har det vært en økende tendens til at flere kommuner går sammen om å organisere legevaktordningen, og 58 prosent av legevaktene er nå interkommunale. Per mai 2014 er det registrert 191 legevakter i Norge. Antallet legevakter som kun dekker én kommune er redusert fra 102 i 2009 til 80 i 2014. Rundt 33 prosent av legevaktslokalene er plassert i tilknytning til et fastlegekontor, ca. 25 prosent har eget legevaktlokale med legevaktsentral, mens ca. 20 prosent er samlokalisert med sykehus. (14) Deltakelse i legevakt er obligatorisk for fastleger, og ca. 44 prosent av alle legevaktkontakter ble utført av fastleger i 2013. Vel halvparten av legevaktene ivaretas av andre leger, og særlig ved store legevakter er det fast ansatte leger i tillegg til fastlegene. I 2013 hadde hver innbygger gjennomsnittlig 0,26 konsultasjoner hos legevakt. Bruken av legevakt er høyest i aldersgruppen 0-5 år, hvor nesten én av tre var i kontakt i 2013. (14)
 Helsestasjon/ skolehelse	Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til gravide, barn og unge i alderen 0–20 år og deres foresatte. Alle norske kommuner er lovpålagt å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tjenesten skal være gratis og skal være et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og familiene deres. Den omfatter helseundersøkelser, vaksiner, oppsøkende virksomhet (hjemmebesøk), helseopplysning og veiledning. Svangerskapsomsorg inngår ofte som en tjeneste på helsestasjon, men tjenestene kan også inngå i et interkommunalt samarbeid eller i samarbeid med helseforetak (25). Fastlegene har også oppgaver innenfor svangerskapsomsorgen. Det skal være skolehelsetjeneste på alle skoler til og med videregående. Det gjelder både private og offentlige skoler. I tillegg oppretter stadig flere kommuner et helsestasjonstilbud for ungdom. Dette skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, skolehelsetjenesten. På de fleste helsestasjoner er jordmor, lege og helsesøster tilgjengelig, og ofte også psykologer. Totalt var 4 217 årsverk tilknyttet disse tjenestene i 2013. Vel halvparten av disse er helsesøstre, ca. 300 jordmødre, 427 andre sykepleiere, 192 fysioterapeuter og 207 legeårsverk. (26)

 Sykehjem/ annen institusjon	<u>Sykehjem og annen boform for heldøgns omsorg og pleie:</u> Kommunene har ansvaret for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av alder og diagnose. Omsorgstjenestene må organiseres slik at brukeren så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene gis både gjennom ulike former for hjemmetjenester og opphold på institusjon. Den enkelte kommune står relativt fritt i organiseringen av tilbudet, og kan også velge å kjøpe institusjonsopphold av private aktører. I tilknytning til opphold på institusjon skal det være organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjeneste. Etter forskrift om helse- og omsorgsinstitusjoner faller følgende institusjoner inn under det kommunale institusjonsbegrepet (27): • Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barnebolig), herunder avlastningsboliger • Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusavhengige • Aldershjem • Sykehjem • Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (KAD – Kommunal akutt døgnenhet) Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer om en bolig skal anses som en av disse kommunale institusjonene. Flere kommuner/regioner har etablert distriktsmedisinske sentre. Dette er ingen definert enhet. Sentrene er tenkt å fungere som en fellesarena for primær- og spesialisthelsetjenesten. Hvilke tjenester som tilbys på sentrene varierer – fra å bestå av poliklinikk og legevakt til å også tilby dagkirurgi og sengepost for pasienter som trenger innleggelse. Det var i 2013 ca. 1.000 institusjoner i Norge. (28)
 Hjemme- tjenester	Hjemmetjenester kan inkludere alle former for helsehjelp som gis hjemme hos pasienten. Dette kan blant annet være hjemmesykepleie, ergoterapeut, fysioterapeut, fottersapeut, ernæring mv. Det er ikke et absolutt krav at tjenesten tilbys innendørs i hjemmet. Hvis det er hensiktsmessig kan tjenestene også gis utenfor hjemmet, for eksempel kan et rehabiliteringsopplegg gjennomføres helt eller delvis utendørs. Kommunen kan ikke ta betalt for helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Eksempel på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, kan være: • Hjelp til medisiner/medikamenter • Sykepleiefaglig hjelp, for eksempel sårstell • Helsefaglige observasjoner • Fysioterapi • Psykisk helsetjeneste • Matombrining og annen praktisk bistand i hjemmet • Trygghetsalarm • Dagaktivitetstilbud <u>Spesialistbehandling i hjemmet:</u> En stadig større del av spesialisthelsetjenestene som tidligere ble utført på sykehus foregår nå i hjemmet. Eksempler på slik helsehjelp er hjemmedialyse, respiratorbehandling og oksygenbehandling. Antall tjenester og pasienter er økende. Dette utfordrer grensene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
 Fengsels- helse- tjeneste	Innsatte i fengsel har de samme rettigheter til helsehjelp som de ville hatt utenfor fengselet. I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte, i praksis allmennhelsetjenester. Det er opp til kommunene hvordan de organiserer dette, og de fleste har etablert egen fengselshelsetjeneste. Tjenesten yter ofte helsehjelp både innen somatisk og psykisk sykdom og kan omfatte både sykepleiere, psykiatriske sykepleiere og hjelpepleiere, fysioterapeut og leger. Dersom institusjonen tilbyr organisert legetjeneste, overføres fastlegens ansvar til institusjonen.

	De regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenestens tilbud når det gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester. Fylkeskommunene har ansvar for tannhelsetjenestene. 43 av landets kommuner har til sammen 47 fengsel med en samlet kapasitet på ca. 3.800 plasser. (21)
 Offentlig tannhelsetjeneste	Etter tannhelsetjenesteloven skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, inkludert spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for hele befolkningen. Fylkeskommunen har også et ansvar for helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid. Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, som skal sørge for tjenester til pasientgrupper som er prioritert etter lov om tannhelsetjenesten. Dette inkluderer barn og unge opp til 20 år, psykisk utviklingshemmede og grupper av eldre, langtidssyke, uføre på institusjon og mottakere av hjemmesykepleie. Fylkeskommunen har også ansvar for å yte nødvendig tannbehandling til langtidsinnsatte i fengsel. Fylkeskommunen kan også vedta andre grupper som kan inngå i den offentlige tannhelsetjenesten. I meldt. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, foreslås det fylkeskommunale ansvaret for tannhelsetjenesten overført til større og mer robuste kommuner. Dette begrunnes i at tannhelsetjenesten har grenseflater mot kommunale tjenesteområder, og det vil kunne gi god effekt å organisere og integrere disse tjenestene.
 Øvrige kommunale tjenester	<u>Eksempler på øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester:</u> • Fysioterapitjeneste: Kommunen skal sørge for fysioterapitjeneste til sine innbyggere. Den kommunale fysioterapitjenesten består av forebyggende virksomhet og av behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. Fysioterapeuter kan ansettes i kommunale stillinger eller arbeide som selvstendig næringsdrivende, med eller uten driftstilskuddsavtale med kommunene. For at det skal utbetales refusjon for behandling hos fysioterapeut, må det foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut (fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi). Regjeringen vil vurdere å innføre direkte tilgang til fysioterapi uten henvisning. (17) Ved behov skal kommunen henvise til spesialisthelsetjenesten, som har ansvaret for mer spesialiserte fysioterapi-, habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Deler av fysioterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem. Fysioterapeuter i kommunene har et nært samarbeid med andre faggrupper i kommunen og spesialisthelsetjenesten. • Manuellterapeut og kiropraktor: Manuellterapeuter og kiropraktorer fikk i 2006 status som primærkontakter for pasienter med muskel- og skjelettlidelser med henvisningsrett til spesialister, fysioterapi og radiologiske undersøkelser. De fikk da også rett til å sykmelde i inntil tolv uker, samt mulighet for refusjon fra Helfo (9). • Ergoterapitjeneste: Kommunen er pålagt å organisere ergoterapitjeneste for formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse. I enkelte kommuner ytes dette av fysioterapitjenesten. Ergoterapeutene kan gi opplæring og trening i dagliglivets aktiviteter til personer som på grunn av sykdom eller skade har redusert funksjonsevne. • Psykisk helsevern og rusomsorg: Kommuner skal ha tilbud til personer med psykisk sykdom og rusmiddelproblemer. Det er ulikt hvordan tjenesten er organisert i den enkelte kommune. I tillegg til sentrale aktører som fastlege, psykisk helsetjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste er det bygd opp en rekke tilbud til både barn, unge og voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblem. Dette kan for eksempel være oppsøkende team, ulike behandlingstilbud, personlig assistanse, samtalegrupper, væresteder og ulike botilbud med individuelle tjenester. Når det gjelder barn og unge vil det i mange tilfeller være samarbeid med PP-tjeneste og barnevern. Flere kommuner har, som en viktig del av kommunens helhetlige tjenestetilbud, etablert brukernære lavterskel helsetilbud, for lettere å nå de som trenger hjelp. Stadig flere har psykologer ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste, som gir tilbud om kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser. Det er også blitt vanlig å etablere ROP-team, som er et tverrfaglig team som gir tjenester til mennesker med samtidig rusavhengighet og alvorlig psykisk lidelse. De ansatte har derfor ulik kompetanse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. • Frisklivssentral: En frisklivssentral er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner

	for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått. Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper for blant annet fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Flere frisklivssentraler har tilbud til barn, unge og deres familier. De samarbeider med både frivillige, offentlige og private aktører og skal ha god oversikt over lokale tilbud. En viktig del av oppfølgingen ved Frisklivssentralen er å gi støtte og veiledning til å finne frem til aktivitet og lokale tilbud som passer den enkelte. Om lag 210 kommuner har etablert frisklivssentral (29). Nærmere 50 av disse har et interkommunalt samarbeid. • Studenthelsetjeneste: Flere universitet og høyskoler har etablert eget helsetjenestetilbud for sine studenter, og omfatter ofte fastlege, helsesøster, fysioterapi, tannlege. Blant annet tilbyr universitetet i Oslo fastlegjetjenester og har etablert tre fastlegekontor.
 Private/ ideelle aktører	<u>Private og ideelle aktører med driftsavtaler med kommuner:</u> Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan den ønsker å organisere tjenestene sine, så lenge den oppfyller kravene etter kommunehelsetjenesteloven. Pleie- og omsorgstjenester kan kjøpes fra ideelle eller private/kommersielle aktører, innkjøpene reguleres av Lov om offentlige anskaffelser (30). Regelverket tilsier at kommunen kan velge om den vil utføre tjenestene de er pålagt å utføre selv, eller om de kjøper tjenestene av en privat eller ideell aktør. De ideelle og private virksomhetene kan for eksempel tilby sykehjemdrift, hjemmetjenester, botilbud til tunge brukere innfor rus og psykiatri, helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse og fysioterapi. Noen kommuner har fritt brukervalg på enkelte tjenester som de tildeler sine brukere/innbyggere. Brukeren/innbyggeren velger aktør og kommunen betaler leverandøren en timebetaling for utført tjeneste, for eksempel innenfor hjemmetjenester. Det er også kommuner som har fritt brukervalg på sykehjem hvor kommunen disponerer plassene, brukeren kan velge mellom sykehjem uavhengig om det er et privat/ideelt eller kommunalt sykehjem.

Spesialisthelsetjenesten

I 2002 ansvaret ble ansvaret for å sikre norske innbyggere nødvendig tilgang til spesialisthelsetjeneste, overført til staten fra fylkeskommunen. Spesialisthelsetjenesten omfatter hovedsakelig somatiske og psykiatriske sykehus, radiologi og laboratorievirksomhet, rehabilitering, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet og rusomsorg. (31)

Spesialisthelsetjenesten reguleres gjennom spesialisthelsetjenesteloven og helseforetaksloven.

Spesialisthelsetjenesten er i dag organisert i en foretaksmodell i fire regionale helseforetak. De regionale helseforetakene står fritt til å organisere tjenestene i underliggende helseforetak og heleide datterselskap. De regionale helseforetakene har også mulighet til å inngå avtaler med private virksomheter gjennom driftsavtaler for å sørge for et tilstrekkelig tilbud av nødvendige spesialisthelsetjenester. Dette kan være spesialister innenfor et fagfelt, privatsykehus, institusjoner eller laboratorier. I 2012 var 9 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten knyttet til kjøp av helsetjenester fra private leverandører. (32)

Figur 21. Aktører i spesialisthelsetjenesten

Aktør	Beskrivelse
 Offentlige sykehus	Regionale helseforetak (RHF): Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, eier de regionale helseforetakene. (33) I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser sine pålagte oppgaver enten ved at sykehus eid av de regionale sykehusene utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private. Spesialisthelsetjenesten omfatter sykehus, poliklinikker, legespesialister, medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjeneste, laboratorie- og radiologitjenester, samt spesialisert rusbehandling. Spesialisthelsetjenesten sysselsetter 111.000 årsverk. Av disse er mer enn to tredjedeler ansatt i somatiske institusjoner. (34) Kjøp av private i spesialisthelsetjenesten inkludert avtalespesialister utgjør om lag 12,4 milliarder i 2013. For avtalespesialistene er det i denne summen kun tatt med deres inntekt fra basisbevilgning (om lag 25-30 prosent). Avtalespesialistenes refusjon over Folketrygdloven utgjør ca. 3 milliarder i tillegg. De regionale helseforetakene eier i felleskap Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og Luftambulansetjenesten ANS. • Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS: Administreringen av pasientreiseområdet er organisert gjennom 18 lokale pasientreisekontor, samt et nasjonalt selskap, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. De lokale pasientreisekontorene er underlagt sine respektive helseforetak. Helseforetakenes senter for pasientreiser, eid av de regionale helseforetakene, ivaretar transaksjonstunge og koordinerende oppgaver rundt pasientreiser og samarbeider med de lokale pasientreisekontorene. • Luftambulansetjenesten ANS er beskrevet lenger ned i tabellen. Helseforetak (HF): Et helseforetak (HF) er en norsk statlig virksomhet som eies av et regionalt helseforetak, regulert gjennom helseforetaksloven av 2001. Helseforetak yter spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Per november 2014 var det til sammen 27 helseforetak. Tre av helseforetakene er felles for regionene (Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Nasjonal IKT HF og Sykehusbygg HF). Fire av helseforetakene er sykehusapotek, ett for hver region (se egen beskrivelse under). De øvrige 20 helseforetakene driver til sammen ca. 70 offentlige sykehus. Et helseforetak består i praksis av flere sykehus plassert på forskjellige lokasjoner, med større eller mindre grad av funksjonsfordeling. (35) Spesialisthelsetjenesten omfatter somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet. En stadig større del av spesialisthelsetjenestene som tidligere ble utført på sykehus foregår nå i hjemmet. Eksempler på slik helsehjelp er hjemmedialyse, respiratorbehandling og oksygenbehandling. Antall tjenester og pasienter er økende. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste er en fellesbetegnelse for høyspesialisert behandling som er sentralisert til ett eller to steder i landet, og omfatter nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester, samt nasjonale kompetansetjenester. Et nytt, revidert styringssystem for alle nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten ble etablert i 2011, og er regulert i egen forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Departementet har utarbeidet en egen veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. (29)
 Sykehusapotek	Sykehusapotekene er en del av spesialisthelsetjenesten, organisert som helseforetak, og eid av de regionale helseforetakene. I 2013 var det 32 sykehusapotek i Norge: • Sykehusapotekene HF eies av Helse Sør-Øst RHF og driver 17 sykehusapotek. • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF eies av Helse Midt-Norge RHF og driver seks sykehusapotek.

	• Sykehusapotek Nord HF eies av Helse Nord RHF og driver tre sykehusapotek, samt avdelinger ved fem øvrige sykehus. • Sjukehusapoteka Vest HF eies av Helse Vest RHF og driver fire sykehusapotek. I tillegg er to sykehusapotek eid av ideelle stiftelser med sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak. Sykehusapotek er samlokalisert med et offentlig eller privat sykehus, og har legemiddelforsyning til sykehuset som sin primæroppgave. De er også tjenesteleverandør av farmasøytiske tjenester til sykehusene. Sykehusene har også anledning til å selge legemidler direkte til enkeltpersoner i sine publikumsavdelinger. Sykehusapotekene omsatte i 2013 for totalt 4,6 milliarder kroner, og hadde ca. 900 årsverk. (22)
	Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av medisinsk nødmeldetjeneste som har til hovedoppgave å besvare det medisinske nødnummeret 113 og ta imot bestillinger på ambulanse. AMK koordinerer ambulanseressursene, alarmerer lokalt legekantor og gir medisinsk rådgivning når nødvendig. Det er i dag 19 AMK-sentraler, som gjerne er lagt til de største sykehusene. Det pågår en prosess med å redusere antall AMK-sentraler. Alle AMK-sentralene tar i mot og registrerer hendelser med behov for akuttmedisinsk hjelp. Henvendelser kommer både fra publikum, pårørende, pasienten selv eller andre på nødtelefon 113. I tillegg er AMK-sentralene koordinerende enhet for ambulanseoppdrag knyttet til henvendelser om pasientforflytning på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten, samt innleggelser til sykehus fra en rekke helseinstitusjoner. AMK-sentralene mottok i 2014 om lag 889.600 henvendelser totalt, en økning på 2,4 prosent fra 2013. Henvendelsene medførte mer enn 651.000 ambulanseoppdrag med bil, båt og luftambulanse, en økning på 2,7 prosent fra 2012. I 2013 utgjorde bestilte oppdrag litt over 50 prosent av all aktivitet som AMK-sentralene utfører. En del AMK-sentraler fungerer også som legevaktsentral for én eller flere kommuner i nærområdet. 96 prosent av alle henvendelser til AMK-sentralene gjaldt utelukkende helserelaterte problemstillinger, mens fire prosent krevde samarbeid og koordinering med brann og/eller politi. Hver henvendelse prioriteres etter hastegrad. Omlag 28 prosent av henvendelsene kategoriseres som akutt, 36 prosent som haster og 36 prosent som vanlig. (14)
	Ambulansetjenester er organisert under de enkelte helseforetak. En ambulanse kan være for eksempel båt, bil, fly eller helikopter. Ambulanse med fly og helikopter er organisert som egen enhet, se egen beskrivelse under Luftambulanse. Enkelte større arbeidsplasser med farlig arbeid kan ha bedriftshelsetjeneste og ulykkesberedskap med egen ambulanse.
	Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen. Sørge-for-ansvaret for luftambulansetjenesten ble overført til de regionale helseforetakene i 2002. I 2004 etablerte disse et felles datterselskap, Luftambulansetjenesten ANS. (36) De regionale helseforetakene betaler alle kostnader knyttet til luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten ANS har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere. Luftambulansetjenesten ANS har hovedkontor i Bodø (administrasjonen). Selskapet holder i tillegg til i Trondheim (medisinsk tekniske tjenester) og i Tromsø (Flykoordineringssentralen). Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud. Luftambulansetjenesten ANS har per 2013 kontrakt med to operatører (Norsk luftambulanse AS og Lufttransport AS) for ambulansefly og ambulanshelikoptre. Ambulansefly er lokalisert på syv steder, mens ambulanshelikoptre er lokalisert på elleve steder. Ved samtlige baser er det døgnkontinuerlig beredskap. Helse- og omsorgsdepartementet har avtale med Justis- og beredskapsdepartementet om at redningshelikoptrene kan benyttes til luftambulanseoppdrag dersom ikke søk- og redningsoppdrag må prioriteres foran. Basene for redningshelikoptre er på seks steder, samtlige med døgnkontinuerlig beredskap.

 Avtale- spesialister	Avtalespesialister er private legespesialister og psykologer som har driftsavtale med regionale helseforetak. I 2014 hadde nærmere 1.500 spesialister avtale med regionale helseforetak, 728 innen somatiske fagområder og 764 innen psykisk helsevern. (19) Avtalespesialistene tilbyr dagbehandling innenfor respektive spesialiteter. Avtale med et RHF gir mulighet for refusjon fra Helfo og belastning med egenandel forutsatt henvisning til spesialist og rapportering til NPR. Avtalespesialister kan også behandle pasienter uten henvisning, men da dekker pasienten hele kostnaden selv. Avtalespesialistenes aktivitet utgjorde i 2014 omtrent 28 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og omtrent 24 prosent innen psykisk helsevern for voksne. Avtalespesialistene har en beskjedne rolle i psykisk helsevern for barn og unge, der de utførte ca. fire prosent av den totale polikliniske aktiviteten. Av de 764 avtalespesialistene innen psykisk helsevern, er 523 psykologer. (19) For at det skal utbetales refusjon for behandling hos psykolog, må det foreligge henvisning fra lege. I februar 2015 fremmet regjeringen for Stortinget Prop. 59 L (2014–2015) Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog), med forslag om at psykologer skal ha adgang til å skrive henvisninger til spesialisthelsetjenesten. (10)
 Private/ideelle sykehus/ institusjoner	<u>Private/ideelle sykehus og institusjoner med avtaler med regionale helseforetak:</u> De regionale helseforetakene har avtaler med både private og ideelle sykehus, i tillegg til avtalespesialistene. En del private/ideelle sykehus har driftsavtale med et RHF (f.eks. Diakonhjemmet sykehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus). Andre har kun avtale om å utføre definerte tjenester (utredning, behandling og rehabilitering) for et RHF, slik at øvrig aktivitet ikke dekkes (f.eks. Feiring (hjertekirurgi, PCI), Aleris, Teres Medical). Avtalene med RHF-ene er såkalte ytelsesavtaler, basert på anbudsprosesser. Fritt behandlingsvalg vil gi pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste mulighet til selv å velge hvor de vil bli utredet eller behandlet blant godkjente institusjoner - på offentlige sykehus, på private behandlingssteder som har avtale med det offentlige eller andre godkjente behandlingssteder. Dette medfører en utvidelse av fritt sykehusvalg for utvalgte områder slik at pasienter kan velge blant flere private/ideelle aktører enn dem som har vært inkludert i fritt sykehusvalg.
 Private lab. og røntgen	De regionale helseforetakene har avtaler med private laboratorier og røntgeninstitutter. Disse yter helsehjelp både for pasienter i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Inntektene til de private laboratoriene og røntgeninstituttene baserer seg i hovedsak på betaling gjennom rammeavtaler med regionale helseforetak og refusjon fra Helfo regulert etter folketrygdloven. I tillegg mottar de full betaling fra pasienten selv eller forsikringsselskap.

Andre aktører som yter helse- og omsorgstjenester

I tillegg til alle aktørene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten er det en rekke andre private aktører som yter helse- og omsorgstjenester. De mest sentrale aktørene trekkes frem her.

Figur 22. Andre aktører som yter helse- og omsorgstjenester

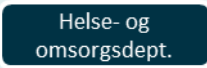
Aktør	Beskrivelse
 Apotek	Apotekloven definerer et apotek som et salgssted for legemidler til sluttbruker hvor det gis legemiddelfaglig veiledning og som er fysisk tilgjengelig for innbyggerne. Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere, men også annet helsepersonell som for eksempel sykepleiere. Med endringen av apotekloven fra 2001 er den norske eierskaps- og etableringspolitikken for apotek blant de minst regulerte i Europa. Statens legemiddelverk gir driftskonsesjon og apotekkonsesjon, som gir rett til å hhv. drive og eie et bestemt apotek. Det var i 2013 ca. 770 apotek i Norge, fordelt på 260 kommuner. Apotekene er eid av private aktører, hvorav tre store apotekkjeder eier nærmere 90 prosent av apotekene. I tillegg kommer 32

	sykehusapotek (se egen beskrivelse). (22) På steder der det ikke er mulig å etablere apotek, kan det etableres medisinutsalg. Medisinutsalg er et separat utleveringssted for legemidler, underlagt et lokalt apotek. Totalt er det registrert ca 920 medisinutsalg. 206 apotek har medisinutsalg knyttet til seg. De fleste medisinutsalgene er plassert i dagligvarebutikker. (22) Utvalgte reseptfrie legemidler kan selges blant annet i dagligvareforretninger og på bensinstasjoner. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer regelverksendring som opphever dagens begrensninger knyttet til forsendelse av legemidler fra apotek. Det tas sikte på at endringen skal gjelde f.o.m. 2016. Norske apotek vil da eventuelt kunne etablere netthandel med reseptpliktige legemidler.
 Privat tann-klinikk	Tannhelsetjenester til den voksne del av befolkningen dekkes i hovedsak gjennom den private tannhelsetjenesten. Det gis imidlertid stønad over folketrygdloven ved en rekke tilstander, og i 2014 ble det utbetalt om lag 1,5 milliarder kroner over folketrygden til tannbehandling. For mange av de stønadsberettigede tilstandene stilles det krav om erklæring eller henvisning fra lege/spesialist. En lang rekke sykdommer i munnhulen har relasjon til systemiske tilstander. Tannleger har forskrivningsrett og forslag om å gi tannleger henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten er på høring med frist i juni 2015. Det er omkring 1.600 private tannklinikker i Norge. I 2013 var det i alt 3.234 avtalte tannlegeårverk og 391 tannpleierårverk i privat sektor, samt 401 tannlegespesialistårverk. <i>Tannteknisk laboratorie:</i> Tannteknikere lager tannerstatninger og skinner til pasienter som har mistet eller fått skader på tennene. I Norge er nesten samtlige laboratorier private, selvstendige bedrifter som tar imot oppdrag fra tannleger. Et fåtall tannteknikere arbeider i det offentlige, tilknyttet den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det er ca. 750 tannteknikere i Norge. (23)
 Private aktører u/avtale	<u>Eksempler på private aktører uten driftsavtale med kommuner eller regionale helseforetak:</u> • Optikere: Optikere er en førstelinjehelsetjeneste innen syn, og de aller fleste kan få hjelp med synskorreksjon hos optiker, så som å få hjelp til riktig tilpassede briller og/eller kontaktlinser. Ved tegn til sykdom eller skade, kan optiker henvise til øyelege. Optikere kan også jobbe på øyeavdelinger på sykehus eller private klinikker og hjelpemiddelsentraler for synshemmede. Det er ca 1.700 optikere i Norge (SSB). Optikere fikk i 2009 rett til å henvise til øyelege. • Fotterapeuter: Fotterapeuter er autorisert helsepersonell som har kompetanse på føttøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. Fotterapeuter driver ofte privat virksomhet, men kan også være ansatt i kommunen. Arbeidsoppgaver omfatter forebygging, behandling og individuell veiledning. Samarbeidet med annet helsepersonell som leger, fysioterapeuter og ortopediingeniører er ofte en del av arbeidet. Det er nærmere 1.900 fotterapeuter i Norge (34). • Bedriftshelsetjeneste: Noen bransjer har et mer risikofyllt arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, men den har ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomhetene. Virksomhetene kan enten etablere en egen bedriftshelsetjeneste internt i virksomheten eller benytte en fellesordning som har mange virksomheter som medlemmer/kunder. Uavhengig av organisasjonsform skal arbeidstilsynet godkjenne ordningen, og har etablert en egen godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester (37). • Klinikker for kosmetisk behandling og kirurgi: Det finnes en rekke private klinikker som utfører ulike kosmetiske behandlinger, blant annet kirurgi. Behandlingen betales i sin helhet av pasienten selv. • Alternativ behandlere: Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten. Loven om alternativ behandling regulerer helserelatert behandling som utøves utenfor den offentlige eller private helse- og omsorgstjenesten av behandlere som ikke er autorisert helsepersonell. (38) Alternativ behandling består av et stort antall fagretninger med ulikt teoretisk og erfaringsbasert grunnlag, for eksempel akupunktur, homøopati, refleksologi,

	healing, sonfelletterapi mv. Alternativ behandling utøves av alternative utøvere, men også av helsepersonell med autorisasjon etter helsepersonelloven. I mange tilfeller benyttes alternativ behandling som et supplement til den ordinære offentlige eller private helsetjeneste. Det er etablert en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. Registrering forutsetter at vedkommende er medlem av en organisasjon for utøvere av alternativ behandling som er godkjent av Helsedirektoratet.
 Forsvarets sanitet	Forsvarets sanitet er ikke å regne som en aktør i helse- og omsorgssektoren, men yter helsehjelp til ansatte og vernepliktige i forsvaret. Forsvarets sanitet skal sikre at Forsvaret til enhver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem for å understøtte Forsvarets virksomhet før, under og etter operasjoner. Forsvarets sanitet har underavdelinger, blant annet sykestuer, i alle større militærleire, til sammen 26 lokasjoner. Forskning drives innenfor flere fagområder blant annet innen flymedisin, traumatologi, navalmedisin, katastrofepsykiatri, epidemiologi, klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Organisasjonen har ca. 400 ansatte, samt har årlig om lag 900 elever til utdanning innenfor sanitetsfaget og akuttmedisin.
 Internasjonale helseaktører	Stadig flere får helsehjelp hos helseaktører utenfor Norge, både primær- og spesialisthelsetjenester. Helsehjelpen kan både være egenfinansiert eller finansiert av det offentlige. <u>Helsehjelp i Norden:</u> De nordiske landene har et etablert samarbeid på helse- og sosialområdet. I felles erklæring i Nordisk ministerråd ble man i 2014 enige om å styrke samarbeid om høyspesialisert behandling i Norden. <u>Helsehjelp i andre EØS-land:</u> EUs pasientrettighetsdirektiv fikk full virkning i Norge fra 1. mars 2015, og pasienter kan nå få dekket utgifter til sykehusbehandling i andre EØS-land. Pasienten vil kunne få dekket kostnader som tilsvarer kostnadene ved lignende behandling i Norge. Det er Helfo som behandler søknader om refusjon og som gir forhåndstilsagn. Pasienter og innbyggere kan også få dekket utgifter for annen type helsehjelp i utlandet, jf. forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land, på samme vilkår som pasienten ville fått i Norge.

Helseforvaltning

Figur 23. Aktører i sentral helseforvaltning

Aktør	Beskrivelse
 Helse- og omsorgsdept.	<i>Stortinget legger de overordnede politiske rammer for helsepolitikken, i første rekke gjennom beslutninger om nasjonale lover og budsjetter.</i> Regjeringen/Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider Regjeringens forslag til lover og budsjetter på helsepolitikkområdet. Sykehusene ble overført fra fylkeskommunene til staten i 2002, og staten overtok da eierskapet og styringen av de offentlige sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet utøver også myndighetsstyringen av spesialisthelsetjenesten, det vil si styring gjennom lover, forskrifter, rundskriv og vedtak, andre enkeltstående myndighetstiltak, samt fastsettelse av takster og egenandeler og behandling av klage på enkeltvedtak i underliggende organer. Myndighetsstyringen omfatter både private og offentlige institusjoner. Eierstyringen fra departementet omfatter bare de offentlige sykehusene.
 Helsedirektoratet	Helsedirektoratet har ansvar for å følge situasjonen i befolkningens helsetilstand og utviklingen i helse- og omsorgstjenesten og på dette grunnlag gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet i faglige spørsmål. Ansvarsområdet dekker både kommunehelsetjenesten, spesialister og sykehus for å iverksette nasjonal politikk på de områdene som er delegert fra departementet, og å administrere og fortolke enkelte helselover. Helsedirektoratet har også funksjoner knyttet opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Helfo	Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo forvalter refusjonsordningene og utbetaler årlig om lag 30 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har Helfo ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt veiledningstelefonen 800HELSE (800 43 573).
Strålevernet	Statens strålevern er landets fag- og forvaltningsmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet, radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall. Strålevernet skal ivareta befolkningens helse, blant annet bl.a. gjennom forvaltning og tilsyn av all bruk av strålekilde i medisin, industri og forskning. Videre skal de øke kunnskapen om omfang, risiko og effekt av stråling, blant annet medisinske effekter av stråling. Alvorlige hendelser i stråleterapi skal varsles strålevernet. Strålevernet vil fra 1.1.2016 inngå som ytre etat under Helsedirektoratet.
Direktoratet for e-helse	Direktoratet for e-helse etableres fra 1.1.2016 som fagdirektorat og myndighetsorgan på IKT-området. Direktoratet for e-helse etableres med utgangspunkt i divisjon for e-helse i Helsedirektoratet, og er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Som fagdirektorat skal Direktoratet for e-helse ha en tydelig nasjonal myndighet og premissgiverrolle på IKT-området i helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet skal ivareta en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring og nasjonal samordning i en samlet helse- og omsorgssektor. Myndighetsrollen skal styrkes gjennom utvikling av nye modeller for bruk av økonomiske og regulerende virkemidler. Direktoratet skal ha ansvar for styring, gjennomføring og forvaltning av nasjonale løsninger på e-helseområdet, forvaltning og utvikling av kodeverk, terminologi og IKT-standarder, samt gjennomføring av nasjonale utredningsoppdrag og situasjonsanalyser innenfor e-helse.
Folkehelseinstituttet	Folkehelseinstituttet (FHI) arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet. Instituttet overvåker folkehelsesituasjonen i landet, herunder utviklingen av smittsomme sykdommer og er databehandlingsansvarlig for 10 sentrale helseregistre. Instituttet leverer en rekke tjenester som vaksineinnkjøp og -distribusjon, og rettsmedisinske oppdrag. De har også et nasjonalt rådgiveransvar overfor Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Helsetilsynet	Statens helsetilsyn er den sentrale tilsynsmyndighet for helse- og omsorgstjenesten, og driver både planlagt tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (systemrevisjon) og behandling av enkeltsaker med spørsmål om svikt i helse- og omsorgstjenesten. Slike enkeltsaker kan bli satt i gang på grunnlag av klager fra pasienter, brukere, medieoppslag, henvendelser fra andre deler av helse- og omsorgstjenesten og lignende. Helsetilsynet i fylkene (tidligere fylkeslegene) skal ivareta disse tilsynsoppgavene både i enkeltsaker og på systemnivå. Administrativt er Helsetilsynet i fylkene tilknyttet fylkesmennene (jf. omtale ovenfor), men underordnet Statens helsetilsyn i tilsynssaker. Fylkesmannen fører tilsyn og behandler klagesaker overfor helsepersonell og helse- og omsorgstjeneste innenfor eget fylke. Helsetilsynet har sanksjonsmulighet (advarel, tilbakekalle eller begrense autorisasjon, straff) overfor helsepersonell. Helsetilsynet vurderer ikke økonomiske forhold og økonomisk erstatning.
Legemiddelverket	Statens legemiddelverk (SLV) er det nasjonale forvaltnings- og tilsynsorgan på legemiddelområdet og skal bidra til at målene for legemiddelpolitikken og refusjonsområdet blir oppfylt. Legemiddelverkets oppgaver omfatter blant annet utredning av kvalitet, sikkerhet og effekt ved godkjenning av legemidler, godkjenning av produktinformasjon, bivirkningsovervåking, kvalitetskontroll og tilsyn med aktører i legemiddelforsyningskjeden. Videre inngår veiledning om riktig legemiddelbruk. Legemiddelverket er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og fører tilsyn med produksjon, utprøving og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig faglig og økonomisk legemiddelbruk, blant annet gjennom vedtak om opptak av legemidler for forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Norsk pasientskade-erstatning	Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og behandler erstatningskrav for pasienter som er blitt påført skade etter behandlingssvikt i den offentlige eller den private helse- og omsorgstjenesten. Stadig flere pasientgrupper er blitt inkludert i ordningen og i dag håndterer NPE bortimot alle krav om erstatning for personskaade som blir rettet mot både offentlig og privat helse- og omsorgstjeneste. I 2014

	utbetalte NPE over 1 milliard kroner i erstatninger til de 1504 søkerne som fikk medhold i sin sak.
Pasient- og brukerombud	Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet skal bidra til å bedre kvaliteten i tjenestene. Ombudene er uavhengige, men er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Det finnes et ombud i hvert fylke, med unntak av i Hedmark og Oppland som har et samlet. I 2014 var det over 14.000 henvendelser til pasient- og brukerombudene (39). Nærmere 18 prosent av henvendelsene i 2014 var knyttet til «Pasientskade og komplikasjon». Det var en stor andel henvendelser knyttet til venting, mangelfulle rutiner, systemsvikt og diagnoseproblematikk. Hver sak kan omfatte problemstillinger knyttet til flere tjenestesteder. Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven. (40)
Nasjonalt klageorgan	Fra 1.1.2016 vil det opprettes et nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Klageorganet vil være en sammenslåing av sekretariatene for blant annet pasientskadenemnda, klagenemnda for behandling i utlandet, preimplantasjonsdiagnostikknemnda og statens helsepersonellnemnd. I tillegg vil relevante klagesaker som i dag behandles i Helsedirektoratet og Helfo flyttes til det nye klageorganet.
Fylkesmannen	Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke, og skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer ved at Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene samt overvåker kommunenes virksomhet. Fylkesmannen skal medvirke til samarbeid og ansvarsavklaring mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer. Fylkesmannen er klageinstans for pasienter og brukere som mener de ikke har fått de helse- og omsorgstjenestene de har krav på. Videre behandler Fylkesmannen søknader om dispensasjon fra helsekravene for førerkort. (41)
Kontrollkomisjon psykisk helsevern	Kontrollkomisjonene innen det psykiske helsevernet har som hovedoppgave å ivareta pasientenes rettssikkerhet ved å sikre at det ikke skjer uriktig frihetsberøvelse og tvangsbruk. (42) Kommisjonen har som oppgave å behandle klager og føre kontroll med institusjonene ved blant annet jevnlige besøk. Bortsett fra vedtak om tvangsbehandling, som kan påklages til fylkesmannen, er kontrollkommisjonen den viktigste klageinstansen innen det psykiske helsevernet. Kontrollkomisjonene skal føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes, og alle institusjoner innen det psykiske helsevernet har en kontrollkomisjon knyttet til seg. Institusjonen som foretar tvangsinnleggelse skal sende kommisjonen kopi av vedtak om videre undersøkelse eller tvungent psykisk helsevern og de dokumenter vedtaket bygger på. Kontrollkommisjonen er et uavhengig, domstolslignende organ. Det finnes ca. 60 kontrollkommisjoner i landet.
Norsk Helsenett	Norsk Helsenett (NHN) er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Foretakets oppdrag er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. Norsk Helsenett drifter også nasjonale løsninger som bl.a. helsenorge-plattformen, nasjonal kjernejournal og helseadministrative registre, samt andre løsninger og registre for sektoren. I tillegg har de opprettet et testsenter for hele helse- og omsorgssektoren. Norsk Helsenett har en operativ rolle i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet i sektoren. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal styrkes, og som et ledd i dette oppgraderes HelseCSIRT fra 2016 til HelseCERT (Computer Emergency Response Team). HelseCERT skal spre kompetanse om IKT-trusler og beskyttelsesmekanismer, og kontinuerlig overvåke trafikken i helsenettet.

Aktører utenfor helse- og omsorgssektoren

En rekke aktører samarbeider eller interagerer med helse- og omsorgstjenesten på ulike måter. Disse aktørene kan bruke helsedata på individnivå som deler av sitt datagrunnlag i saksbehandling eller liknende, men da i virksomhet som ligger utenfor den ytende helse- og omsorgstjenesten. Noen av

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

disse aktørene kan også tenkes å registrere enkelte opplysninger som ligger nært opp til, eller kan klassifiseres som, helseopplysninger, slik som politiet og barnevernsmyndigheter.

I denne gruppen ligger interessenter også som antas å kunne ha behov og nytte av helseinformasjon og helserelaterte data for beslutninger innenfor andre sektorer, eksempelvis innretning og dimensjonering av offentlige tjenestetilbud som barnehage, skole, idrettstilbud mv. Disse kan også sies å ha en forebyggende rolle i kraft av sine beslutninger, og grenser også til kategorien «styrer, monitorerer og forebygger».

Figur 24. Aktører på ulike måter interagerer eller samarbeider med helse- og omsorgstjenesten

Aktør	Beskrivelse
NAV	NAV fattar vedtak om blant annet yrkesskade, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, samt hjelpemidler og andre tjenester for innbyggere med ulike helseproblemer. Innbygger søker selv om disse tjenestene, men søknad må oftest inneholde dokumentasjon eller uttalelse fra fastlege, psykolog, spesialist eller annet relevant helsepersonell. NAV mottar også sykmelding fra fastlege og annet helsepersonell med rett til å sykmelde. Arbeidet med oppfølging av sykmeldte kan involvere både helse- og omsorgstjenesten (særlig fastlege), arbeidsgiver og NAV. <u>Hjelpemiddelsentral</u>: Det finnes hjelpemiddelsentraler i hvert fylke. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.
Skole og barnehage	Barn med funksjonshemminger, sjeldne diagnoser og andre tilstander kan ha behov for hjelp i skole og barnehage, og elevenes rett til helsehjelp reguleres i en rekke lover, forskrifter og skriv. Behovene kan variere fra svært store hjelpebehov til behov for lett tilrettelegging eller påminning om gjøremål. Skole og barnehage må derfor tilegne seg kunnskap om diagnose og eleven gjennom skriftlig og muntlig dialog med elev og foresatte og eventuelt tjenesteapparatet som kjenner eleven (43). <u>Logoped eller audiopedagog</u>: Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring har rett til tilbud om logoped eller audiopedagog fra kommunen. Fylkeskommunen har plikt til å tilby slik hjelp til ungdom i videregående skole. Helfo kan gi stønad til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped eller audiopedagog etter folketrygdloven, dersom det offentlige ikke yter stønad etter opplæringsloven, kommunehelsetjenesteloven eller spesialisthelsetjenesteloven. (44) Behandling fra logoped og audiopedagog inngår i mange tilfeller som en del av behandling eller etterbehandling av et helseproblem. De inngår ofte i tverrfaglige team, blant annet i forbindelse med slagrehabilitering og opplæring i forhold til hørselsdefekter, både i regi av spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Barnevern	Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansaret og arbeidsoppgavene til barnevernsmyndighetene er regulert i barnevernloven med forskrifter. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste. Barneverntjenesten skal gi råd og rettledning, gjøre undersøkelser, gjøre vedtak etter loven og iverksette og følge opp saker. Alle som arbeider i det offentlige har lovpålagt plikt til å kontakte barnevernet dersom de er alvorlig bekymret for et barn. Bekymringsmeldinger kan blant annet komme fra helsestasjoner, sykehus og tannleger. Barneverntjenestens undersøkelser vil ofte omfatte sakkyndig undersøkelse og innhenting av informasjon fra disse og andre instanser. (45)
PP-tjeneste	Hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den skal også sørge for at det blir gjort en sakkyndig vurdering i de tilfeller der loven krever det. PP-tjenesten skal arbeide systemrettet og bistå barnehager og skoler med å sikre at alle

	barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. PP-tjenesten samarbeider ofte med fastlege, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, helsestasjon, habiliteringsavdeling og barnevernet, samt logoped. (46)
Politi	Politiet har samarbeid med helse- og omsorgstjenesten for vurdering og erklæringer av personskader i ulike typer saker. Det er samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og politiet i psykisk helsevern og rus. Det er helse- og omsorgstjenestens ansvar å yte helsehjelp, men politiet har imidlertid plikt til å hjelpe personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv. Politiet og helse- og omsorgstjenesten har i visse tilfeller varslingsplikt overfor hverandre. Politiet har også plikt til å yte nødvendig bistand til helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med tvungen psykisk helsevern, tvangsinnleggelse etc. Politiet har også plikt til å hjelpe eller sørge for hjelp til personer de kommer i kontakt med som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og som ikke ivaretas av andre. Det betyr at politiet skal varsle lege når det er grunn til å anta at legehjelp kan være nødvendig. Statens Barnehus er opprettet i ti ulike politidistrikter som et tilbud til barn og ungdom som er eller kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming eller som er særlig sårbare, samt ungdom som kan ha vært utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Politiet er ansvarlig for Barnehusene, og spesialisthelsetjenesten bistår med medisinske undersøkelser. Dokumentasjon av disse følger pasientjournalforskriften. Lokal legevakt og fastlege er også ofte involvert, siden de ofte er de som først tar imot fornærmede. (47)
Utlendingsforvaltningen	Helse- og omsorgstjenesten i vertskommunen er forpliktet til å sørge for nødvendig helsehjelp til asylsøkere, flyktninger og familiegjennforente, jf. helse- og omsorgstjenesteloven.
Skatteetaten	Skatteetaten er bl.a. ansvarlig for det sentrale folkeregisteret. Helse- og omsorgssektoren har behov for oppdaterte opplysninger om innbyggere og pasienter, blant annet kontaktinformasjon og familierelasjoner. Helse- og omsorgssektoren er også ansvarlig for å melde fødsler og dødsfall i Norge til folkeregisteret.
Andre tilsynsorganer	Ulike tilsynsorganer utenfor helse- og omsorgssektoren har tilsyn med forskjellige deler av helse- og omsorgstjenestens virksomheter. De viktigste er: • <i>Arbeidstilsynet</i>, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, har tilsyn med etterlevelse av arbeidsmiljøloven, pålagte HMS-tjeneste, verneutstyr, farlige kjemikalier og andre områder knyttet til arbeidsmiljøet. • <i>Mattilsynet</i>, underlagt Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet, har tilsyn med mattrygghet, blant annet innenfor institusjoner, samt med reseptfrie legemidler som er tillatt solgt utenfor apotek. • <i>Datatilsynet</i>, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har tilsyn med personopplysningsloven og personvern. • <i>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap</i>, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, har tilsyn med brann- og el-sikkerhet samt med elektromedisinsk utstyr. • <i>Difi</i>, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har tilsyn med universell utforming av IKT.
Forsikrings-selskaper	Forsikringsselskaper tilbyr ulike helseforsikringer. Innbyggere som tegner helseforsikringer må oftest fylle ut egenerklæringsskjemaer, samt samtykker til at selskapene innhenter komplette journalopplysninger fra helse- og omsorgstjenesten. Ved sykdom eller skade har forsikringsselskapene samtykke fra pasienten til å innhente komplette journalopplysninger. Det har vært en økning i antall personer som tegner behandlingsforsikring, som gir den forsikrede tilgang til privat helsehjelp. I all hovedsak er det private tjenesteleverandører som benyttes for å gi kundene helsehjelpen de har krav på i forsikringen. Leverandørene som benyttes er lokalisert både i Norge og utlandet.

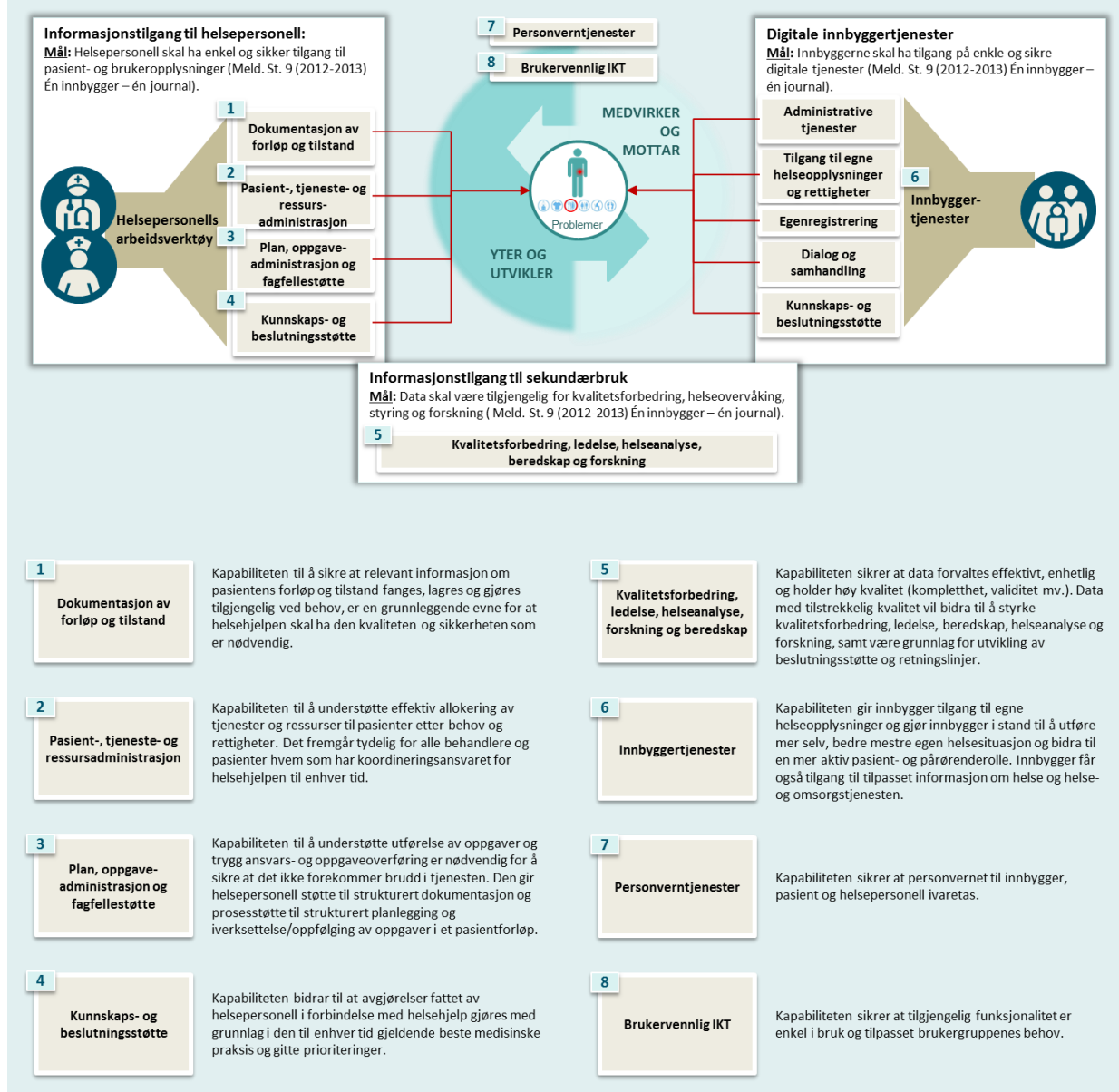
2 E-helsekapabiliteter

2.1 Innledning

Dette kapitlet beskriver de e-helsekapabiliteter som er sentrale for å understøtte virksomhetskapabiliteter som er beskrevet i kapittel 1. En e-helsekapabilitet er et sett av egenskaper ved en løsning (bestående av få eller mange systemer) og beskriver den funksjonalitet som på et overordnet nivå understøtter virksomhetskapabilitetene som dekkes av tiltaket.

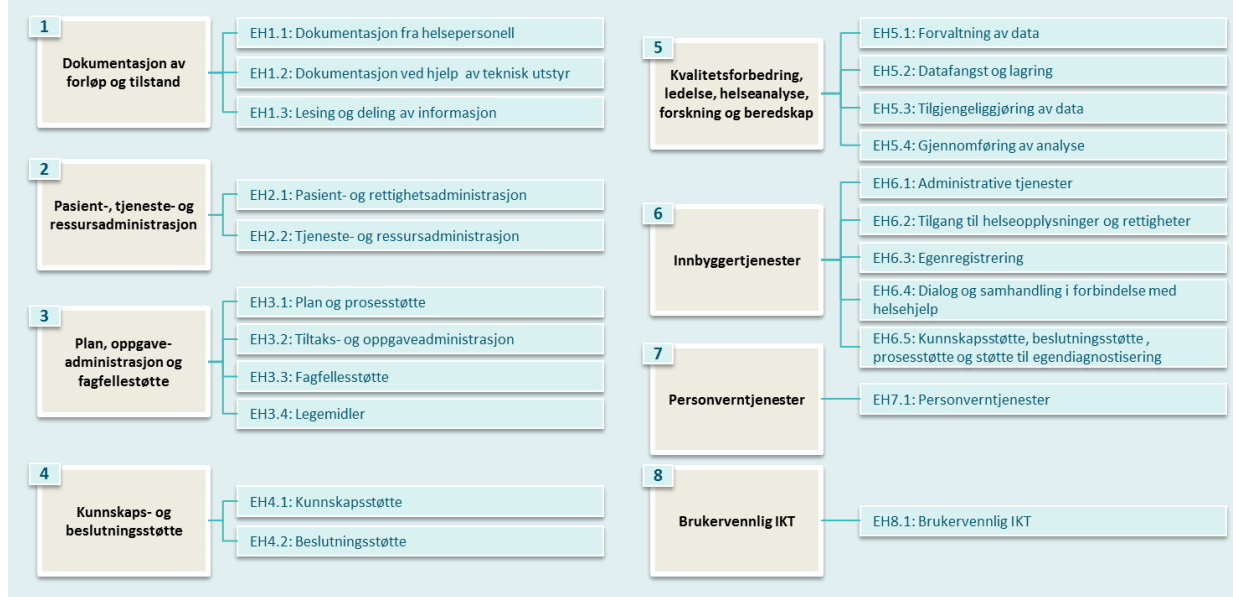
Det er for dette tiltaket definert åtte e-helsekapabiliteter. Sammenheng mellom de helsepolitiske mål definert i Meld. St. 9 og e-helsekapabilitetene er illustrert i Figur 25.

Figur 25. E-helsekapabilitetene og deres sammenheng med målene i Meld. St. 9 «En innbygger – én journal»



Under hver e-helsekapabilitet er det, som vist i Figur 26, definert et sett med underkapabiliteter som til sammen utgjør e-helsekapabiliteten.

Figur 26. E-helsekapabiliteter med underkapabiliteter



2.2 E-helsekapabilitet 1: Dokumentasjon av forløp og tilstand

Kapabiliteten til å sikre at relevant informasjon om pasientens forløp og tilstand fanges, lagres og gjøres tilgjengelig ved behov. Dette er en grunnleggende evne for at helsehjelpen skal ha den kvaliteten og sikkerheten som er nødvendig, gjennom bedre *administrativ* og *informativ kontinuitet* (jf. definisjoner i boks).

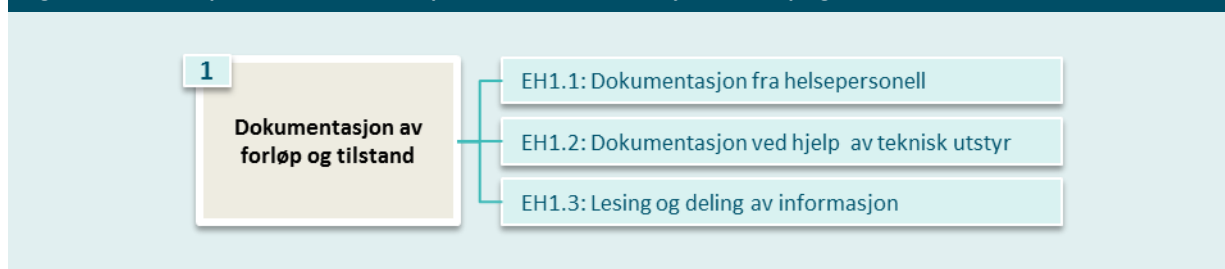
Kapabiliteten dekker alle registrerte helserelaterte opplysninger, enten de registreres av helsepersonell eller andre som yter helsehjelp, medisinsk-teknisk utstyr, innbyggeren selv eller pårørende. Innbyggers egenregistrering beskrives i kapittel 2.7.3. Det sentrale formålet med e-helsekapabilitet 1 er å understøtte helsepersonells kliniske tankeprosesser, hypotesedannelse og dokumentasjonsplikt, samt for i ettertid å kunne gjenskape et hendelsesforløp.

Administrativ kontinuitet:
Formidling av informasjon på tvers av for eksempel institusjonelle grenser.

Informativ kontinuitet:
Å ha relevant informasjon tilgjengelig til enhver tid slik at man kan ivareta omsorg og behandling for den enkelte pasient.

Relasjonell kontinuitet:
Det terapeutiske forholdet mellom pasienten og én eller flere helsepersonell. (50)

Figur 27. E-helsekapabilitet med underkapabiliteter: Dokumentasjon av forløp og tilstand



2.2.1 EH1.1: Dokumentasjon fra helsepersonell

Funksjonalitet EH1.1.1: Registrering av informasjon

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell tilgang til å kunne registrere, redigere og slette informasjon på en enhetlig måte, og i henhold til sine roller og tilganger.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.1.1.1	Samme informasjon registreres kun én gang. Relevant informasjon er tilgjengelig fra tidligere registreringer, registrert av pasient eller tilgjengelig fra automatisk registrering fra teknisk utstyr. Helsepersonell og pasient vurderer hva som er relevant å registrere på nytt.
EH1.1.1.2	Alle helseproblemer som pasienter angir eller som på annen måte er påvist, skal kunne dokumenteres. I tillegg skal dokumentasjon av normaltilstander, slik som graviditet, støttes. Forskjellige typer forebygging hos innbyggere, slik som spedbarnskontroller og screeningprogrammer, samt spesiell oppfølging av risikogrupper, må støttes.
EH1.1.1.3	Informasjon skal kunne eksistere med ulik status (foreløpig, ferdig, godkjent). Det må i så fall tydelig fremkomme hvilken status registreringene har, slik at det ikke oppstår misforståelser. Kontrasignering vil kunne forekomme ved at erfarne spesialister går gjennom informasjonen til mindre erfarne. En del informasjon registreres uten status, og det er da ikke noen godkjenningsrutine.
EH1.1.1.4	Status på informasjonen bestemmer hvorvidt informasjon kan endres/slettes. Status på dokument eller informasjon (foreløpig, ferdig, godkjent) avgjør hvilke muligheter det er for redigering og sletting. Endringer skal kunne gjenskapes, også etter at status har vært godkjent.
EH1.1.1.5	Informasjonen organiseres, så langt det er hensiktsmessig, i maler for å understøtte strukturering og/eller standardisering av dokumentasjonsprosessen. For strukturering og/eller standardisering av informasjonen støttes dokumentasjonsprosessen med eksempelvis maler, fraser, terminologi, kodeverk og forhåndsdefinerte skjemaer/tabeller (ev. med faste svaralternativer til eksempelvis strukturerte kartlegginger innen BUP/psykiatri, ernæringskartlegging mv.)
EH1.1.1.6	Informasjon skal kunne avgis gjennom fritekst der malene ikke gir tilstrekkelig støtte. Informasjon kan også ved behov registreres ved å skrive fritekst (ev. via talegjenkjenning). Det bør vurderes om Natural Language Processing (eller lignende teknologi) kan brukes for å transformere tekst til standardisert/strukturert informasjon.
EH1.1.1.7	Informasjon fra mange mediatyper inngår som en del av dokumentasjonen. Film/video, bilder, lydopptak og overføring fra ulikt teknisk utstyr.
EH1.1.1.8	Støtte for grafisk dokumentasjon. Det er støtte for grafisk fremstillinger av målinger og annen dokumentasjon, f.eks. partogram i fødesystemer, skjematisk tegning av tenner inkl. ev. fyllinger.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Funksjonaliteten understøtter helsepersonells ytelse av helsehjelp ved å samle informasjon fra helsepersonellens kliniske arbeidsprosesser, hypotesedannelse.
- Funksjonaliteten legger til rette for utførelse av helsepersonells dokumentasjonsplikt som er et normativt krav (jf. § 39 i Lov om helsepersonell).
- Funksjonaliteten legger til rette for å kunne gjenskape hendelsesforløp på en sikker måte der det oppstår slike behov.
- Funksjonaliteten legger til rette for at strukturert dokumentasjon kan hentes ut til sekundærformål.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Rolle- og tilgangsstyring for helsepersonell.
- Standardisering og strukturering av informasjon.

Funksjonalitet EH1.1.2: Kode støtte

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell avansert støtte til å velge og angi korrekte koder.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.1.2.1	Kode støtte for valg av diagnoser, prosedyrer og takster. Det skal være verktøy som foreslår korrekte diagnosekoder. Disse benyttes blant annet i forbindelse med innsatsstyrt finansiering.
EH1.1.2.2	Kode støtte for valg av rett begrep og synonym. Det skal være verktøy som understøtter valg av rett begrep og synonym ved ordinær dokumentasjon (strukturert og standardisert). Forståelsen/definisjonen av termen må være korrekt, slik at neste behandlingsledd forstår det samme som forrige.
EH1.1.2.3	Beslutningsstøtte ved koding. Beslutningsstøtte ved koding vil bruke tilgjengelig informasjon i pasientjournalen for å gi råd om hvilken hoveddiagnose og hvilke underdiagnoser pasienten får. Beslutningsstøtte understøtter koding av undersøkelser, behandling og pleie der det finnes separate kodeverk.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidra til felles forståelse av pasientinformasjon på tvers av helsetjenestenivåer og helsepersonellgrupper, og til standardisering av informasjonselementene.
- Økt bruk av korrekte koder som gir bedre datagrunnlag for styring, forskning og kvalitetsforbedring.
- Bedre kode støtte forenkler og effektiviserer helsepersonells hverdag.
- Forbedret datagrunnlag for all offentlig helseinformasjon om sykdomsforekomst i befolkningen.
- Funksjonaliteten skal redusere feil koding. Flere revisjoner (RR 2008, RHF 2011) viser at om lag 66 % av kodene som er anført på hoveddiagnosenivå er riktig.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Felles sett av kodeverk og terminologier med utviklet beslutningsstøtte for brukere.

2.2.2 EH1.2: Dokumentasjon ved hjelp av teknisk utstyr

Funksjonalitet EH1.2.1: Multimediadokumentasjon

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at helseopplysninger i form av lyd-, bilde- og videofiler kan registreres der dette er relevant dokumentasjonsform.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.2.1.1	Lagring og forvaltning av multimediadokumentasjon. Dokumentasjonen kan skje innenfor gitte standarder direkte i løsningen eller integrerte spesialistsystemer.
EH1.2.1.2	Kobling til pasientens problemliste. Fremstillingen er knyttet til pasientens problemliste og kan derfor filtreres og grupperes slik at det som er relevant for det enkelte helsepersonell fremkommer.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Lyd, bilde eller video kan i en del sammenhenger gi en god beskrivelse av situasjon/forløp/tilstand og brukes i økende grad som en del av løpende dokumentasjon.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte tekniske grensesnitt for fremstilling og tilkobling av informasjon fra multimediautstyr.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Funksjonalitet EH1.2.2: Automatisk datafangst fra teknisk utstyr som brukes i forbindelse med helsehjelp

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å integrere med medisinsk-teknisk utstyr (MTU) og annet teknisk utstyr som brukes i forbindelse med helsehjelp, samt for å utnytte data generert av utstyret som en del av dokumentasjon av forløp/tilstand. Dette omfatter også utvalgt hjemmebasert MTU, personnære enheter og velferdsteknologi.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.2.2.1	Støtte for dokumentasjon i medisinsk-teknisk utstyr. Inkludert generering av rapporter slik som i hjerteultralydmaskiner, spirometriapparater o.l. Informasjonen må kunne lagres som rådata som kan rekonstrueres ved behov. Lagrede data må i størst mulig grad kunne bearbeides og rapporteres i strukturert form.
EH1.2.2.2	Lagring og forvaltning av informasjon innhentet fra teknisk utstyr som brukes i forbindelse med helsehjelp. Informasjon som innhentes fra teknisk utstyr som brukes i forbindelse med helsehjelp (digitalt røntgenutstyr, ultralydutstyr og annet.) skal kunne brukes som en integrert del av journalen (uten behov for utskrift og skanning). De samme regler for status gjelder som anneninformasjonen registrert av helsepersonell.
EH1.2.2.3	Kobling til pasientens problemliste. Informasjon som innhentes fra teknisk utstyr knyttes til pasientens problemliste og kan filtreres og grupperes.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

Avansert medisinsk-teknisk utstyr som overvåkingsutstyr, infusjonspumper, anesthesiapparater, respiratorer mv. samler mye informasjon om pasient som i dag ofte ikke samles, eventuelt dokumenteres på papir. Ved å integrere og samle inn data fra denne type utstyr vil en rekke behov kunne dekkes:

- Dokumentasjonsbehovet for helsepersonell reduseres. Unngå tidkrevende manuell dobbeltregistrering.
- Data kan gjenbrukes blant annet som grunnlag for beslutningsstøtte og til rapportering/forskning.
- Gi bedre datagrunnlag fordi innsamling kan forgå løpende istedenfor punktmåling eller manuell oppfølging av helsepersonell.
- Bidrar til bruk i avansert beslutningsstøtte.
- Bidrar til en papirløs helse- og omsorgstjeneste.
- Gi innbyggere og helsepersonell en samlet tilgang til relevante helseopplysninger for bedre beslutningsgrunnlag.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte tekniske grensesnitt for tilkobling og lagring av informasjon fra teknisk utstyr.
- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Retningslinjer for hvilket utstyr som skal integreres og hvilke data som skal overføres til løsningen.
- Standardiserte kodeverk og terminologier legges til grunn for integrasjonene.
- Løsningen skal følge Continua Health Alliance sitt standardiseringsrammeverk der det er påkrevd, bl.a. for velferdsteknologi.

Funksjonalitet EH1.2.3: Automatisk utveksling av data med spesialistsystemer

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Informasjon fra integrerte spesialistsystemer kan utnyttes som en del av dokumentasjon av forløp/tilstand.

Hvilke egenskaper funksjonaliteten har

EH1.2.3.1	Lagring og forvaltning av informasjon innhentet fra spesialistsystemer. Informasjon som innhentes fra spesialistsystemer skal kunne brukes som en integrert del av journalen. De samme reglene for status skal gjelde for denne informasjonen som for helseopplysninger registrert av helsepersonell.
EH1.2.3.2	Kobling til pasientens problemliste. Informasjon som innhentes fra spesialistsystemer knyttes til pasientens problemliste og kan filtreres og grupperes
EH1.2.3.3	Synkronisering av den samlede helseinformasjonen Endringer av informasjon som er lagret i spesialistsystemet og i dokumentasjonssystemet synkroniseres slik at informasjonsinnholdet er reflektert.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

Det er spesialiteter som genererer dokumentasjon fra medisinsk-teknisk utstyr slik som EKG, EEG og andre nevrofysiologiske undersøkelser, kardiofysiologiske målinger, ultralyd og lignende. Felles for systemene er at de inneholder spesifikk dokumentasjon. Ved å implementere denne funksjonaliteten realiseres følgende behov:

- Gi innbyggere og helsepersonell en samlet tilgang til relevante helseopplysninger for bedre beslutningsgrunnlag.
- Dokumentasjonen for helsepersonell forenkles og man unngår manuell dobbeltregistrering.
- Reduksjon av avskriftsfeil som reduserer pasientsikkerheten.
- Data kan gjenbrukes blant annet som grunnlag for beslutningsstøtte og til rapportering/forskning.
- Gi bedre datagrunnlag fordi innsamling kan forgå løpende i stedet for punktmåling eller annen manuell oppfølging.
- Understøtter målet om en papirløs helse- og omsorgstjeneste.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte kodeverk og terminologier legges til grunn for integrasjonene.

Funksjonalitet EH1.2.4: Automatisk utveksling av data med medisinsk service

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å kunne utnytte informasjon registrert i systemer for medisinsk service (røntgen og laboratorier) som en del av dokumentasjon av forløp/tilstand.

Hvilke egenskaper funksjonaliteten har

EH1.2.4.1	Lagring og forvaltning av informasjon innhentet fra medisinsk service. Informasjon som innhentes fra medisinsk service skal kunne brukes som en integrert del av journalen. De samme reglene for status skal gjelde for denne informasjonen som for helseopplysninger registrert av helsepersonell.
EH1.2.4.2	Kobling til pasientens problemliste. Informasjon som innhentes fra medisinsk service knyttes til pasientens problemliste og kan filtreres og grupperes.

EH1.2.4.3	Synkronisering av informasjon mellom medisinsk service og hoveddokumentasjonen. Endringer av informasjon som er lagret i systemer knyttet til medisinsk service og i dokumentasjonssystemet synkroniseres slik at systemene inneholder identisk informasjon. Informasjonen i systemer knyttet til medisinsk service er autorativ kilde for slik informasjon.
------------------	--

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Strukturerte data gjenbrukes som grunnlag for beslutningsstøtte.
- Informasjonen er tilgjengelig og «mistes» ikke.
- Gir oversikt over undersøkelser og prøver som er foretatt slik at disse kan vurderes for gjenbruk.
- Bidrar til målet om et papirløst sykehus.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte kodeverk og terminologier ligger til grunn for integrasjonene.

Funksjonalitet EH1.2.5: Automatisk datafangst fra lokaliseringssensorer

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å integrere sensorer som lokaliserer pasienters, personells eller utstyrs plassering i sykehus, omsorgssenter, hjem mv.

Hvilke egenskaper funksjonaliteten har

EH1.2.5.1	Lagring og forvaltning av informasjon innhentet fra lokaliseringssensorer på pasienter. Informasjon som innhentes fra lokaliseringssensorer kunne brukes som en integrert del av løsningen. De samme reglene for status skal gjelde for denne informasjonen som for helseopplysninger registrert av helsepersonell.
EH1.2.5.2	Kobling til pasientens lokasjonsliste. Informasjon som innhentes fra en pasients lokaliseringssensor knyttes til pasientens lokasjonsliste og kan derfor filtreres og grupperes. Krav til samtykke, ev. tvangsvedtak ivaretas.
EH1.2.5.3	Lagring og forvaltning av informasjon innhentet fra lokaliseringssensorer på personell. Informasjon som innhentes fra lokaliseringssensorer kunne brukes som en integrert del av løsningen.
EH1.2.5.4	Lagring og forvaltning av informasjon innhentet fra lokaliseringssensorer på utstyr. Informasjon som innhentes fra lokaliseringssensorer kunne brukes som en integrert del av løsningen.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Unngå manuell dokumentasjon.
- Dokumentere informasjon som i dag ikke finnes.
- Unngå misforståelser mht. hvor pasienten er.
- Sporing av helsepersonell for å studere arbeidsprosesser, bedre beredskap og varsling i akutte situasjoner.
- Sporing av utstyr for å slippe leting etter utstyr.
- Smittesporing: Spore smittet pasient og kontakter/personell samt lokasjoner.
- Økt grad av trygghet, mestring og frihet for personer med demens eller annen kognitiv svikt. GPS-sporing kan være en slik mekanisme.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Tekniske grensesnitt.
- Standardiserte kodeverk og terminologier.
- Retningslinjer for hvilke data som skal overføres til løsningen.
- Regelverk som sikrer samtykke fra pasienter og personell om løpende registreringer.

2.2.3 EH1.3: Lesing og deling av informasjon

Funksjonalitet EH1.3.1: Samlet tilgang til relevant informasjon

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell som skal yte helsehjelp en samlet tilgang til helseopplysninger som er nødvendige for å kunne yte helsehjelpen på en forsvarlig måte.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.3.1.1	Oversiktlig fremstilling av relevant informasjon. Det er enkelt å finne frem til relevant informasjon.
EH1.3.1.2	Søkefunksjonalitet. Det er støtte for å gjøre søk – både enkle med én søkeparameter, og mer avanserte med flere søkeparametere.
EH1.3.1.3	Støtte for grafisk fremstilling. Det er støtte for grafisk fremstillinger av målinger og annen dokumentasjon, f.eks. partogram i fødesystemer, skjematisk tegning av tenner inkl. ev. fyllinger.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Et helhetlig informasjonsgrunnlag om pasienten gir bedre beslutningsgrunnlag for behandler og bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet.
- Spart tid grunnet redusert tid til å lete etter informasjon og redusert antall gjentatte undersøkelser på grunn av manglende oppdateringer og kunnskap om hva som faktisk er gjort.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Rolle- og tilgangsstyring for helsepersonell.
- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Muligheter for kommunikasjon med andre løsninger iht. lovverk for deling av informasjon.

Funksjonalitet EH1.3.2: Rolletilpasset fremstilling av relevant informasjon

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å fremstille relevant informasjon på en måte som er tilpasset brukerens tjenstlige behov. Helsepersonell har ulike behov ut fra tjenstetype, deres profesjon og rolle, og hva som er relevant informasjon for den enkelte vil variere. Et enkelt helsepersonell kan ha flere roller, slik som en fastlege som også er kommuneoverlege, sykehjemslege og tar legevakter.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.3.2.1	Helsepersonellens rolle i en konkret situasjon styrer fremstilling av informasjon. Hvilken informasjon som tilgjengeliggjøres og hvordan det fremstilles, styres av aktuell problemstilling, samt hvilken rolle det enkelte helsepersonell har i forhold til problemstillingen. Det som er mest relevant for vedkommende vises først, samtidig som det tydelig fremkommer hvordan man kan få opp mer utfyllende informasjon.
-----------	--

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

En samlet fremstilling av all relevant informasjon kan bli uoversiktlig fordi informasjonsmengden kan være stor. En fremstilling som er tilpasset den enkelte helsepersonellrolles behov vil bidra til:

- Bedre beslutningsgrunnlag, økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet.
- Spart tid grunnet redusert tid til å lete etter informasjon i løsningen.
- Bedre administrativ og informativ kontinuitet (jf. definisjoner s. 50).

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Rolle- og tilgangsstyring for helsepersonell iht. lovregulering.
- Beskrivelse og tilgang til alle relevante roller.
- Standardisering og strukturering av informasjon.

Funksjonalitet EH1.3.3: Gruppering av relevant informasjon, blant annet problemorientert

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for sortering, filtrering og gruppering av informasjonen på bakgrunn av én eller flere parametere.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.3.3.1	Informasjon kan sorteres, filtreres og grupperes på bakgrunn av informasjonens kobling til pasientens problemliste (problemorientert). Et informasjonselement er koblet mot ett eller flere helseproblemer i pasientens problemliste. Dette inkluderer pasientens funksjonstap/restressurser, behov for tjenester.
EH1.3.3.2	Informasjon kan sorteres, filtreres og grupperes kronologisk (tidslinje). Tidsregistreringstidspunkt for å se informasjon registrert nylig eller på et annet spesifikt tidspunkt. Tidslinje for å følge utvikling over tid for ett eller flere områder (se 1.3.4).
EH1.3.3.3	Informasjon kan sorteres, filtreres og grupperes på bakgrunn av informasjonens kritikalitet. Løsningen gjenkjenner, basert på kodeverk, kritisk informasjon som registreres i journalen, slik at denne informasjonen merkes og vises som kritisk informasjon. Helsepersonell kan også selv merke registrert informasjon som kritisk.
EH1.3.3.4	Informasjon kan sorteres, filtreres og grupperes på bakgrunn av informasjonstype. Eksempelvis henvisning, rekvisisjon, søknad, epikrise, prøvesvar, vedtak, daglige notater/forløpsnotater, skjemafelt, lyd, bilde, video.
EH1.3.3.5	Informasjon kan sorteres, filtreres og grupperes på bakgrunn av personen som har registrert informasjonen. Dersom det er ulike personer som har registrert informasjonen og godkjent den registrerte informasjon, vil informasjonen kunne systematiseres på bakgrunn av de enkelte rollene. Informasjonen kan også systematiseres på bakgrunn av personens organisasjonstilhørighet (virksomhet, avdeling).

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

En samlet fremstilling av all relevant informasjon kan bli uoversiktlig fordi informasjonsmengden kan være stor. Funksjonalitet for sortering, filtrering og gruppering av informasjonen gjør at det enkelte helsepersonell kan systematisere informasjonen med tanke på de beslutningene vedkommende skal ta i en spesifikk situasjon, og vil dermed bidra til:

- Bedre beslutningsgrunnlag og bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet.
- Spart tid grunnet redusert tid til å lete etter informasjon i løsningen.

Filtrering på bakgrunn av informasjonens kobling til pasientens problemliste, vil kunne gi økt mulighet for konfidensialitet ved at informasjon som ikke er relevant for en aktuell problemstilling ikke er tilgjengelig.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Rolle- og tilgangsstyring for helsepersonell.
- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Registrert informasjon må være koblet til relevante parametere (metadata).
- Felles kodeverk over informasjonsklasser som regnes som kritiske.
- Oversikt om den enkelte helsepersonellrolles organisasjonstilhørighet.

Utredning av «Én innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Funksjonalitet EH1.3.4: Fremstilling av informasjon som funksjon av tid (tidslinjer)

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å strukturere informasjon som en funksjon av tid for å følge utvikling over tid for ett eller flere områder, eksempelvis en kurve. All strukturert pasientinformasjon kan i prinsippet fremstilles som funksjon av tid.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.3.4.1	Gjennomgående kurve. Konsistent tilgjengeliggjøring av pasientinformasjon som funksjon av tid, uavhengig av informasjonens tilknytning til lokasjon og tid.
EH1.3.4.2	Tidslinjer med ulik detaljeringsgrad (dybde). Det er støtte for visning av tidslinjer på ulike detaljeringsnivå – fra tidslinjer, ofte i form av kurver, med en «oppløsning» på minuttintervaller opptil et skift (8 timer) om gangen, til mer overordnede tidslinjer som viser dager, måneder eller flere år samtidig. En overordnet tidslinje vil være et sentralt element i fremstillingen av et samlet behandlingsforløp eller en behandlings-/tiltaksplan, da ofte som en samlet kontaktlinje. En kontakt representerer en hendelse, eksempelvis en konsultasjon, en behandling, en telefonsamtale, et røntgensvar, en innkommet epikrise mv.
EH1.3.4.3	Tidslinjer med ulikt «omfang» (bredde). Tidslinjer kan brukes på flere områder og nivå, både som samlede tidslinjer og for å vise utvikling på ett enkelt område.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Forståelse for diagnostikk og behandling av sykdom baserer seg på en forståelse av hvordan sykdom og tiltak utvikler seg over tid.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Ved registrering av informasjon må det være knyttet tidspunkt til hendelser.

Funksjonalitet EH1.3.5: Utsveksling av informasjon med aktører utenfor helse- og omsorgssektoren

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å utveksle informasjon til relevante aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten (f.eks. barnevern, skole, barnehage, PP-tjenesten, NAV, arbeidsgiver, forsikringsselskap, politi, UDI) på en effektiv og sikker måte.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH1.3.5.1	Kommunikasjonsløsning. Aktører fra ulike sektorer som har behov for samhandling, kan kommunisere seg i mellom gjennom sikre kanaler.
EH1.3.5.2	Deling av dokumentasjon og planer. Aktører fra ulike sektorer som har behov for samhandling, kan dele informasjon og opprette planer for å koordinere sine tjenester i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
EH1.3.5.3	Lagring og forvaltning av informasjon innhentet fra aktører utenfor helse- og omsorgssektoren. Informasjon som innhentes fra aktører utenfor helse- og omsorgssektoren skal lagres og forvaltes som en integrert del av journalen. De samme reglene for status må gjelde for denne informasjonen som for helseopplysninger registrert av helsepersonell. Informasjonen bør kunne grupperes og fremstilles som beskrevet i EH1.3.3 og 1.3.4.
EH1.3.5.4	Kobling til pasientens problemliste. Informasjon som innhentes fra aktører utenfor helse- og omsorgssektoren knyttes til pasientens problemliste og kan derfor filtreres og grupperes slik at det som er relevant for det enkelte helsepersonell fremkommer.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

Helsepersonell samarbeider ofte med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten for å gi et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud til innbygger/pasient. Funksjonalitet for utveksling av informasjon vil forenkle koordinering og samordning av tjenester fra forskjellige aktører i og utenfor helse- og omsorgstjenesten.

- Innbygger/pasient som følges opp av aktører fra flere sektorer, vil få mer helhetlige og koordinerte tjenester.
- Involverte aktører vil kunne spare tid ved at den tverrsektorielle samhandlingen blir mer effektiv.

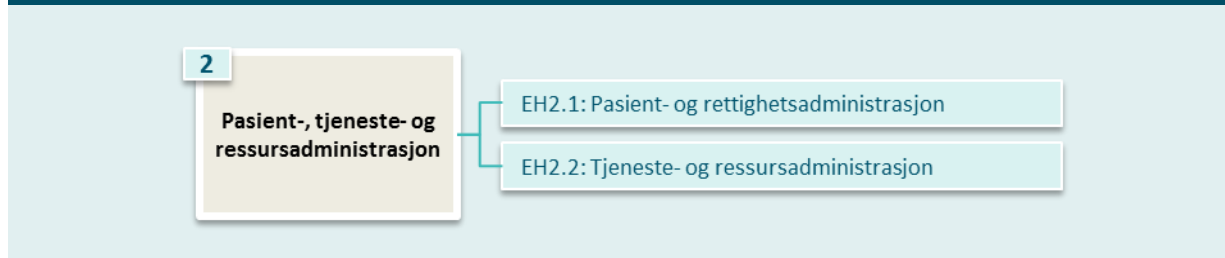
Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte grensesnitt for utveksling av informasjon.
- Rolle- og tilgangsstyring iht. regelverk.
- Samtykkeløsning (utveksling av informasjon er ofte avhengig av samtykke fra pasient og bruker eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende).

2.3 E-helsekapabilitet 2: Pasient-, tjeneste- og ressursadministrasjon

Kapabiliteten sikrer effektiv allokering av tjenester og ressurser (inkl. personell) til pasienter etter behov og rettigheter. Det fremgår tydelig for alle behandlere og pasienter hvem som har koordineringsansvaret for helsehjelpen og ansvaret for å utføre hvilke tjenester til enhver tid.

Figur 28. E-helsekapabilitet med underkapabiliteter: Pasient-, tjeneste- og ressursadministrasjon



Sentralt for denne kapabiliteten er de ulike anmodningsformene, beskrevet i Figur 29.

Figur 29. Anmodningsformer

Anmodninger om helsehjelp fra innbygger <u>Bestille:</u> Innbygger bestiller helsehjelp som ikke krever søknad/henvisning/rekvisisjon, for eksempel time hos fastlege. <u>Søke:</u> Innbygger søker om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette kan også gjøres av andre (f.eks. pårørende, helsepersonell) på vegne av innbygger. Aktuelt offentlig organ behandler søknaden og fatter vedtak.	Anmodning om helsehjelp fra helsepersonell med rekvisisjons-/henvisningsrett <u>Rekvirere:</u> Kreve at noe stilles til rådighet i arbeidet med et helseproblem. Det kan være <i>undersøkelser, tjenester, hjelpemidler, transport</i>. Ved en rekvirering beholder utstederen av rekvisisjonen hovedansvaret for det aktuelle helseproblemet dette gjelder. <u>Henviser:</u> Når helsepersonell ber om at en annen instans i helse- og omsorgstjenesten eller annet helsepersonell tar hånd om et helseproblem. Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar midlertidig ansvaret for dette helseproblemet.
--	---

Her beskrives funksjonalitet som understøtter henvisningsprosessen, samt saksbehandling av innbyggers søknader. Funksjonalitet for å understøtte innbygger i å bestille og søke er beskrevet i kapittel 2.7.1. Funksjonalitet for å understøtte helsepersonell i å rekvirere er beskrevet i kapittel 0.

2.3.1 EH2.1: Pasient- og rettighetsadministrasjon

Funksjonalitet EH2.1.1: Henviser

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at helsepersonell kan be om at en annen instans i helse- og omsorgstjenesten eller annet helsepersonell tar hånd om eller utrede et helseproblem. Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar midlertidig ansvaret for dette helseproblemet.

Denne funksjonaliteten virker både mellom aktører innenfor samme omsorgsnivå og på tvers av omsorgsnivåene. Den dekker også kommunikasjon begge veier mellom aktører, se Funksjonalitet EH6.1.2: Søke om helse- og omsorgstjenester og andre ytelser i kapittel 2.7.1.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.1.1.1	Støtte til valg av tjeneste. Henvisende helsepersonell får, på bakgrunn av aktuelt helseproblem, forslag til tjenester, og kan derfra velge ønsket gjennomført tjeneste.
EH2.1.1.2	Støtte til valg av henvisningsmottaker for vurdering. Henvisningen kan sendes til alle virksomheter, både private og offentlige, som har vurderingskompetanse. Det vil si virksomheter som kan tildele pasient- og brukerrettigheter.
EH2.1.1.3	Støtte til valg av tjenesteyter. For valgt tjeneste vises aktuelle tjenesteytere med relevante vurderingsparametere (kvalitetsindikatorer, ventetider mv.). Tjenesteyter kan være en annen virksomhet enn henvisningsmottaker i EH2.1.1.2. <u>Fritt sykehusvalg, fritt behandlingsvalg:</u> Pasienter kan etter å ha fått henvisningen vurdert og blitt tildelt rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste, velge annen tjenesteyter enn den som har vurdert henvisningen. Tjenesteyter må enten ha avtale med et regionalt helseforetak eller være godkjent etter forskrift om fritt behandlingsvalg. Ved valg av annen tjenesteyter er denne bundet av den første vurderingen som er gjort.
EH2.1.1.4	Henvisningsmottaker og tjenesteyter kan være samme aktør, eller ulik aktør. Løsning understøtter retten til fritt behandlingsvalg.
EH2.1.1.5	Støtte til tilgjengeliggjøring av relevant informasjon. Det finnes støtte for valg av informasjon og utforming av henvisning. Det kan legges inn obligatoriske krav til utforming og innhold i henvisningen for ulike diagnoser/tjenester.
EH2.1.1.6	Oversikt over hva henvisende helsepersonell skal gjøre før henvisning. Funksjonaliteten gir henvisende helsepersonell en oversikt over relevante undersøkelser som vedkommende selv skal utføre før henvisning sendes.
EH2.1.1.7	Mottaker kan be om tilgang til mer informasjon. Dersom mottaker mangler informasjon for å vurdere en henvisning og eventuelt gjennomføre nødvendige tjenester, kan vedkommende be om tilgang til mer informasjon.
EH2.1.1.8	Mottaker kan besvare henvisningen. Den som mottar en henvisning kan besvare den med å ta over behandlingsansvaret. Mottaker kan også avvise en henvisning, og eventuelt besvare henvisningen med råd til avsender.
EH2.1.1.9	Ansvarsoverføring tilbake til henvisende instans (epikrise). Dersom den som mottar en henvisning velger å kalle inn pasienten, overtar vedkommende midlertidig ansvaret for dette helseproblemet. Når aktuelle tjenester er gjennomført overføres ansvaret tilbake til henvisende instans. Ved en overføring av ansvar forutsettes at nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig for mottaker.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Forenkler og effektiviserer en sentral prosess. Helsepersonell sparer mye tid ved å slippe å duplisere opplysninger.
- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet, støtte til riktigere utredning før henvisning. Færre henvisninger sendes feil.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Rolle- og tilgangsstyring for helsepersonell.
- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Samlet tilgang til informasjon.
- Tilgjengelig kodeverk for hvilke tjenester som kan ytes ved rekvisisjon.
- Felles tjenestekatalog.
- Avklart oppgave- og ansvarsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
- Adresseregister som sikrer sikker og effektiv formidling mellom avsender og mottaker av informasjon.

Funksjonalitet EH2.1.2: Samlet og komplett oversikt over sendte henvisninger og søknader

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi henvisende helsepersonell (ev. helsepersonell involvert i pasients søknad) en samlet og komplett oversikt over sendte henvisninger og søknader.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.1.2.1	Oversikten viser status. Oversikten viser hvor hver henvisning/søknad er til behandling, frist for saksbehandling, samt utfall/vedtak. Det finnes mulighet til å spore hver henvisning til person som sitter med ansvar til en hver tid (inkl. kontaktinformasjon), samt mulighet til å logge fremdrift og måle kvalitet på prosessen.
EH2.1.2.2	Henvisninger/søknader kan oppdateres. Henvisende helsepersonell kan oppdatere henvisning/søknad med nye/endrede opplysninger og problemstillinger.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Forenkler og effektiviserer helsepersonells hverdag. Reduserer unødige og dupliserte undersøkelser.
- Lokaliseringsfunksjon for henvisninger som gjør det mulig å spore hvor i prosessen en henvisning befinner seg.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Rolle- og tilgangsstyring for helsepersonell.
- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Samlet tilgang til informasjon.

Funksjonalitet EH2.1.3: Vurdering og prioritering av henvisninger og søknader

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å understøtte aktører som mottar henvisninger og søknader i å vurdere og prioritere disse.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.1.3.1	Samlet og komplett oversikt over innkomne henvisninger og søknader. Oversikten viser aktuelle pasienters rettigheter og tilhørende frister, samt status for hver enkelt henvisning eller søknad (hvor hver henvisning/søknad er til behandling, hvor langt saksbehandlingen har kommet, frist for saksbehandling, utfall/vedtak, eventuell korrespondanse med henvisende helsepersonell (f.eks. oppdatert informasjon)).
EH2.1.3.2	Tilgang til relevant informasjon tilknyttet hver henvisning/søknad. På bakgrunn av helseproblem/tjeneste, gis mottaker av henvisning/søknad tilgang til relevante

	pasientopplysninger og kontekst (spørsmål/problemstilling, problemliste, symptomer, behandling/legemidler, diagnoser, gjennomførte undersøkelser mv.). For søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, må det utvidede informasjonsbehovet ivaretas (bosituasjon, familiesituasjon, sosiale forhold, eventuelle tidligere vedtak mv.).
EH2.1.3.3	Mottaker kan be om tilgang til mer informasjon. Dersom mottaker mangler informasjon for å vurdere en henvisning/søknad og eventuelt gjennomføre nødvendige tjenester, kan vedkommende be om tilgang til mer informasjon.
EH2.1.3.4	Mottaker varsles ved oppdatering av vurderingsgrunnlag. Mottaker av henvisning/søknad varsles dersom henvisning/søknad oppdateres med nye opplysninger og problemstillinger.
EH2.1.3.5	Manuell rettighetsvurdering av henvisninger/søknader. Det er støtte for manuell rettighetsvurdering (inkl. behandlingsfrist) av henvisninger/søknader og prioritering av disse, samt tilbakemelding om utfall/vedtak til henvisende helsepersonell og innbygger. Dette inkluderer mulighet til å avvise søknader, ev. omadressere dersom annen mottaker ville være mer relevant. Slike vurderinger innebærer informasjonsansvar til pasient og henvisende instans.
EH2.1.3.6	Beslutnings-/prosessstøtte til rettighetsvurdering av henvisninger/søknader. Beslutnings-/prosessstøtte som understøtter rettighetsvurderinger (som beskrevet i EH2.1.3.5) og gir konkrete forslag der det er relevant. Beslutnings-/prosessstøtte kan også foreslå supplerende eller alternative tjenester til det som kan være spesifisert i henvisning/søknad.
EH2.1.3.7	Oppdatering av oversikt over pasientrettigheter og valgmuligheter for den enkelte pasient. Oversikten (jf. EH2.1.5) oppdateres på bakgrunn av utført rettighetsvurdering.
EH2.1.3.8	Støtte for utsatt timebestilling. Det finnes mulighet for å utsette en innkalling. Fristbrudd utløses dersom utsettelsen går ut over det som er satt opp som medisinsk forsvarlig ventetid.
EH2.1.3.9	Ansvarsoverføring tilbake til henvisende instans (epikrise). Når en oppgave er utført og pasienten er ferdig behandlet/vurdert, overføres ansvaret tilbake til henviser for det aktuelle problemet. Ansvarsoverføring skal alltid følges av en overføring av relevant informasjon for den som tar over ansvar etter ferdig behandling/vurdering.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Økt pasientsikkerhet.
- Forenkler og effektiviserer prosessen med vurdering av henvisninger og søknader.
- Sikrer at eventuell ny informasjon blir fanget opp av mottaker.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Rolle- og tilgangsstyring for helsepersonell.
- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Samlet tilgang til informasjon.

Funksjonalitet EH2.1.4: Ventelistedministrasjon

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi en instans i helse- og omsorgstjenesten en komplett oversikt over pasienter som er rettighetsvurdert på bakgrunn av en anmodning (henvisning/søknad), men som ikke har mottatt helsehjelpen de har rett på enda. Ventelisten viser pasienter som har en avtale frem i tid, og pasienter som venter på å få satt opp en avtale (utsatt timebestilling). En avtale kan her kan eksempelvis være tildeling av korttidsplass, oppstart av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, avlastning eller støttekontakt, eller installering av trygghetsalarm eller utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.1.4.1	Samlet og komplett oversikt over pasienter i ventelisten. Det er en samlet og komplett oversikt over pasienter i ventelisten. Pasientene i ventelisten er knyttet til problemstilling og planlagt tjeneste, samt hvem som har ansvar for at tjenesten gjennomføres innenfor gjeldende frist.
EH2.1.4.2	Påminnere.

	Det er funksjonalitet for påminnere (varsler) dersom eksempelvis tid ikke reserveres til pasienten innen definerte frister for å unngå fristbrudd og at pasienter glemmes. Disse eskalerer dersom det ikke ageres innen en gitt frist.
EH2.1.4.3	Sortering, filtrering og gruppering. Listene kan struktureres etter ulike parametere. Eksempelvis kan det være relevant å sortere etter geografisk bosted og reisevei, for å finne pasienter som kan møte på kort varsel.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Sikre orden og oversikt over ventende arbeidsoppgaver og forpliktelser for en enhet.
- Fjerne brudd på gjeldende rettighetsvurderinger.
- Redusere ventetid.
- Forenkle og effektivisere prosessene for tildeling av ressurser og rettigheter.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Samlet tilgang til informasjon.
- Strukturert kunnskapsgrunnlag og regelsett.

Funksjonalitet EH2.1.5: Samlet og komplett oversikt over pasientrettigheter og valgmuligheter for den enkelte pasient

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell tilgang til en samlet, komplett og oppdatert oversikt over den enkelte innbyggers pasient- og brukerrettigheter, samt eventuelle valgmuligheter som følger av rettighetene.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.1.5.1	Oppdatert oversikt over innbyggers pasient- og brukerrettigheter. Oversikt over den enkelte innbyggers pasient- og brukerrettigheter oppdateres på bakgrunn av svar på henvisninger og søknader (vedtak).
EH2.1.5.2	Oppdatert oversikt over innbyggers valgmuligheter. Oversikt over den enkelte innbyggers valgmuligheter oppdateres på innbyggers pasient- og brukerrettigheter.
EH2.1.5.3	Støtte til valg av tjenesteyter (Fritt sykehusvalg, Fritt behandlingsvalg, Fritt brukervalg). For valgt tjeneste vises aktuelle tjenesteytere med relevante vurderingsparametere (kvalitetsindikatorer, ventetider mv.). For kommunale helse- og omsorgstjenester finnes er det fritt brukervalg for enkelte tjenester i enkelte kommuner.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Økt innfrielse av pasientrettigheter, og på den måten bidra til å sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
- Bedre *administrativ kontinuitet* (jf. definisjon s. 50).

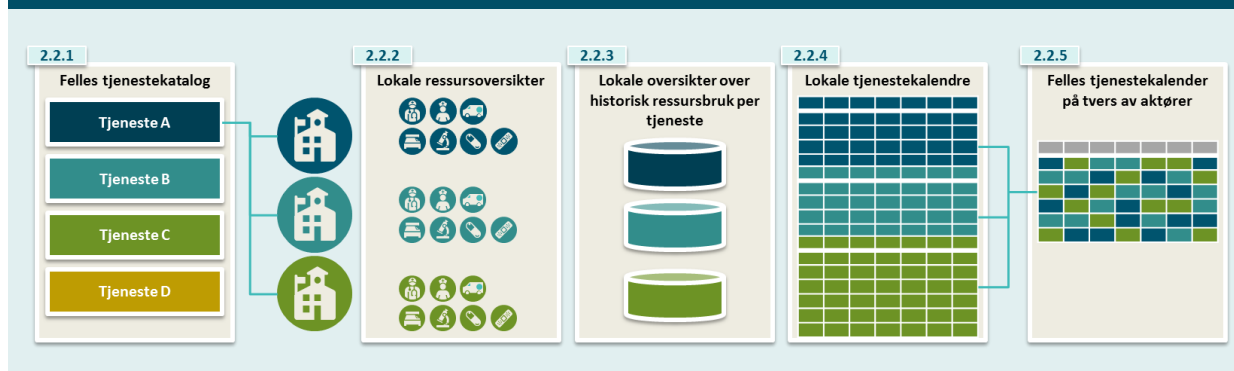
Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisering og strukturering av informasjon
- Samlet tilgang til informasjon.

2.3.2 EH2.2: Tjeneste- og ressursadministrasjon

Funksjonalitet som er beskrevet i dette kapitlet, henger sammen som illustrert i Figur 30.

Figur 30. Ressurs- og tjenesteadministrasjon



Funksjonalitet EH2.2.1: Felles tjenstekatalog

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

En sentral oversikt over alle tjenester (hovedtiltak, tiltak, oppgaver), og hvilke enheter og virksomheter som utfører dem.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.2.1.1	Tjenestene er strukturerte og standardiserte. Tjenestekatalogen baseres på enhetlige definisjoner av tjenestene.
EH2.2.1.2	Tjenesten kan være koblet mot spesifikke problemstillinger. Gjør det eksempelvis mulig å henvise for en problemstilling uten å spesifisere ønsket tjeneste. Helseproblem kobles til tjeneste og aktuelle tjenesteytere via tjenestekatalogen.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bedre oversikt over tilgjengelige tjenester.
- Lettere å henvise/rekvirere/søke til rett aktør.
- Pasient kommer raskere til rett aktør for beste helsehjelp.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Samlet tilgang til informasjon.
- Alle helse- og omsorgstjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter.

Funksjonalitet EH2.2.2: Lokal ressursoversikt

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Lokal oversikt over den enkelte virksomhetens ressurser (personer, utstyr, rom/arealer), samt når de er tilgjengelige.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.2.2.1	Hver ressurs er knyttet til et sett med tiltak og oppgaver. For helsepersonell er det deres profesjon, rolle og kompetanse som regulerer hvilke tjenester de kan utføre.
EH2.2.2.2	Kalenderoversikt over ressursers tilgjengelighet. Ressursers tilgjengelighet baseres på arbeidsplan, vaktlist, reservasjonslister for rom mv.
EH2.2.2.3	Regler for booking/reservasjon av ressurser. Det må kunne settes regler for gradvis oppfylld av tilgjengelige ressurser basert på tjenesteyters behov

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

	for oversiktlig arbeidsplanlegging og medisinsk forsvarlig drift. Helsepersonell kan booke avtaler for pasienter utenfor egen enhet der det finnes avtaler om direkte booking mellom de to enhetene.
--	--

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bedre utnyttelse av kapasitet.
- Bedre fordeling og koordinering av ressurser.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Alle helse- og omsorgstjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter.
- Oppdatert felles tjenestekatalog med forutsigbarhet en definert tidsperiode frem i tid (f.eks. 3 måneder).
- Helseadministrative registre.

Funksjonalitet EH2.2.3: Lokal oversikt over historisk ressursbruk per tjeneste

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Lokal oversikt over ressursbruk (personer, utstyr, rom/arealer) knyttet til den enkelte tjeneste (hovedtiltak, tiltak, oppgaver).

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.2.3.1	Kobler tjenester og ressurser på bakgrunn av informasjon fra felles tjenestekatalog (EH2.2.1) Tjenestenes kobling mot tjenesteyter og spesifikke problemstillinger.
EH2.2.3.2	Kobler tjenester og ressurser på bakgrunn av informasjon fra lokal ressursoversikt (EH2.2.2). Ressursenes tilknytning til tiltak og oppgaver, for helsepersonell på bakgrunn av profesjon, rolle og kompetanse. Kalenderoversikt over ressursers tilgjengelighet. Regler for booking/reservasjon av ressurser.
EH2.2.3.3	Tid brukt på gjennomføring av spesifikke tjenester. Det kan registreres hvor lang tid ulikt helsepersonell bruker på definerte tjenester, eksempelvis en leges gjennomsnittlige operasjonstid.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

Hver tjeneste har et ressursbehov, som kan være en kombinasjon av ulike typer helsepersonell, utstyr og rom mv. Hvordan tjenesten leveres, hvilke helsepersonell som er involvert og andre lokale forhold, vil gjøre at ressursbehov for gjennomføring av én spesifikk tjeneste vil variere.

- Forhåndsdefinert forslag til hvilke ressurser som skal inngå for en gitt tjeneste, effektiviserer bestillingen og sikrer at enkelttiltak ikke blir glemt.
- Muliggjør rask booking av tiltak på tvers av kalendre.
- Raskt å finne frem til ledig tid for tiltak.
- Bedre ressursutnyttelse.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Alle helse- og omsorgstjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter.
- Oppdatert felles tjenestekatalog.
- Helseadministrative registre.
- Lokal ressursoversikt.

Funksjonalitet EH2.2.4: Lokal tjenestekalender

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å sette opp tidspunkter for gjennomføring av spesifikke tjenester i en lokal tjenestekalender.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.2.4.1	Logikk basert på informasjon i felles tjenestekatalog (EH2.2.1), lokal ressursoversikt (EH2.2.2) og lokal oversikt over historisk ressursbruk per tjeneste (EH2.2.3) Ressursenes tilknytning til tiltak og oppgaver, for helsepersonell på bakgrunn av profesjon, rolle og kompetanse. Hvor lang tid ulikt helsepersonell bruker på definerte tjenester. Kalenderoversikt over ressursers tilgjengelighet. Regler for booking/reservasjon av ressurser.
EH2.2.4.2	Automatisk reservasjon av nødvendige ressurser. Når en tjeneste settes opp på et spesifikt tidspunkt, reserveres nødvendige ressurser i det nødvendige tidsrommet som en del av samme prosess.
EH2.2.4.3	Viser ledig kapasitet. For valgt tjeneste vises når det er ledig kapasitet.
EH2.2.4.4	Kan bestille/endre/avbestille timer. En spesifikk tjeneste til et spesifikt tidspunkt kan tildeles en spesifikk pasient (avtale) i henhold til pasientens rettigheter og hastegrad.
EH2.2.4.5	Ivaretagelse av relasjonell kontinuitet (jf. definisjon s. 50). For at det terapeutiske forholdet mellom pasienten og én eller flere helsepersonell, foreslås tidspunkt hvor ønsket tjeneste utføres av pasientens faste helsepersonell, der dette er relevant.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Automatisering av manuelle arbeidsprosesser kan gi tidsbesparelser.
- Automatisering og standardisering med bruk av påminnere gir likere og bedre helsehjelp.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Alle helse- og omsorgstjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter.
- Oppdatert felles tjenestekatalog.
- Helseadministrative registre.
- Lokal ressursoversikt som viser ressursers tilgjengelighet.
- Forhåndsdefinert ressursbruk for tjenester.

Funksjonalitet EH2.2.5: Felles tjenestekalender på tvers av aktører

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å tilgjengeliggjøre oppdatert informasjon fra hver lokale tjenestekalender i én felles tjenestekalender. Kalenderen viser nødvendigvis ikke all informasjon fra de lokale tjenestekalendrene.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH2.2.5.1	Viser ledig kapasitet på tvers av aktører for aktuelle tjenester. For valgt tjeneste vises når aktuelle tjenesteytere har ledig kapasitet.
EH2.2.5.2	Informasjon om aktuelle tjenesteytere. For valgt tjeneste vises med hvilken kvalitet tjenesten har blitt levert av aktuelle tjenesteytere tidligere (kvalitetsindikatorer, ventetider mv.).
EH2.2.5.3	Kan bestille/endre/avbestille timer. En spesifikk tjeneste til et spesifikt tidspunkt kan tildeles en spesifikk pasient (avtale) i henhold til pasientens rettigheter og hastegrad dersom aktør har valgt å åpne for dette. Tilgang for andre aktører og innbygger kan være begrenset til å se tilgjengelighet.
EH2.2.5.4	Ivaretagelse av relasjonell kontinuitet (jf. definisjon s. 50). Det foreslås tidspunkt hvor ønsket tjeneste utføres av pasientens faste helsepersonell, der dette er relevant. Dette for å ivareta kontinuitet i det terapeutiske forholdet mellom pasient og én eller flere helsepersonell.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Raskere reservasjon og endring av tjenester.
- Bedre kapasitetsutnyttelse.
- Muliggjør selvbetjening.

Utredning av «Én innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Alle helse- og omsorgstjenester er enhetlig definert på tvers av virksomheter.
- Oppdatert felles tjenestekatalog.
- Helseadministrative registre.
- Lokale tjenestekalendrene.

2.4 E-helsekapabilitet 3: Plan, oppgaveadministrasjon og fagfellestøtte

Kapabiliteten til å understøtte utførelse av oppgaver og trygg ansvars- og oppgaveoverføring er nødvendig for å sikre at det ikke forekommer brudd i tjenesten. Den gir helsepersonell prosessstøtte til strukturert planlegging, iverksettelse og oppfølging av oppgaver i et behandlingsforløp. Planen er både overordnet og detaljert, altså at den både viser f.eks. en timeavtale frem i tid men også detaljerte tiltak i den avtalen.

Der det er tilgjengelig vil forhåndsdefinerte standardplaner (standardiserte behandlingsforløp og prosedyrer) benyttes som grunnlag i størst mulig grad. Det er fleksibilitet til å tilpasse disse til den enkelte pasients behov ved å fjerne og legge til tiltak og oppgaver. Elementene i planen er knyttet til en tidslinje og samme plan brukes både for inneliggende, hjemmeboende med pleie og for polikliniske pasienter for best kontinuitet.

Planen er knyttet til problemstilling. Dermed kan en pasient med mange problemstillinger ha mange forskjellige planer. Disse kan følges individuelt men også slås sammen til en felles koordinert plan for bedre koordinering.

Planen gir også oversikt over hvilke aktører som har ansvar for tiltak og oppgaver i planene. En plan startet opp hos en aktør overføres til en annen aktør og ansvaret overtas. Det er støtte for varsling til aktør med ansvaret for et tiltak.

Helsepersonell vil bruke funksjonalitet beskrevet i kapittel 1 for å dokumentere i en plan.

Figur 31. E-helsekapabilitet med underkapabiliteter: Plan, oppgaveadministrasjon og fagfellestøtte



2.4.1 EH3.1: Plan og prosessstøtte

Funksjonalitet EH3.1.1: Felles tverrfaglig plan

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell en samlet oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak knyttet til en pasients problemliste. Tiltakene er både overordnet slik som en avtale (eks. en årskontroll for diabetes) og detaljert (de forskjellige tiltakene i en årskontroll eller et sårstell for en pasient som mottar pleie på en institusjon eller i hjemmet). Både overordnede og detaljerte tiltak er knyttet til tid.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.1.1.1	Planer for den enkelte pasient kan opprettes, deles og følges opp på tvers av helse- og omsorgstjenesten. Planen kan deles på tvers av helsepersonellgrupper (tverrfaglig), på tvers av aktører og på tvers av omsorgsnivå.
EH3.1.1.2	Det fremgår tydelig hvilken aktør og hvilke helsepersonell/helsepersonellteam som til enhver tid har ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. Planen støtter teamorganisering av helsehjelp (jf. primærhelsemeldingen (17) om primærhelseteam og oppfølgingsteam).
EH3.1.1.3	Hvert tiltak/hver oppgave vises med status (planlagt/gjennomført). Viser også tidspunkt for gjennomføring, eventuelt frist for gjennomføring.
EH3.1.1.4	Planen støtter tverrsektoriell teamorganisering. Understøtter koordinering av tverrsektorielle ansvarsgrupper. Planen kan inngå i individuell plan (tverrsektoriell).
EH3.1.1.5	Planen kan fremstilles både overordnet og detaljert. Det er mulig å se planen på ulike nivå, fra oppgaver fordelt på timer i en dag og til å se flere år om gangen.
EH3.1.1.6	En pasient kan ha flere planer. En pasient vil kunne inngå i flere behandlingsforløp, og potensielt flere planer. Dette gjelder spesielt multisyke. Løsningen håndterer eventuelle avhengigheter mellom de ulike planene.
EH3.1.1.7	Planen kan filtreres. Informasjonen i en plan kan filtreres slik at kun de tiltak og oppgaver som er relevante, avhengig av rolle og situasjon, vises. Noen har behov for å se én eller flere planer samlet, mens andre bare har behov for å se deler av en plan for å gjennomføre enkeltstående tiltak. Løsningen muliggjør synliggjøring av både helheten og detaljene. Jf. EH1.3.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Planen danner basis for forsvarlig helsehjelp.
- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet, redusere muligheten for at oppgaver og tiltak uteglemmes.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisert og strukturert dokumentasjon.
- Tilgang til relevante pasientopplysninger.
- Definerte tiltak/prosedyrer og oppgaver.
- Rolle- og tilgangsstyring.

Funksjonalitet EH3.1.2: Rekvirere

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at helsepersonell kan kreve at noe stilles til rådighet i arbeidet med et helseproblem. Det kan være undersøkelser, tjenester, hjelpemidler, transport. Ved en rekvirering beholder utstederen av rekvisisjonen hovedansvaret for det aktuelle helseproblemet dette gjelder.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.1.2.1	Ifm. laboratorieundersøkelser: Merking av materiale med strekkodelesere og annet ID-kontrollutstyr. Det er støtte for ID-merking av emballasje for prøver av vev og væsker.
EH3.1.2.2	Ifm. laboratorie-/radiologiundersøkelser: Identifisering av pasient med ID-kontrollutstyr. Pasient kan ved prøvetaking identifiseres med strekkoder eller annet ID-kontrollutstyr.
EH3.1.2.3	Støtte til valg av undersøkelse/tjeneste/hjelpemiddel. Rekvirerende helsepersonell får, på bakgrunn av aktuelt helseproblem, forslag til undersøkelser/tjenester/hjelpemidler, og kan derfra velge det som er aktuelt.
EH3.1.2.4	Rekvirere som del av plan basert på standardiserte behandlingsforløp. Ved opprettelse av planer basert på standardiserte behandlingsforløp (jf. EH3.1.3) som inkluderer undersøkelser/tjenester/hjelpemidler/transport som må rekvireres, kan alle aktuelle rekvisisjoner sendes samlet som en integrert del av prosessen med å opprette planen når det standardiserte behandlingsforløpet initieres. Det finnes mulighet for å redigere den forhåndsdefinerte listen over rekvisisjoner ved å fjerne og legge til etter behov.
EH3.1.2.5	Støtte til valg av tjenesteyter/leverandør av hjelpemiddel. For valgt tjeneste vises aktuelle tjenesteytere/leverandører av aktuelle hjelpemidler. Det er støtte for personlige adressater, tjenestebasert adressering og for flere adressater samtidig.
EH3.1.2.6	Støtte til tilgjengeliggjøring av relevant informasjon. På bakgrunn av helseproblem/tjeneste, gis rekvirerende helsepersonell forslag til hvilken informasjon som bør tilgjengeliggjøres (relevante pasientopplysninger og kontekst (spørsmål/problemstilling, problemliste, symptomer, behandling/legemidler, diagnoser, gjennomførte undersøkelser mv.)). Rekvirerende helsepersonell kan endre utvalget av informasjon som tilgjengeliggjøres ved å legge til eller trekke fra.
EH3.1.2.7	Mottaker kan be om tilgang til mer informasjon. Dersom mottaker mangler informasjon for å gjennomføre aktuelle undersøkelser/tjenester eller tildele aktuelle hjelpemidler, kan vedkommende be om tilgang til mer informasjon.
EH3.1.2.8	Mottaker kan gi tilbakemelding til rekvirerende helsepersonell. Mottaker av rekvisisjon kan eksempelvis gi tilbakemelding om når pasienten er kalt inn til ønsket undersøkelse, samt rapportere resultat fra undersøkelsen i etterkant.
EH3.1.2.9	Støtte til rekvisisjon av transport. Rekvirerende helsepersonell kan, på bakgrunn av pasientens transportbehov og gjeldende retningslinjer, rekvirere transport, både eksternt og internt.
EH3.1.2.10	Adressering til rekvirent(er). Det finnes en lukket sløyfe for rekvirering og adressering av svar slik at rekvirent blir gjort oppmerksom på at undersøkelsen er ferdig.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Forenkler og effektiviserer prosessen. Helsepersonell sparer mye tid på å slippe duplisere opplysninger samt reduserer mulighet for feil mottaker. Mottagende helsepersonell får tilstrekkelig informasjon og kontekst om pasienten.
- Økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisert og strukturert dokumentasjon.
- Tjenestekatalog.

Funksjonalitet EH3.1.3: Standardiserte behandlingsforløp og prosedyrer (prosesstøtte)

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell støtte til planlegging, koordinering og gjennomføring av pasientrettede tiltak (48) basert på standardiserte behandlingsforløp og prosedyrer.

Standardisert behandlingsforløp:

En normativ beskrivelse av et planlagt og forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. (52)

Begrepene «standardisert pasientforløp» og «behandlingslinje» benyttes også om normerte forløp. Det benyttes i dette dokumentet begrepet «behandlingsforløp», og ikke «pasientforløp», da det i kapabilitetssammenheng er naturlig å se på forløp fra helsepersonells perspektiv.

Prosedyre:

Detaljerte beskrivelser av hvordan helsepersonell bør utføre klinisk avgrensede oppgaver som for eksempel blodprøvetaking, hjerte- lungeredning, spirometrimåling med mer. Prosedyrer kan være medisinskfaglige eller administrative. Prosedyrene bør lages på grunnlag av dokumenter som synliggjør kunnskapsgrunnlaget for prosedyren og valg som er gjort i utarbeidelsen av denne. Det bør være tydelig sammenheng mellom prosedyren og tilhørende dokumenter som prosedyren bygger på, for eksempel veiledere, retningslinjer, strategidokumenter der brukerønsker, politiske ønsker eller annet er beskrevet. (53)

Soft-stop:

Ved soft-stop varsles bruker om systemets anbefaling, men systemet krav til en aktiv handling fra bruker dersom anbefalingen ikke tas til følge.

Hard-stop:

Ved hard-stop krever systemet en aktiv handling fra bruker dersom systemets anbefaling ikke tas til følge. Dersom bruker ikke ønsker å ta en anbefaling til følge, må vedkommende registrere dette valget for å komme videre. Det kan stilles krav til at begrunnelse for valget må registreres.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.1.3.1	Ved opprettelse av en plan for en enkelt pasient, kan hele eller deler av standardiserte behandlingsforløp og prosedyrer benyttes. Løsningen kan foreslå aktuelle behandlingsforløp/prosedyrer basert på registrert pasientinformasjon, ev. med beslutningsstøtte (se kapittel 2.5.2).
EH3.1.3.2	Forslag til individuell tilpasning basert på pasientopplysninger. Ved benyttelse av standardiserte behandlingsforløp og prosedyrer i en plan til en enkelt pasient, vil det basert på registrerte pasientopplysninger, kunne komme anbefalinger til individuell tilpasning (beslutningsstøtte, ev. samvalg med pasient).
EH3.1.3.3	Mulighet for manuell individuell tilpasning. For pasienter med sammensatte diagnoser vil det ofte være behov for å tilpasse de ulike behandlingsforløpene til ett helhetlig behandlingsforløp.
EH3.1.3.4	Prosesstøtte med varsling. Prosesstøtte kan fremkomme som visuelle varsler, forslag til tiltak eller oppgaver som kan ordineres, dialogbokser mv. Varsling gis som påminnelse for å gjennomføre en aktivitet (medikasjon etc.) eller som varsel om at en planlagt hendelse ikke er gjennomført til rett tid. Logg kan vise gjennomføring av aktiviteter i et behandlingsforløp med avvikende resultater/kostnader.
EH3.1.3.5	Prosesstøtte med soft-stop eller hard-stop. Det vil kunne variere hvor styrende prosesstøtte er (soft-stop/hard-stop, jf. definisjoner i boks).
EH3.1.3.6	Radiologiundersøkelser: Støtte for tolkning, redigering og bearbeidelse av data fra teknisk utstyr. F.eks. radiologens behov for verktøy for tolkning slik som linjaler, markører, gråtonejusteringer, inverteringer mv. Støtte for tekstlig dokumentasjon av tolkningen, inkludert også bruk av spesifikke kodeverk slik som f.eks. NCRP.
EH3.1.3.7	Laboratorieundersøkelser: Støtte for arbeidsflyt for sikker håndtering av prøver. Støtter arbeidsprosesser for mottak, bearbeidning/preparering/dyrkning, analyse, kvalitetssikring av analyse m.m. som foregår på laboratorier. Dette inkluderer kvalitetssikring av oppbevaring/behandling av materialet gjennom bearbeidelsesprosessen.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Standardisering av behandlingsforløp og prosedyrer bidrar til bedre resultater av helsehjelp og færre uønskede hendelser.
- Høyere pasienttilfredshet.
- Legger til rette for bedring av effektivitet og måling av kvalitet i behandlingen.
- Mulighet til å måle og sammenligne kvalitet for behandling av pasientgrupper og etterlevelse av gjeldende retningslinjer.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Funksjonalitet (prosesstøtte) for definering av standardiserte behandlingsforløp og prosedyrer.
- Bibliotek av relevante standardiserte behandlingsforløp knyttet til både diagnoser og symptomer, ev. utredningsprosedyrer for uklare tilstander (inkludert multisykke).

2.4.2 EH3.2: Tiltaks- og oppgaveadministrasjon

Funksjonalitet EH3.2.1: Arbeidslister til helsepersonell

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell/team/avdelinger oversikt over tiltak og oppgaver de er ansvarlige for. Tiltak og oppgaver baseres på pasientenes tverrfaglige planer.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.2.1.1	Arbeidslistene baseres på pasientenes planer (se kapittel 0), samt løpende oppgaver for aktuelt helsepersonell. Det vises tiltak og oppgaver fra flere pasienter samtidig.
EH3.2.1.2	Det fremgår tydelig hvilke helsepersonell/helsepersonellteam som har ansvaret for gjennomføring av aktuelle tiltak/oppgaver. Planen støtter teamorganisering av helsehjelp.
EH3.2.1.3	Hvert tiltak/hver oppgave vises med status (planlagt/gjennomført). Viser også tidspunkt for gjennomføring, eventuelt frist for gjennomføring.
EH3.2.1.4	Svar på undersøkelser i arbeidsliste. Svar på undersøkelser vises som oppgaver hos adressaten som kan kvitteres ut når svaret er håndtert. Frist, kritikalitet mv. fremkommer for enklere prioritering.
EH3.2.1.5	Varsling og påminnere. Tiltak og oppgaver som skal gjennomføres vil varsles. Dette gjelder også ved ansvarsoverføringer.
EH3.2.1.6	Det er støtte for å dokumentere utførelsen av tiltak/oppgave. Dette endrer status fra planlagt til gjennomført.
EH3.2.1.7	Eskalering av varsling og påminnere. Det er funksjonalitet for å eskalere varsling til høyere nivå dersom tiltaket/oppgaven ikke dokumenteres som gjennomført innenfor definert frist.
EH3.2.1.8	Arbeidslistene støtter tverrsektoriell teamorganisering. Understøtter koordinering av tverrsektorielle ansvarsgrupper. Tiltak/oppgaver fra individuelle planer (tverrsektoriell) kan inngå i arbeidslisten.
EH3.2.1.9	Arbeidsliste kan filtreres på pasient. Informasjonen i en arbeidsliste kan filtreres slik at kun de tiltak og oppgaver som gjelder én enkelt pasient vises.
EH3.2.1.10	Arbeidsliste kan filtreres på det enkelte helsepersonell. Informasjonen i en arbeidsliste kan filtreres slik at kun de tiltak og oppgaver som gjelder ett enkelt helsepersonell vises – eksempelvis brukeren selv eller en kollega.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Forbedrer og effektiviserer helsepersonells hverdag.
- Tilrettelegger for at oppgaver ikke overses eller forglemmes.
- Økt kvalitet og pasientsikkerhet

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Felles tverrfaglig plan.
- Standardisering av arbeidsoppgaver.

2.4.3 EH3.3: Fagfellestøtte

Funksjonalitet EH3.3.1: Fagfellestøtte

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell mulighet til kollegial kunnskaps- og erfaringsutveksling rundt pasientkasus eller generelle problemstillinger i form av kommunikasjonsløsninger som er knyttet til IKT-funksjonene.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.3.1.1	Det er støtte for å finne relevant fagfelle og eventuelt tilgjengelighet. Relevant fagfelle kan identifiseres gjennom søk etter legespesialister, spesialsykepleiere, fysioterapeuter med spesialområder mv. Visning av fagfelles tilgjengelighet er knyttet til søket.
EH3.3.1.2	Ulike kommunikasjonsformer. • Synkron kommunikasjon, som chat, telefonmøter eller videokonferanser (f.eks. videooverføring av et inngrep der kirurger kan veilede fra annen lokasjon). • Asynkron kommunikasjon, som sikker e-post eller digitale oppslagstavler.
EH3.3.1.3	Det er støtte for deling/utveksling av informasjon. Eksempelvis en pasients helseopplysninger eller artikler, multimedia.
EH3.3.1.4	Det er støtte for at råd som gis og konsekvenser av et samarbeid kan dokumenteres. Kommunikasjon om pasientkasus kan dokumenteres i pasientens journal. Skriftlig kommunikasjon (chat, sikker epost), samt opptak av telefon-/videomøter kan lagres.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

Helsepersonell samhandler ofte om et behandlingsforløp og konsulterer annet helsepersonell før de tar beslutninger. I praksis er det ofte vanskelig å få tak i fagfeller, og ofte vil slike henvendelser medføre uheldige avbrytelser for fagfelle. Bruk av IT kan forenkle fagfellekommunikasjonen.

- Bedre pasientbehandling. Legger til rette for kvalitetssikring av beslutninger.
- Kompetanseheving.
- Mer effektiv arbeidshverdag for helsepersonell.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Tjenestekatalog med adresseregister og nasjonal oversikt over ressurser, inkludert ressursenes kompetanse.

2.4.4 EH3.4: Legemidler

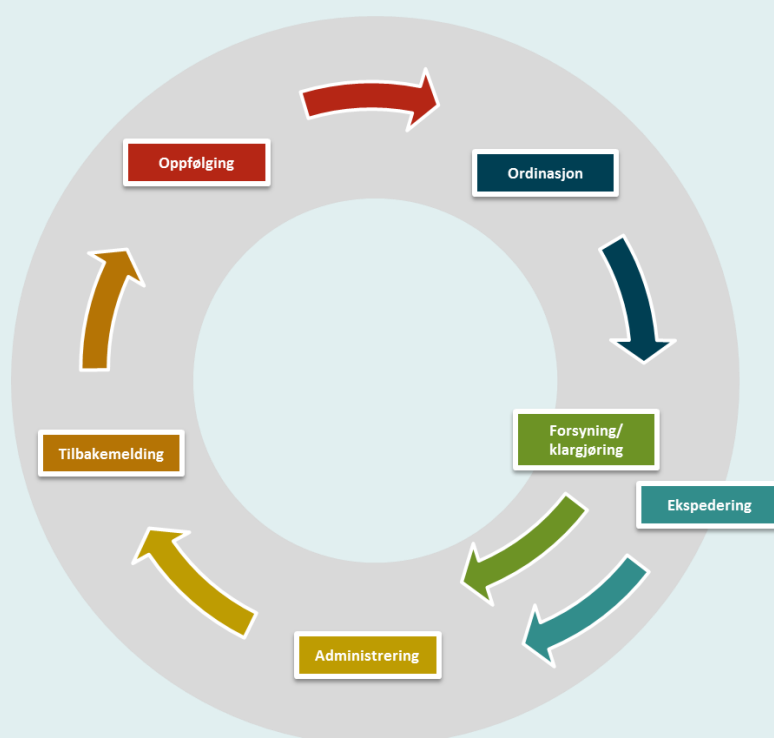
Behandling med legemidler er en sentral del av moderne medisin. Det er flere yrkesgrupper involvert i behandlingen. Det er risiko for skader og død hvis legemidler brukes feil. Derfor kreves en stor grad av presisjon i opplysninger om legemiddelbruk hos en pasient.

Legemiddelsløyfen (jf. Figur 32) er prosessen som løper fra en rekvirent (lege) ordinerer et legemiddel til pasienten tar legemidlet i bruk og, sammen med rekvirent, evaluerer dets effekt. Evalueringen danner grunnlaget for videre behandling, og gjør at prosessen vil være iterativ/syklisk. Legemiddelsløyfen har flere faser der én eller flere yrkesgrupper kan ha sentrale oppgaver, og det er behov for å dokumentere i alle fasene.

Utrekning av «Én innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Figur 32. Legemiddelsløyfen



Ordinasjon er den delen av legemiddelsløyfen der en rekvisient tar stilling til hvilke legemidler pasienten skal behandles med, og rekvisienten gjennomfører selve ordineringsprosessen. Dette er en formell beslutning om og bestilling av legemiddelutdeling. Rekvisienten har det endelige ansvaret for hvilke legemidler som blir ordinert til en pasient. I denne kapabiliteten ligger også evnen til å endre, pause og avslutte (seponere) en ordinasjon.

Forsyning/klargjøring Klargjøring, eller istandgjøring, er den delen av legemiddelsløyfen der legemidler blir gjort i stand til den enkelte pasient, eller at standardpakker blir klargjort til for eksempel operasjon. Med dette menes blanding av infusjoner, opptrekk i sprøyter, pakking av multidoser mv.

Ekspedering er den delen av legemiddelsløyfen der en bestilling av legemidler blir mottatt og behandlet på apotek eller hos grossist, og hvor legemidlene til slutt blir pakket, merket og fraktet fra apoteket til post, legemiddelrom/-tralle/-kabinett, vaktentral eller pasient. Det vanligste er at pasienten selv anskaffer legemidler på apotek.

Administrering er den delen av legemiddelsløyfen der legemidler mottas av pasient via ulike administrasjonsveier. Administreringen kan dokumenteres detaljert per dose legemiddel eller mer overordnet. Administrering kan utføres av helsepersonell slik som på institusjon eller i hjemmesykepleien, men vanligst er at pasient administrerer legemidler selv i hjemmet.

Tilbakemelding er den delen av legemiddelsløyfen der pasienten rapporterer legemidlenes virkninger (og bivirkninger). Dette kan fordelaktig skje via strukturerte PROMs (Patient-Reported Outcome Measures).

Oppfølging er den delen av legemiddelsløyfen der rekvisient følger opp pasientens opplevelse av virkninger (og bivirkninger). Dette danner grunnlaget for beslutning om ordinasjonen skal videreføres, endres, settes på pause eller avsluttes.

Funksjonalitet EH3.4.1: Ordinasjon og plan for legemidler

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for en sanntidsoppdatert liste over alle legemidler som er ordinert for pasienten. Listen er felles for alle relevante helsepersonellgrupper. Listen over legemidler brukes til all dokumentasjon av behandling med legemidler, både for inneliggende og hjemmeboende pasienter, med og uten støtte til administrasjon av legemidler. Det er støtte for dokumentasjon av at pasient er informert, opplært og veiledet i rett bruk, samt evaluering av virkning og bivirkning gjennom kapabilitetene i kapittel EH1 og EH3.4.5.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.4.1.1	Sanntidsoppdatert liste over alle ordinerte legemidler. Listen er felles for alle relevante helsepersonellgrupper og alle endringer gjøres direkte i listen. Det er ikke behov for andre lister for samme informasjon. Alle historiske endringer, slik som seponeringer, oppstart, pauser, doseendringer mv. kan vises.
EH3.4.1.2	Støtte for å bruke standardiserte metoder for gjennomgang av planen. Standardiserte metoder (som START og STOPP eller IMM) kan brukes for gjennomgang av legemiddelplanen. Det er mulig å se ordinasjoner knyttet mot problem men også mot mer detaljerte indikasjon.
EH3.4.1.3	Seponerings- og endringsårsak finnes strukturert og standardisert. Seponerings- og endringsårsak finnes strukturert og standardisert, f.eks. tilfrisknet, manglende effekt, bivirkning, kontraindikasjon mv.
EH3.4.1.4	Ordinasjoner med og uten tidsbegrensning. Ordinasjoner kan være både med og uten tidsbegrensning. Det er støtte for angivelse av evalueringspunkt for evaluering av effekt av behandling. Det er støtte for behovsmedikasjon (PRN – pro re nata) som er stående ordinasjoner/generisk forskrivning der pasienten selv eller annet helsepersonell innenfor bestemte regler kan administrere legemiddel ved behov.
EH3.4.1.5	Komplekse ordinasjoner og automatisk oppdatering av informasjon fra legemiddelspesifikk MTU. Det er støtte for komplekse ordinasjoner der det finnes, inkludert infusjoner der dosering er angitt som intervall. Informasjon fra legemiddelspesifikke MTU-er slik som infusjonspumpe er integrert og oppdateres automatisk.
EH3.4.1.6	Støtte til dokumentasjon av administrasjon av legemidler til pasient. For den som håndterer legemidler til pasient finnes støtte for dokumentasjon med alle variasjoner som oppstår, samt at det er innebygget kvalitetsfremmende verktøy som sikrer rett administrasjon til rett pasient i rett tid. Det er støtte for arbeidslister med varslings for når pasienter skal få et legemiddel.
EH3.4.1.7	Dokumentasjon av administrerte legemidler retrospektiv. Det er mulig å dokumentere administrerte legemidler retrospektiv, slik som i akutte situasjoner.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Økt pasientsikkerhet og reduksjon av uønskede hendelser, eksempelvis feil- og overdosering og interaksjoner.
- Planen kan benyttes til å dokumentere effekter av legemidler slik at virksam behandling opprettholdes.
- Mer effektivt for helsepersonell, redusert tid på å lete etter oppdatert informasjon om pasientens legemiddelordinasjoner. Dette gjelder særlig i akuttmottak og ved ansvarsoverføring
- Vil gi verdifull kunnskap til utvikling av helse- og omsorgstjenesten.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisert og strukturert datagrunnlag.
- Tilgang til relevante helseopplysninger.

Funksjonalitet EH3.4.2: Lukket legemiddelsløyfe

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for støtte til legemiddelhåndteringsprosessen der legemidler merkes med pasientens ID, fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse, klargjøring og administrasjon av legemiddelet, til evaluering av effekt for å sikre at riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig administrasjonsmåte, og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet.

Legemiddelsløyfe:

Prosess som løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse, klargjøring og administrering av legemiddelet, frem til evaluering av effekt. (Ref. figur 31)

Lukket legemiddelsløyfe:

Metode for sikring av legemiddelsløyfen slik at riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig administrasjonsmåte og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet. (51)

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.4.2.1	Legemidler kobles med pasientens ID i legemiddelhåndteringsprosessen. Pasient-ID er tilgjengelig på legemiddelet eller legemiddelet er koblet mot pasientens ID slik at verifisering kan utføres (riktig pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, i riktig dose, med riktig administrasjonsmåte og med riktig evaluering av effekt og sikkerhet, jf. definisjon av «lukket legemiddelsløyfe» i boks).
EH3.4.2.2	Ordinasjonen kobles mot produksjon og lagerføring Ved nye ordinasjoner igangsettes også leveranseprosessen. Selve funksjonaliteten for produksjon og leveranse behøver ikke være en sømløs del av løsningen, men kan integreres med.
EH3.4.2.3	Ved administrasjon finnes tilbakekoblingsmekanismer Når administrasjon verifiseres korrekt, dokumenteres automatisk administrasjonen. Dette vises i legemiddellisten. Opplysninger legemiddelets batch- og lotnummer er del av dokumentasjonen.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Redusere feil i legemiddelhåndtering, økt kvalitet og pasientsikkerhet.
- Mulighet for oppfølging ved tilbaketrekning av spesifikke legemiddelbatcher, ved nye bivirkninger eller kontraindikasjoner mv.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Virkestofforskrivning (generisk forskrivning).
- En-doser av legemidler finnes
- Strekkodesystem innført (eller annen tilsvarende teknologi) for identifisering av pasienter og legemidler.

Funksjonalitet EH3.4.3: Legemiddelekspedering/-utlevering

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Med en felles oppdatert legemiddelliste forsvinner behovet for «resept», men behovet for en anskaffelsesrett for hjemmeboende pasienter med instruksjoner for bruk til legemidler består. Dette innebærer funksjonalitet som gjør at leverandør av legemidler kan utlevere korrekt legemiddel med nødvendig veiledning og kontroll.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.4.3.1	Det kan ordineres legemidler med og uten sluttdato, men med angitt tid for evaluering av behandlingen. For pasienter som bor hjemme brukes samme legemiddelliste som for inneliggende pasienter. Det skilles enkelt mellom at pasient skal anskaffe og administrere legemidler selv i stedet for at sykehuset eller institusjonen anskaffer og administrere. I stedet for sluttdato for rekvisisjon finnes evalueringsdato for legemiddelet.
EH3.4.3.2	Pasient kan velge pakkemåte for legemidler. Pasient kan velge hvordan legemidlene skal pakkes, så som multidose, manuelle og elektroniske dosetter

	med rapporteringsfunksjon og andre løsninger for legemiddelforsyning. Automatiske dosetter er koblet mot legemiddellisten og gir kun tilgang til rett legemiddel i rett tid.
EH3.4.3.3	Pasient kan velge anskaffelsesmetode. Det er støtte for at pasient kan velge mest egnede anskaffelsesmetode når det finnes en gyldig ordinasjon. De kan velge å bruke internetapotek, få legemiddel levert på døren eller reise til apotek og hente etc.
EH3.4.3.4	Tilbakemeldingssløye ved utlevering Når legemiddelet er utlevert vises dette i legemiddellisten.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Økt sikkerhet i legemiddelhåndtering, spesielt pasientens etterlevelse og bruk av legemidler.
- Bedre transparens for helsepersonell ved at de kan se om pasienter har hentet ut ordinerte legemidler.
- Større valgfrihet for pasienter.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Strukturert og standardisert dokumentasjon

Funksjonalitet EH3.4.4: Interaksjonskontroll, dobbeltordinasjon, kontraindikasjoner, allergivarsling

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for interaksjonskontroll, dobbeltordinasjon, dosekontroll og andre varianter av klinisk beslutningsstøtte for legemiddelplan, basert på legemiddelinformasjon og pasientspesifikk informasjon. Generelt for alle er lærende funksjoner slik at individuell tilpassing av varslingsregler minimerer alarmtrøtthet. Se for øvrig EH4.2. for annen klinisk beslutningsstøtte.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.4.4.1	Varsel om interaksjoner. Det er varsel om legemidler som interagerer, inkludert mulighet for individuell tilpasning av varslinger knyttet til rolle for å unngå alarmtrøtthet.
EH3.4.4.2	Varsel om dobbeltordinasjon og synonymprodukter. Det er varsel om dobbeltordinasjon av legemidler. Det gis et varsel ved bruk av synonympreparater slik at den som administrerer legemidler kan verifisere at det byttes korrekt og dokumentere hvilket legemiddel som ble gitt.
EH3.4.4.3	Doseringskontroll. Doser utover gitt intervall varsles.
EH3.4.4.4	Doseringskontroll knyttet mot fysiologiske variabler. Det finnes doseringskontroll som er knyttet mot fysiologiske variabler slik som kjønn, alder, vekt, høyde, BMI m.fl. Også biokjemiske markører, slik som nyrefunksjonsprøver og genetiske variasjoner vil kunne brukes. Det gis varslings til ansvarlig behandler hvis det er endringer i disse variablene som gjør at en ordinasjon bør endres.
EH3.4.4.5	Varsling om sykdommer og tilstander som påvirker metabolismen av legemidler. Det er varslings om sykdommer og tilstander som påvirker metabolismen av legemidler ved forsøk på ordinerings, eksempelvis kontraindikasjoner. Det er også varslings hvis en pasient med aktive ordinasjoner får nye sykdommer og tilstander som påvirker metabolismen av de legemidler pasienten bruker.
EH3.4.4.6	Standardiserte metoder for legemiddelgjennomgang. Det er støtte for å bruke standardiserte metoder slik som START og STOPP og IMM for gjennomgang av legemiddelplanen.
EH3.4.4.7	Varsel om bivirkninger for en pasient. Det er varsel ved ordinasjon av et legemiddel som tidligere har gitt bivirkninger for en pasient. Jf. EH3.4.5.1.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Økt pasientsikkerhet og reduksjon i uønskede hendelser. Redusert overdosering med tilhørende reduksjon som direkte eller indirekte konsekvens.
- Det er potensielt færre interaksjoner som potenserer legemidler med mulighet for at færre pasienter utsettes for unøddig risiko i form av overdosering.
- Det er potensielt færre interaksjoner som reduserer effekten av legemidler, med mulighet for bedre effekt av legemidler.
- Spart tid for helsepersonell på å finne relevant og oppdatert informasjon om legemidler, samt sparer tid ved å kunne få tilgang til informasjon når det varsles om avvik.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisert og strukturert regelsett.
- Standardisert og strukturert dokumentasjon.

Funksjonalitet EH3.4.5: Bivirkningsdokumentasjon og -rapportering

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for dokumentasjon og rapportering av legemiddelbivirkninger.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH3.4.5.1	Dokumentasjon av legemiddelbivirkninger. Diagnostiserte bivirkninger av et legemiddel kan enkelt dokumenteres som et problem pasienten har hatt i problemlisten. Dette gjøres knyttet til at legemiddelordinasjonen seponeres eller videreføres endret (avhengig indikasjon og bivirkningens alvorlighetsgrad) og årsak knyttes til legemiddelet.
EH3.4.5.2	Rapportering av bivirkninger. Dokumenterte bivirkninger sammen med annen relevant informasjon kan enkelt rapporteres til virksomheter som analyserer og beskriver bivirkninger.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Forhindrer at legemidler som har blitt seponert på grunn av alvorlige bivirkninger gjeninnsettes.
- Bedre datagrunnlag for bivirkninger.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

Standardisert og strukturert dokumentasjon.

2.5 E-helsekapabilitet 4: Kunnskaps- og beslutningsstøtte

Kapabiliteten bidrar til at avgjørelser fattet av helsepersonell i forbindelse med helsehjelp gjøres med grunnlag i den til enhver tid gjeldende beste medisinske praksis, kunnskap og gitte prioriteringer. Den bidrar sammen med prosessstøtte til at like tilstander får likere behandling, økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet. Standardiserte forløp gir forutsigbarhet for pasienter og høyere effektivitet.

For mer detaljert beskrivelse av kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte, vises det til rapporten «Beslutningsstøtte. Definisjoner, status og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støtte» (48).

Figur 33. E-helsekapabilitet med underkapabiliteter: Kunnskaps- og beslutningsstøtte



2.5.1 EH4.1: Kunnskapsstøtte

Funksjonalitet EH4.1.1: Kunnskapsstøtte

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi helsepersonell tilgang til forskningsbasert kunnskap. Kunnskapsstøtte gir en mulighet for å hente kunnskap om en konkret problemstilling, men den tilpasser ikke eller velger ikke ut informasjonen etter en konkret pasient (48).

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH4.1.1.1	Kunnskapsstøtte kan tilgjengeliggjøres på ulike måter. Prosedyresamlinger, elektroniske oppslagsverk, kunnskapsdatabaser eller søkemotor for vitenskapelige artikler mv. Informasjonen må være kvalitetssikret og i tråd med det som til enhver tid er beste medisinske praksis.
EH4.1.1.2	Tilgang fra den kliniske arbeidsflaten. Integrert i en helhetlig løsning slik at helsepersonell kan benytte kunnskapsstøtte uten å forlate sin kliniske arbeidsflate.
EH4.1.1.3	Profesjonstilpasset. Kunnskapsstøtte må være tilpasset de forskjellige profesjonene slik at man enkelt kan hente råd og informasjon om konkrete arbeidsoppgaver innenfor egen profesjon.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Kunnskapsbasert helsehjelp gir bedre kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet i møte med innbyggere.
- Bedre og mer effektiv utredning og bedre resultater av helsehjelp. Det øker pasientsikkerheten ved å redusere uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Prosess for kvalitetssikring av informasjon før tilgjengeliggjøring.

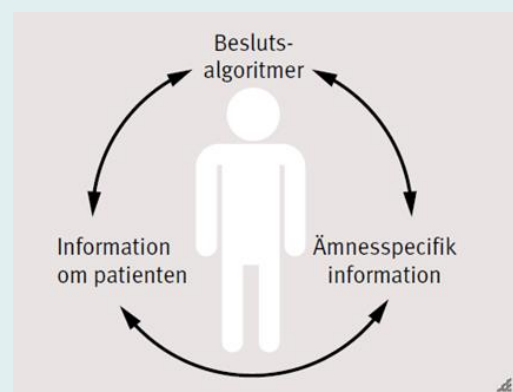
2.5.2 EH4.2: Beslutningsstøtte

Funksjonalitet EH4.2.1: Beslutningsstøtte

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet som kombinerer medisinsk, helsefaglig og annen forskningsbasert kunnskap med individuelle pasientopplysninger for å understøtte beslutninger. (48)

Figur 34. Beslutningsstøtte (49)



Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH4.2.1.1	Kan baseres på ulike typer forskningsbasert kunnskap. • Emnespesifikk informasjon, som hvilke legemidler som har interaksjoner (jf. EH3.3.4). • Digitaliserte og strukturerte veiledninger, retningslinjer eller prosedyrer (strukturert som beslutningsalgoritmer).
EH4.2.1.2	Beslutningsstøtte kan eksistere i både enkle og komplekse varianter. Dette avhenger av hvor mange aspekter som hensyntas. Eksempel på skala: 1. Forventning eller utvalg: Angir om en egenskap er som forventet eller ikke, eventuelt normal eller ikke. 2. Isolert anbefaling om ett enkelt tiltak. 3. Isolert anbefaling om en pakke eller serie tiltak. 4. Anbefaling om et eller flere tiltak mest mulig integrert i pasientens situasjon. 5. Diagnostikk og hypotesegenerering: Genererer nye hypoteser og eventuelt ny kunnskap ved å bruke kjente algoritmer på eksisterende pasientopplysninger om aktuell pasient og eventuelt andre sammenlignbare pasienter.
EH4.2.1.3	Beslutningsstøtte med varsling. Beslutningsstøtte kan fremkomme som visuelle varsler, forslag til tiltak eller oppgaver som kan ordineres, dialogbokser mv.
EH4.2.1.4	Beslutningsstøtte med soft-stop eller hard-stop. Det vil kunne variere hvor styrende beslutningsstøtte er (soft-stop/hard-stop, jf. definisjoner s. 70).
EH4.2.1.5	Beslutningsstøtte kan være integrert i plan/prosesstøtte (jf. kapittel 0).
EH4.2.1.6	Mulighet for samvalg med pasient. En variant av beslutningsstøtte som i tillegg legger til grunn individuelle preferanser og verdier fra pasienten, samvalg (jf. Funksjonalitet EH6.5.2: Beslutningsstøtte).

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Kunnskapsbasert helsehjelp gir bedre kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet i møte med innbyggere.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardisering og strukturering av informasjon.
- Oppdaterte veiledere og retningslinjer.

2.6 E-helsekapabilitet 5: Kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap

E-helsekapabiliteten sikrer at data som dokumenteres i forbindelse med helsehjelp (jf. kapittel 2.2) enkelt kan brukes til kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, beredskap og forskning.

Figur 35. E-helsekapabiliteter med underkapabiliteter: Kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap



2.6.1 EH5.1: Forvaltning av data

Denne e-helsekapabiliteten understøtter virksomhetskapabiliteten Informasjonsforvaltning.

Funksjonalitet EH5.1.1: Forvaltning av informasjonsarkitektur

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å definere og vedlikeholde spesifikasjoner av data som gir en felles definisjon av kodeverk, terminologier og informasjonselementer som skal brukes i kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Nødvendig for å oppnå en felles definisjon av data som skal gjenbrukes til ulike formål.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Etablering av en styringsmodell for forvaltning av data på tvers av de aktører som har behov for tilgang til data til kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap.

Funksjonalitet EH5.1.2: Forvaltning av felles grunndata (masterdata)

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å sikre konsistens av felles grunndata.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Nødvendig for at alle konsumenter av data til kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap bruker de samme felles grunndata.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Etablering av en styringsmodell for forvaltning av data på tvers av de aktører som har behov for tilgang til data til kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap

2.6.2 EH5.2: Datafangst og lagring

Funksjonalitet EH5.2.1: Kildeintegrasjon

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet som gjør det mulig å integrere med ulike kilder for automatisk og fortløpende kunne innhente data til kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.2.1.1	Standardiserte og harmoniserte grensesnitt for deling av data. Det skal finnes en katalog av standardiserte og harmoniserte grensesnitt for deling av data. For eksempel skal data om forekomst og behandling etc. av kreft som skal til Kreftregisteret, gjenbrukes direkte fra det som allerede er dokumentert ved ytelse av helsehjelpen. Dette vil erstatte dagens ordning hvor opplysningene må hentes manuelt til egne skjema.
EH5.2.1.2	Kobling med datasett fra andre sektorer. Det er mulig å sammenstille med andre datasett, f.eks. fra NAV og SSB (forutsatt nødvendige tillatelser). For eksempel kan data registrert i forbindelse med helsehjelp sammenstilles med data fra NAV, for å analysere effekt av ulike typer behandling sammenlignet med sykmelding og arbeidsuførhet.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Reduserer kostnader og tid for å opprettholde komplette datasett.
- Sikrer enklere og raskere sammenstilling av data fra ulike kilder.
- Bedrer kvalitet i dataene.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte og strukturerte data med enhetlig kodeverk og terminologi.
- Tilgangsstyring på datasettnivå.

Funksjonalitet EH5.2.2: Mellomlagring av data

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at data enkelt kan mellomlagres for analyseformål.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.2.2.1	Katalog over de data (fra helsehjelpen) som er tilgjengelige til analyseformål. Det finnes en katalog over de data (fra helsehjelpen) som er tilgjengelige til analyseformål. Katalogen inneholder beskrivelser av kontekst for innsamling/dokumentasjon av disse data, slik at de som har behov for nye rapporter/uttrekk velger riktig sammensetning av data til aggregerte datasett.
EH5.2.2.2	Kobling med datasett fra andre sektorer. Det er mulig å sammenstille med andre datasett, f.eks. fra NAV og SSB (forutsatt nødvendige tillatelser). For eksempel skal data registrert i forbindelse med helsehjelp sammenstilles med data fra NAV, for å analysere effekt av ulike typer behandling sammenlignet med sykmelding og arbeidsuførhet.
EH5. 2.2.3	Lagring av data av ulike formater. Det er mulig å lagre ulike typer av data (strukturerte, semistrukturerte og ustrukturerte).

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Reduserer behovet for at hver enkelt konsument av data utvikler en egen integrasjon til hver enkelt datakilde.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte og strukturerte data med enhetlig kodeverk og terminologi.

Funksjonalitet EH5.2.3: Transformering av data

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å kunne transformere data fra et format som er gitt fra kildesystemene til et felles format som er uavhengig av kildesystemenes definisjon.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.2.3.1	Forvaltning av regler for transformering av data. Det finnes funksjonalitet for å kunne angi regler for transformering av data ned på dataelementnivå.
EH5.2.3.2	Automatisk og løpende transformering som innhentes fra datakilder. Det finnes funksjonalitet for automatisk og løpende transformere data som innhentes fra ulike datakilder slik at de dataene som er tilgjengelige for kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap kontinuerlig er oppdaterte og komplette.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Sikrer enklere og raskere sammenstilling av data fra ulike kilder med ulike formater.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Felles informasjonsmodell og definisjon av data som skal brukes til kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap.

Funksjonalitet EH5.2.4: Sikring av datakvalitet

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å vaske data, fjerne duplikater, etc for å sikre kvalitet i data som er tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.2.4.1	Måling av datakvalitet. Det finnes funksjonalitet som understøtter prosesser for å kunne måle at informasjonen er komplett, riktig, konsistent
EH5.2.4.2	Maskinell og manuell datavask. I noen situasjoner må data vaskes, dvs. maskinelt eller manuelt gjennomgås for å fjerne enkelte dataelementer.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Reduserer kostnader og tid for å opprettholde komplette datasett.
- Bedrer kvalitet i dataene.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Felles informasjonsmodell og definisjon av data som skal brukes til kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap.

2.6.3 EH5.3: Tilgjengeliggjøring av data

Funksjonalitet EH5.3.1: Tilgjengeliggjøring av rådata

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet som gir brukere som skal analysere data for kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap tilgang til rådata.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.3.1.1	Håndtering av søknader for tilgang til rådata. Det finnes funksjonalitet som gir tidsbegrenset tilgang til et utvalg av rådataene som er tilgjengelige.
EH5.3.1.2	Avidentifisering av rådata. Det finnes mulighet for å avidentifisere rådata slik at kun data for innbyggere som ikke kan identifiseres er tilgjengelig for uttrekk.
EH5.3.1.3	Utlevering av rådata. Det finnes mulighet for å kunne gi tilgang til rådata basert på det sikkerhetsnivå som er godkjent for brukeren. Andre virksomheter vil ha behov for rådata for f.eks. å kunne analysere behandlingsforløp som involverer flere aktører. For de fleste brukergruppene skal kun avidentifiserbare rådata kunne gjøres tilgjengelige, mens for andre grupper vil det være nødvendig å ha tilgang til identitet på den enkelte innbygger.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Sikrer enklere og raskere sammenstilling av data fra ulike kilder, raskere tilgjengeliggjøring av kunnskap.
- Bidrar til at krav om personvern er ivarettatt ved at anonymiserte data er tilgjengelige for analyseformål (f.eks. forskning).
- Bidrar til å redusere ledetid til tilgjengeliggjøring av data ved at dataene er ferdig koblete og harmoniserte i henhold til samme kodeverk og terminologi.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Tilgangsstyring som kan gi tidsbegrenset tilgang til rådata.

Funksjonalitet EH5.3.2: Organisering og tilgjengeliggjøring av data for analyse- og rapporteringsverktøy

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet som gjør det mulig å organisere utvalg av rådata i predefinerte strukturer som datatorg (data marts).

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.3.2.1	Administrering av datatorg som er felles for mange brukergrupper. Det finnes funksjonalitet for å kunne organisere, administrere og skape datatorg.
EH5.3.2.2	Administrering av personlige datatorg. Det finnes funksjonalitet for brukere med riktig tilgang til å skape og administrere egne datatorg.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til å redusere ledetid til tilgjengeliggjøring av data ved at dataene er ferdig organisert med hensyn til ulike behov.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Tilgangsstyring som kan gi tilgang til administrasjonsfunksjonalitet for å skape og administrere datatorg.

Funksjonalitet EH5.3.3: Avlevering av pasientopplysninger til Norsk helsearkiv (Helsearkivregisteret)

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å sikre at eldre arkivverdig informasjon ikke går tapt, men arkiveres i henhold til gjeldende lovverk og standarder for nasjonale arkiver.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.3.3.1	Avlevering av pasientinformasjon på et gitt format. Det skal være mulig å avlevere relevant pasientinformasjon til Norsk helsearkiv på et standardformat.
EH5.3.3.2	Skille ut arkivverdig informasjon. Det skal være enkelt å skille ut den delen av pasientdokumentasjonen som er arkivverdig.
EH5.3.3.3	Pasientinformasjon for pasienter som har vært døde en fastsatt periode skal automatisk arkiveres. Som en del av automatiske rutiner skal informasjon om pasienter som har vært døde i en fastsatt periode arkiveres.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Ivareta krav til spesialisthelsetjenesten om å avlevere eldre, bevaringsverdige pasientarkiver til Norsk helsearkiv. Norsk helsearkiv forvalter disse for bruk til forskning og andre dokumentasjonsformål.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standard format for arkivering må være tilgjengelig.
- Standardisering og strukturering av informasjon.

2.6.4 EH5.4: Gjennomføring av analyse

Data som blir fanget, transformert og gjøres tilgjengelig for kvalitetsforbedring, ledelse, helseanalyse, forskning og beredskap skal kunne analyseres både på virksomhetsnivå, kommunalt nivå, regionalt nivå og nasjonalt nivå. Analysene skal kunne brukes til ulike formål. Denne underkapabiliteten omfatter et utvalg av funksjonalitet for ulike brukergrupper.

Funksjonalitet EH5.4.1: Analyse for å understøtte kvalitetsforbedring

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet som gjør det mulig å analysere og tilgjengeliggjøre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten for den enkelte helsepersonell, for virksomheter og for sektoren på ulike nivåer.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.4.1.1	Tilgang til informasjon om egen behandlingspraksis. Det enkelte helsepersonell har enkel tilgang til informasjon om egen behandlingspraksis, med mulighet for å sammenligne egne resultater med andre med samme rolle/spesialitet og andre enheter med lignende pasientpopulasjon. Presentasjon må gjøre det mulig og kunne angi avdelingens/enhetens/personens kvalitet på utført helsehjelp, eksempelvis resultat, komplikasjoner, effektivitet og pasienttilfredshet. Det bør også være mulig å se resultater fra egne pasienter helhetlig gjennom behandlingsforløpet. Videre må det være mulighet for å gjøre analyser på pasientpopulasjoner, for eksempel må en fastlege kunne gjennomføre en analyse på egen fastlegeliste.
EH5.4.1.2	Analyse av kvalitet. Det er støtte for å utarbeide analyser og rapporter av forhold knyttet til kvalitet på ulike nivå i virksomheten, fra det enkelte helsepersonell, til avdeling og virksomheten som helhet. Det er fleksibilitet til enkelt å tilpasse eksisterende analyse og rapporter, med hensyn til både innhold og frekvens, samt mulighet å utarbeide nye analyser og rapporter. Informasjonen er tilgjengelig for leder som grunnlag for kvalitetsoppfølging av medarbeidere og virksomhet.

EH5.4.1.3	Oppfølging av kvalitet. Rapporter og oppfølging må kunne gi grunnlag for løpende måling av kliniske resultater inkludert komplikasjonsregistrering, rehabilitering, oppfølging av pasienten etter utskrivelse både ved direkte kontakt med pasienten og med helsepersonell utenfor egen virksomhet. Eksempler på relevante rapporter/analyser er data og nøkkeltall knyttet til kvalitet, informasjon om avvik, uønskede hendelser og komplikasjoner.
EH5.4.1.4	Analysere data for systematisk kvalitetsforbedring på tvers av virksomheter. Rapporter og indikatorer som brukes til å analysere kvalitetsindikatorer på tvers av virksomheter. Eksempler på indikatorer er resultat av helsehjelp, ulikheter i behandling, komplikasjoner og tilfredshet.
EH5.4.1.5	Offentlig publisering av kvalitetsindikatorer. Utvalgt informasjon kan automatisk tilgjengeliggjøres for offentlig publisering, bl.a. kvalitetsindikatorer (f.eks. liggetid, utsatte operasjoner, antall dager siden alvorlig brudd på pasientsikkerhet osv.)

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Kvalitets- og resultatoppfølging er det viktigste tiltaket for å sikre et systematisk kvalitetsarbeid på alle nivåer i en virksomhet/enhet.
- Læring og erfaringsbygging. Funksjonaliteten gir viktig informasjon om hvor virksomheten bør iverksette tiltak for å bedre kvaliteten.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte og strukturerte data.
- Definerte kvalitetsindikatorer som lar seg måle og kan rapporteres online.
- Standardisering av pasientgrupper, datasett, arkitektur og rapporteringsmåter.
- Ensartet definisjon og beskrivelse av behandlingsopplegg/prosedyrer for å sikre at man kan definere mulige forskjeller og sammenligne resultater.

Funksjonalitet EH5.4.2: Analyse for å understøtte styring og ledelse

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet som gjør det mulig å analysere drift og styre kapasitet (personer, utstyr, rom, etc.) i henhold til behovene. Funksjonaliteten brukes for langsiktig planlegging som innkjøp og ansettelser og operativ oppfølging.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.4.2.1	Analyse av kostnad per pasient. Det er støtte til å beregne kostnad per pasient for hele behandlingsforløpet, også på tvers av virksomheter. Kostnad per pasient er et viktig målepunkt for å kunne måle klinisk virksomhet og sammenligne organisasjoner/enheter som leverer samme type tjenester. Kunnskap om kostnader ved helsehjelp er fundamental kunnskap for å kunne sammenligne tjenester i forhold til effektivitet og kvalitet, og for å utvikle finansieringsordninger som kan bidra til en bedre og mer effektiv ressursutnyttelse i helse- og omsorgstjenesten.
EH5.4.2.2	Analyse av kapasitetsutnyttelse. Fortløpende se over- og underkapasitet og ventetider for tjenester. Utfra analyser av skjevfordeling kan man se hvilke tjenester som har for lav bruk og hvilke som trenger mer tilgang til ressurser. Mulighet for å planlegge bemanningsbehov basert på kunnskap om hvordan driftssituasjonen endrer seg gjennom året, særlig ved sesongbetonte endringer i pasienttilgangen og i bemanningen. Mulighet for simuleringer.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bedre og mer rasjonell drift samt bedre utnyttelse av personell og andre ressurser, kostnadsbesparelser.
- Kortere ventetid.
- Øket forståelse for arbeidsprosesser og mobilitet av pasienter og personell innenfor enheter/avdelinger og institusjoner.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Definerte tjenester.

Funksjonalitet EH5.4.3: Analyse for å understøtte beredskap og helseanalyse

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gjennomføre løpende analyse av data fra helsehjelpen slik at man kan se mønstre og avdekke endringer i befolkningens helsetilstand, epidemier og sykdomsutvikling tidligere enn i dag.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH5.4.2.1	Smittevern og overvåking. Det er støtte for løpende overvåking og smittesporing for pasienter med smittsomme sykdommer. Det er varsling og automatisk melding for meldepliktige sykdommer når prøvesvar konkluderer med slike diagnoser. Det er støtte for gjenkjenning av mønstre ved mulige epidemier og utbrudd og det varsles hvis slike mønstre oppstår. Det er ved utbrudd mulig å følge hvor i helse- og omsorgstjenesten pasienten har vært for å kunne drive smittesanering.
EH5.4.2.2	Løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Det er støtte for løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen, med støtte for simulering, beregninger, modellering og visualisering. Det finnes varslingsmekanismer som basert på analyser kan varsle om endring i mønstre på et tidlig tidspunkt. Det er fleksibilitet knyttet til å definere regelmessige rapporter både mht. innhold og frekvens, samt støtte for enkelt å kunne tilgjengeliggjøre rapporter, kvalitetsindikatorer og statistikk. Indikatorer er målbare og sammenlignbare, og omfatter også drifts-/administrative data, økonomiske data og kvalitetsdata, både i forhold til gjennomføring og resultater samt ressursforbruk.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Hurtigere sporing av epidemier og smittsomme sykdommer samt raskere sporing av smittesituasjoner, redusere spredning. Bedre mulighet for å prognostisere skadeomfang/-utvikling.
- Økt kunnskap for å kunne målrette tiltak og styre både i helse- og omsorgstjenesten og tverrsektorielt.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte og strukturerte data, sammenlignbare på tvers av virksomheter.
- Standardiserte nasjonale kvalitetsindikatorer som også omfatter kliniske resultater og andre områder som samfunnet ønsker å måle helse- og omsorgstjenesten på.

2.7 E-helsekapabilitet 6: Innbyggertjenester

Kapabiliteten gir innbygger tilgang til egne helseopplysninger og gjør innbygger i stand til å utføre mer selv, bedre mestre egen helsesituasjon og bidra til en mer aktiv pasient- og pårørenderolle. Innbygger får også tilgang til tilpasset informasjon om helse og helse- og omsorgstjenesten.

Mye av funksjonaliteten beskrevet for innbygger er også beskrevet for helsepersonell under e-helsekapabilitet 1-4, da en realisering for helsepersonell er en forutsetning for realisering for pasienter. Det må skje en tilpassing før tilgjengeliggjøring for pasienter, bl.a. sikkerhetsløsninger og forenklinger i brukergrensesnitt.

Personverntjenester for innbygger er beskrevet i kapittel 2.8.

Figur 36. E-helsekapabilitet med underkapabiliteter: Innbyggertjenester



2.7.1 EH6.1: Administrative tjenester

Funksjonalitet EH6.1.1: Avtaleadministrasjon

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at innbygger skal kunne bestille, endre og avbestille tjenester/avtaler i henhold til sine rettigheter.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.1.1.1	Styring av hvilke tjenester innbygger selv kan bestille og endre. Det er oversikt over tilgjengelige tidspunkt for ulike tjenester, og løsningen gir støtte til å finne ledige tidspunkt i tråd med innbyggers preferanser. Det er ikke alle tjenester som egner seg for selvbetjening, så som kostbare og komplekse tjenester, og regler vil styre hvilke tjenester innbygger selv kan bestille og endre.
EH6.1.1.2	Støtte for å kunne gjøre en samlet bestilling av flere tjenester. Ved behov for flere tjenester hos samme virksomhet er det støtte for at innbygger skal kunne gjøre en samlet bestilling.
EH6.1.1.3	Støtte for å kunne sette seg på venteliste. Det er støtte for at innbygger kan sette seg på venteliste for definerte tjenester, dersom det bli en ledig time tidligere.
EH6.1.1.4	Varsler og påminnere. Innbygger kan få varsler og påminnere om nært forestående avtaler gjennom valgfrie kanaler (SMS, e-post, kalendervarsling). Varsler kan inneholde informasjon som er relevant for den enkelte tjenester, for eksempel informasjon om faste. Det er gjennom varslene også enkel mulighet for å kunne endre eller kansellere avtaler.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til redusert andel ikke-møtt,
- Gir redusert tidsbruk knyttet til å flytte/bytte avtaler for både innbygger og helse- og omsorgstjenesten.
- Bidrar til økt pasienttilfredshet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Katalog som viser hvilke aktører som yter hvilke tjenester.
- Hver aktør har en oppdatert kalender over tidspunkt for gjennomføring av ulike tjenester.

Funksjonalitet EH6.1.2: Søke om helse- og omsorgstjenester og andre ytelser

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at innbygger kan søke om helse- og omsorgstjenester eller andre ytelser som ikke er gjenstand for å bli rekvirert eller henvist til. Eksempler på tjenester er sykehjemsplass, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, avlastning, støttekontakt og trygghetsalarm.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.1.2.1	Digitale søknader. Det er funksjonalitet for digital søknad for alle relevante helse- og omsorgstjenester, med støtte for informasjon om tjenestetilbud og retningslinjer. Det er støtte til å finne korrekt mottaker av søknaden.
EH6.1.2.2	Forhåndsutfylling av søknader. Søknaden forhåndsutfylles med relevante helseopplysninger.
EH6.1.2.3	Status på behandling av søknader. Innbygger kan se status på søknaden samt informasjon om når det kan forventes at søknad er behandlet. Når søknaden er ferdig behandlet blir innbygger varslet om dette og vedtaket er tilgjengelig digitalt.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Gir enklere og mer effektiv søknadsprosess.
- Gjør det enklere å finne korrekt mottaker.
- Gjør det enklere for innbygger å få informasjon om status i saken.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Katalog som viser hvilke aktører som yter hvilke tjenester.

Funksjonalitet EH6.1.3: Øvrige administrative tjenester

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at innbygger kan utføre ulike administrative tjenester.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.1.3.1	Forlenge ordinasjon/reseptfornyelse. Innbygger kan be om at en ordinasjon kan forlenges, eventuelt i form av en resept som fornyes. Det er mulig for lege eller annen rekvirent å legge inn regler som brukes for automatisk å gi en fornyelse.
EH6.1.3.2	Fastlegebytte. Det er oversikt over alle fastleger, med informasjon om fasiliteter, spesialiteter mv. Det er enkelt å bytte fastlege og ev. sette seg på venteliste dersom ønsket fastlege ikke har ledig plass.
EH6.1.3.3	Europeisk helsetrygdkort. Det er støtte for å kunne bestille Europeisk helsetrygdkort for innbygger og øvrige familiemedlemmer. Det er varsel til innbygger når utløpstiden for helsetrygdkortet nærmer seg.
EH6.1.3.4	Tilbakemeldinger til helse- og omsorgstjenesten. Det skal finnes funksjonalitet for at innbygger skal kunne gi strukturert tilbakemelding til helse- og omsorgstjenesten om hvordan han/hun opplevde møtet med tjenesten.
EH6.1.3.5	Klage på helsehjelp. Det er funksjonalitet for at innbygger kan klage på helsehjelpen som er mottatt, og med støtte for å legge ved relevant informasjon i saken. Det er mulighet for å se status i saken. Det er støtte for å finne frem til korrekt klageorgan.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Gjør det enklere og mer effektivt å utføre administrative oppgaver for innbygger.
- Gjør det enklere for innbygger å få informasjon om status i saken.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Katalog som viser hvilke aktører som yter hvilke tjenester.

2.7.2 EH6.2: Tilgang til helseopplysninger og rettigheter

Funksjonalitet EH6.2.1: Tilgang til egne helseopplysninger

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger samlet tilgang til alle registrerte opplysninger om egen helse, uavhengig av hvor helsehjelp er gitt.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.2.1.1	Oversiktlig fremstilling. Fremstilling av informasjonen er oversiktlig og tilpasset innbyggernes behov og språk. Informasjon knyttet til avtaler frem i tid og pågående behandling/problemløsning vises først, med mulighet for å søke informasjon tilbake i tid.
EH6.2.1.2	Mulighet for å søke og å filtrere informasjon. Det er gode muligheter for å søke etter og filtrere informasjonen på ulike måter, for eksempel avgrenset til en diagnose, et behandlingsforløp eller et behandlingssted. Det er mulig å få en kronologisk fremstilling av hendelser relatert til helsehjelpen gjennom en helhetlig tidslinje. Det fremgår hvem som har registrert hvilke opplysninger og når de ble registrert.
EH6.2.1.3	Forsinkelse i tilgjengeliggjøring av enkelte opplysninger. Det er funksjonalitet for at enkelte opplysninger ikke gjøres tilgjengelig for innbygger digitalt før innbygger har fått formidlet informasjonen direkte fra helsepersonell.
EH6.2.1.4	Forklaringer tilpasset brukeren. Det er støtte for at innbygger enkelt kan få forklaring på medisinsk terminologi og vanskelige begreper, slik at de bedre kan forstå opplysninger knyttet til egen helsesituasjon.
EH6.2.1.5	Mulighet for å rette og slette informasjon. Det er støtte for at innbygger enkelt skal kunne få rettet, eventuelt slettet, informasjon som er feil eller mangelfull, jf. Funksjonalitet EH7.1.2: Retting og sletting av registrerte opplysninger.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Gir økt oversikt og innsikt i egen helsesituasjon.
- Stimulerer til mestring av egen sykdom.
- Bidrar til færre misforståelser av informasjon som ellers blir glemt.
- Vil gi innbygger bedre oversikt over kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
- Vil redusere den tid innbygger bruker på å lete etter informasjon.
- Bidrar til økt pasienttilfredshet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Sikkerhetsløsning for innbyggere.
- Informasjonen til innbygger er konsolidert uavhengig av hvor innbygger har mottatt helsehjelp.
- Strukturert og standardisert informasjon.
- Retningslinjer for hvilke opplysninger som eventuelt ikke skal være tilgjengelig digitalt før innbygger har fått formidlet informasjonen direkte fra helsepersonell.

Funksjonalitet EH6.2.2: Oversikt over egne pasientrettigheter og valgmuligheter

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger tilgang til en samlet og oppdatert oversikt over sine rettigheter og valgmuligheter.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.2.2.1	Allmenne og betingede rettigheter. Enkelte rettigheter er allmenne, mens andre er betinget av at det er igangsatt tiltak som for eksempel en henvisning, et vedtak eller en diagnose.
EH6.2.2.2	Person- og situasjonstilpasset presentasjon av rettigheter.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

	Informasjonen er person- og situasjonstilpasset. F.eks. vil en prioritert pasient med behandlingsfrist kunne se gjeldende frist, samt hvilke rettigheter et eventuelt fristbrudd utløser. Pasienten vil også se informasjon om sine valgmuligheter, eksempelvis valg av behandlingssted.
--	--

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til økt etterlevelse av pasientrettigheter.
- Bidrar til at innbygger har bedre oversikt over og økt bevissthet rundt sine rettigheter.
- Kan bidra til færre fristbrudd, kortere ventetid, bedre kvalitet og pasientsikkerhet, forsterket pasientrolle.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte definisjoner for tjenester på tvers av aktører.
- Standardiserte definisjoner for pasientadministrasjon på tvers av aktører.

Funksjonalitet EH6.2.3: Tilgang til eget barns helseopplysninger

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi foreldre samlet tilgang til alle registrerte opplysninger om deres barns helse, samt oversikt over barnets pasientrettigheter og valgmuligheter.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.2.3.1	Innsyn i barns opplysninger. Foreldre har mulighet for innsyn i helseopplysninger som er registrert om sine barn frem til de er 16 år.
EH6.2.3.2	Egenskaper tilsvarende: • Funksjonalitet EH6.2.1: Tilgang til egne helseopplysninger • Funksjonalitet EH6.2.2: Oversikt over egne pasientrettigheter og valgmuligheter

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Foreldre har rett til innsyn i sine barns helseopplysninger.
- Gir økt oversikt og innsikt i egne barns helsesituasjon.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Sikkerhetsløsning for innbyggere.
- Oppdatert folkeregister med informasjon om familieforhold.

Funksjonalitet EH6.2.4: Dele egne opplysninger

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger mulighet å gi andre tilgang til helseopplysninger og fullmakter til å samhandle med helse- og omsorgstjenesten på sine vegne.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.2.4.1	Be om/motta fullmakt fra annen person. Innbygger kan be om/motta fullmakt fra andre.
EH6.2.4.2	Tidsbegrensning av fullmakt. Innbygger skal kunne sette begrensning på tid og/eller omfang av tilgang.
EH6.2.4.3	Oversikt over gitte fullmakter Innbygger skal ha enkel oversikt over hvem som har hvilke fullmakter.
EH6.2.4.4	Styre rettigheter for andres tilganger. Forutsatt samtykkekompetanse, kan innbygger på en enkel måte styre hvilke rettigheter ulike personer skal ha – både hvilke helseopplysninger de skal ha tilgang til og hvilke mulighet de skal ha til å samhandle med helse- og omsorgstjenesten på vegne av seg. Dette inkluderer også mulighet for å benytte selvbetjeningsløsninger.
EH6.2.4.5	Predefinerte fullmakter for personer uten samtykkekompetanse.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

	For personer med manglende samtykkekompetanse er det mulig å predefinere hvem som har fullmakter. Foreldre har, med mindre annet er bestemt, tilgang til sine barns journaler i henhold til lovverk.
--	--

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til økt pasientsikkerhet.
- Gjør det mulig for innbygger enklere å involvere pårørende og andre i egen helse - forberedelser, vurderinger og valg knyttet til egen behandling.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Løsninger for tilgangsstyring.
- Strukturert og standardisert informasjon.

2.7.3 EH6.3: Egenregistrering

Funksjonalitet EH6.3.1: Egenregistrering og egenmålinger

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger mulighet til å registrere egne helseopplysninger og målinger, manuelt eller ved bruk av eksternt måleutstyr (m-helseutstyr).

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.3.1.1	Registrering initiert av helsepersonell. Helsepersonell kan be pasient om utfylling av spesifikk informasjon slik som tidligere sykdommer, praktiske forhold i hjemmet m.m. som forberedelse til planlagt utredning og inngrep. Ved en del helseproblemer vil helsepersonell be pasienten om å fylle ut symptomer og deres påvirkning på hverdagen for å kartlegge plagene.
EH6.3.1.2	Bruk av innbyggernes egenregistrerte opplysninger. Innbygger kan registrere helserelaterte egenmålinger, kommentere informasjon i journalen eller foreta egne notater i forkant av en konsultasjon. Innbygger kan velge om det enkelte informasjonselement skal kunne deles med helse- og omsorgstjenesten (i henhold til retningslinjer) eller om den kun skal registreres for personlig bruk. Det skal, for alle som har tilgang til journalen, tydelig fremgå hva som er registrert av helsepersonell og hva som er registrert av pasient eller pårørende.
EH6.3.1.3	Gjenbruk av egenregistrerte opplysninger. Tidligere registrert informasjon gjenbrukes, eventuelt med mulighet for å bekrefte/avkrefte av informasjonen fremdeles er gyldig og dekkende.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til mer oppdaterte og komplett datagrunnlag.
- Bidrar til at innbygger har bedre oversikt over og økt bevissthet rundt egen helsesituasjon.
- Bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Løsninger for tilgangsstyring.
- Tekniske grensesnitt for tilkobling av teknisk utstyr.
- Strukturert og standardisert dokumentasjon.

2.7.4 EH6.4: Dialog og samhandling i forbindelse med helsehjelp

Funksjonalitet EH6.4.1: Enkel digital helsehjelp

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger støtte til å kunne kommunisere og samhandle digitalt med ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.4.1.1	E-kontakt og e-konsultasjon. Det skal være støtte for at innbygger kan stille spørsmål til behandler (e-kontakt og e-konsultasjon), og motta og sende dokumenter i forbindelse med behandling.
EH6.4.1.2	Tydelig oversikt over helsepersonell som er tilgjengelig for e-kontakt/e-konsultasjon. Det er oversikt over og regler for hvem innbyggeren kan starte en dialog med, ut i fra det/de behandlingsløp som er aktive og hvilke behandlere som følger opp innbygger, eventuelt en koordinator. Det vil også finnes mottakere som er tilgjengelige uten at innbygger har et aktivt forløp, slik som journalansvarlig ved virksomhetene.
EH6.4.1.3	Opprette/administrere personlig dialogprofil. Innbygger skal kunne kontrollere sin dialog med helse- og omsorgstjenesten gjennom en personlig dialogprofil som definerer hvilken type informasjon som ønskes mottatt fra ulike aktører.
EH6.4.1.4	Oversikt over status på dialogen. Det må være støtte for varsling om at nytt innhold er tilgjengelig og når sendte meldinger ikke blir lest.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Gjør det enklere for innbygger å ha kontakt med helse- og omsorgstjenesten,
- Gjør at behov for personlig oppmøte reduseres, tidsbesparende.
- Bidrar til økt trygghet og økt kvalitet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Finansieringssystem som understøtter digital dialog.
- Tjenestekatalog.

Funksjonalitet EH6.4.2: Samhandlingsarena

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å understøtte samhandling med en gruppe helsepersonell når innbygger følges opp av et behandlingsteam, eller har behov for individuell plan.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.4.2.1	Initiering og deltakelse i utarbeidelse av individuell plan Innbygger kan initiere og delta i utarbeidelse av egne planer (individuell plan).
EH6.4.2.2	Samhandlingsrom for deling av informasjon Innbygger har sammen med behandlere og andre som er involvert i et behandlingsforløp, tilgang til et samhandlingsrom der de kan dele informasjon.
EH6.4.2.3	Mulighet til å invitere pårørende Innbygger har mulighet til å invitere inn pårørende eller andre de ønsker skal involveres.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Gjør det enklere å etablere teamorientert samhandling der innbygger er involvert i samhandlingen.
- Bidrar til økt trygghet og økt kvalitet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Løsninger for tilgangsstyring.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

2.7.5 EH6.5: Kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte, prosessstøtte og støtte til egendiagnostisering

Funksjonalitet EH6.5.1: Kunnskapsstøtte

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger tilgang til relevant opplæring og rådgiving tilpasset egen helsesituasjon, basert på oppdatert og forskningsbasert kunnskap.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.5.1.1	Opplæring og rådgiving tilknyttet tiltak innbygger har ansvar for. Innbygger har tilgang til opplæring og rådgiving tilknyttet tiltak innbygger selv har ansvar for, som å ta medisiner, skifte på et sår, daglige øvelser eller observere egen sykdomsutvikling. Opplæring og rådgiving kan eksempelvis omhandle: faresignaler og tiltak ved forverring; forhåndsregler (f.eks. tilknyttet legemiddelbruk); informasjon om øvelser; råd om forebygging (f.eks. ved risikofaktorer som tidligere diagnoser, prøveresultater/målinger eller genetiske disposisjoner); anbefalte forberedelser før konsultasjon/behandling; informasjon om pasient- og støtteorganisasjoner
EH6.5.1.2	Generell kunnskapsstøtte. Det er behov for at innbygger kan få støtte til å forstå resultater/informasjon som gjøres tilgjengelig, såkalt kunnskapsstøtte (jf. behov 10). Eksempelvis har innbygger behov for en oppdatert legemiddelliste, men også informasjon om potensielle bivirkninger og faresignaler. Ved konstatert diagnose trenger innbygger informasjon om hva diagnosen innebærer for seg.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Funksjonaliteten bidrar til å gi innbygger økt kunnskap og bevissthet om egen helsesituasjon.
- Funksjonaliteten bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte veiledere.
- Dynamisk og fortløpende forvaltning av veiledere.

Funksjonalitet EH6.5.2: Beslutningsstøtte

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger tilgang til beslutningsstøtte som kan være til hjelp for innbygger i valg av behandling og behandlingssted.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.5.2.1	Parameter som styrer beslutningsstøtte. Beslutningsstøtte er basert på egne helseopplysninger (inkludert pasientrettigheter og valgmuligheter), personlige preferanser (bivirkninger, risiko for komplikasjoner, kostnader, behov for kontroll og oppfølging), samt oppdatert og forskningsbasert kunnskap.
EH6.5.2.2	Samvalgsløsninger. Samvalgsløsninger er en variant av beslutningsstøtte som i tillegg tar inn pasientens individuelle preferanser i utarbeidelsen av forslag til behandling og behandlingssteder. <u>Eksempler:</u> Innen psykiatrien har mange legemidler noe forskjellig bivirkningsprofil. Pasienten kan registrere hvilke bivirkninger de opplever mest plagsomme. Systemet vil foreslå de legemidlene som er best kompromiss mellom symptomer, behandlingsmål og bivirkninger. Kreftbehandling med langvarige behandlingsopplegg kan gi betydelige bivirkninger. Pasientens preferanse for mat og behandling av kvalme kan legges inn i systemet og sikrer at pasientens ønsker realiseres ved hver behandlingsepisode.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til å gi innbygger økt kunnskap og bevissthet om egen helsesituasjon.
- Bidrar til forsterket pasientrolle og bedre grunnlag for å ta valg som er best for den enkelte.
- Bidrar til økt pasienttilfredshet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Organisasjon for utvikling og forvaltning av regler for beslutningsstøtte.
- Standardisert og strukturert dokumentasjon av pasientønsker/preferanser.
- Strukturert og standardisert dokumentasjon.

Funksjonalitet EH6.5.3: Støtte til egendiagnostisering

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger mulighet til, for utvalgte symptomer, å registrere disse og få en indikasjon på diagnose samt eventuelle råd om egenbehandling eller om å konferere helsepersonell.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.5.3.1	Grunnlag for egendiagnostisering. Informasjon om symptomer kan kobles med tidligere diagnoser og problemhistorikk og eventuelt data fra egenmålinger for å få en mest mulig presis indikasjon.
EH6.5.3.2	Deling av resultater fra egendiagnostisering. Det er mulig å dele informasjonen med helsepersonell etter definerte prosedyrer.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til å gi innbygger økt bevissthet om egen helse.
- Bidrar til forbedret kvalitet på konsultasjon fordi pasient er bedre forberedt.
- Bidrar til forbedret forebyggende arbeid.
- Bidrar til redusert etterspørsel etter unødvendige helse- og omsorgstjenester, tidsbesparende for innbygger.
- Bidrar til økt innbyggertilfredshet.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Strukturert og standardisert dokumentasjon.
- Organisasjon for utvikling og forvaltning av regler for beslutningsstøtte.

Funksjonalitet EH6.5.4: Plan og prosesstøtte

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger som gjennomgår behandlingsforløp med flere beslutningspunkter og ulikt informasjonsbehov i løpet av behandlingsforløpet, en helhetlig og aktiv støtte til prosessen. Prosesstøtte er relevant for standardiserte behandlingsforløp, eksempelvis pakkeforløp for kreft, og bør understøtte hele forløpet (utredning, behandling, rehabilitering, pleie/omsorg).

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH6.5.4.1	Parameter som styrer prosesstøtte. Prosesstøtte er basert på egne helseopplysninger (inkludert pasientrettigheter og valgmuligheter), personlige preferanser (bivirkninger, risiko for komplikasjoner, kostnader, behov for kontroll og oppfølging), samt oppdatert og forskningsbasert kunnskap.
EH6.5.4.2	Det fremgår tydelig hvilken aktør og hvilke helsepersonell/helsepersonellteam som til enhver tid har ansvaret for gjennomføring av aktuelle oppgaver. Planen støtter teamorganisering av helsehjelp (jf. primærhelsemeldingen (17) om primærhelseteam og

	oppfølgingsteam).
EH6.5.4.3	Hvert tiltak/hver oppgave vises med status (planlagt/gjennomført). Viser også tidspunkt for gjennomføring, eventuelt frist for gjennomføring.
EH6.5.4.4	Planen støtter tverrsektoriell teamorganisering. Understøtter koordinering av tverrsektorielle ansvarsgrupper. Planen kan inngå i individuell plan (tverrsektoriell).
EH6.5.4.5	Planen kan fremstilles både overordnet og detaljert. Det er mulig å se planen på ulike nivå, fra oppgaver fordelt på timer i en dag og til å se flere år om gangen.
EH6.5.4.6	En pasient kan ha flere planer. En pasient vil kunne inngå i flere behandlingsforløp, og potensielt flere planer. Dette gjelder spesielt multisyke. Løsningen håndterer eventuelle avhengigheter mellom de ulike planene.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Bidrar til å gi innbygger økt kunnskap og bevissthet om egen helsesituasjon.
- Bidrar til forsterket pasientrolle og bedre grunnlag for å ta valg som er best for den enkelte.
- Bidrar til økt pasienttilfredshet.

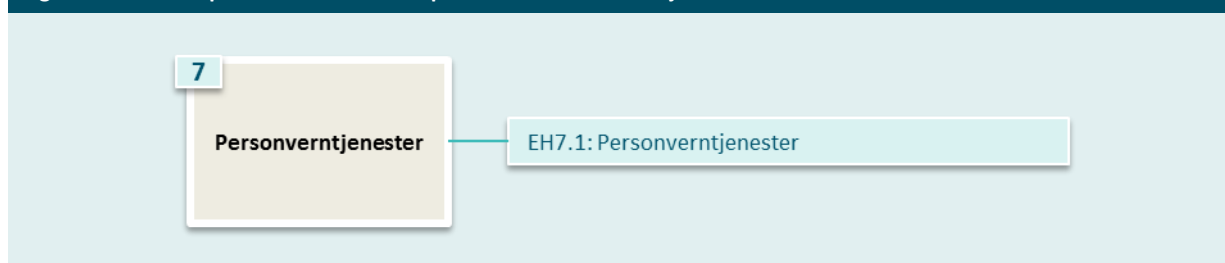
Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Standardiserte behandlingsforløp.
- Standardisert og strukturert dokumentasjon av pasientønsker/preferanser.
- Strukturert og standardisert dokumentasjon.

2.8 E-helsekapabilitet 7: Personverntjenester

Kapabiliteten skal tilrettelegge for et godt personvern for pasient og innbygger ved å tilby funksjonalitet som gjøre de enklere for pasient og innbygger å ha kontroll med egne opplysninger og ivareta sine rettigheter, samt at det settes inn tiltak for å sikre effektiv tilgangsstyring, logging mv.

Figur 37. E-helsekapabilitet med underkapabiliteter: Personverntjenester



2.8.1 EH7.1: Personverntjenester

Funksjonalitet EH7.1.1: Innsyn

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at innbygger og de som innbygger ønsker å involvere har mulighet til innsyn i informasjon som er registrert om dem og innsyn i hvem som har hatt tilgang til opplysningene.

Tilgang til helseopplysninger og rettigheter er beskrevet mer detaljert i kapittel 0.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH7.1.1.1	Innsyn i egne opplysninger. Innbygger har mulighet for innsyn i helseopplysninger som er registrert om seg selv og logg over bruk.
------------------	--

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Oppfylle lovpålagte rettigheter og funksjoner for ivaretagelse av innbyggers personvern.

Funksjonalitet EH7.1.2: Retting og sletting av registrerte opplysninger

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å gi innbygger mulighet å utøve sin rett til å få rettet eller slettet opplysninger om seg selv som er feilaktige eller mangelfulle.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH7.1.2.1	Mulighet til å kreve retting/sletting av helseopplysninger Innbygger skal kunne fremme krav om å få rettet eller slettet helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre. Henvendelsen videreformidles til rette virksomhet for vurdering.
EH7.1.2.2	Varsel til andre virksomheter ved endringer. Dersom det foreligger kopier av informasjonen hos andre virksomheter, vil det være mulig å identifisere disse slik at de kan varsles om endringene.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Økt kvalitet og pasientsikkerhet ved å ha mer korrekte helseopplysninger.
- Oppfylle lovpålagte rettigheter og funksjoner for ivaretagelse av innbyggers personvern.

Funksjonalitet EH7.1.3: Samtykke, reservasjon, sperring

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å registrere innbyggers samtykke, reservasjon og sperring til bruk av tjenester eller tilgjengeliggjøring av informasjon.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH7.1.3.1	Samtykke. Innbygger skal kunne registrere samtykke på bruk av tjenester og tilgjengeliggjøring av informasjon. Det skal for eksempel være mulig å registrere samtykke til sekundærbruk av opplysninger, eller å låse opp tidligere sperringer av informasjon.
EH7.1.3.2	Reservasjon Innbygger skal kunne reservere seg mot nasjonal kjernejournal og enkelte tilfeller av sekundærbruk av opplysninger. Reservasjoner skal kunne endres etter innbyggers ønske.
EH7.1.3.3	Sperring eller motsette seg tilgjengeliggjøring av helseopplysninger Innbygger skal kunne motsettes seg (sperre) at hele eller deler av journalen kan tilgjengeliggjøres for enkeltpersoner eller grupper. Dersom innbygger ønsker det kan helsepersonell eller andre brukere utføre dette på vegne av innbygger. Informasjon som er sperret må kunne låses opp igjen hvis innbygger gir sitt samtykke til det.
EH7.1.3.4	Mulighet for sperring av informasjon for foreldre til barn 12-16 år. Helsepersonell skal, i samråd med barn mellom 12 og 16 år, kunne sperre informasjonselementer fra foreldrene.
EH7.1.3.5	Tilgang til sperret informasjon ved livstruende sykdom eller skade. Enkelte informasjonselementer skal kunne låses opp av helsepersonell dersom innbygger er livstruende syk eller skadet og ikke selv kan gi sitt samtykke til dette.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Oppfylle lovpålagte rettigheter og funksjoner for ivaretagelse av innbyggers personvern.
- Opprettholde tillitt til helse- og omsorgstjenestene.

Funksjonalitet EH7.1.4: Tilgangsstyring

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å styre helsepersonells tilgang til å lese og/eller skrive informasjon på gruppe-, rolle- eller personnivå slik at bare de som er autorisert for tilgang får dette.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH7.1.4.1	Tilgangsstyring på gruppe-, rolle- eller personnivå, eventuelt også etter type informasjon. Brukernes tilganger kan styres på både gruppe-, rolle eller personnivå. Helsepersonells tilgang er regulert av bestemmelser i pasientjournalloven basert på tjenstlig behov, samt overstyring fra pasient i form av sperring som gir begrensninger i informasjonstilgang. Det kan også være aktuelt å styre tilgang for enkelte typer informasjonelementer som ansees som særlig sensitive.
EH7.1.4.2	Tilpasninger til lokale forhold, roller, ansvar og organisering. Tilgangsstyringen må kunne tilpasses lokale forhold i utøvelse av helsehjelp.
EH7.1.4.3	Midlertidig tilganger og avslutning av tilganger. Tilgangsstyringen må dekke behov for vikarer og annet personell som skal ha midlertidig tilgang, og med mulighet for å stoppe tilgang ved permisjon eller når personell slutter.
EH7.1.4.4	Oversikt over tilganger. Det skal være løsninger for å kunne se hvem som har hvilke tilganger.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Opprettholde lovpålagte rettigheter og funksjoner for ivaretagelse av innbyggers personvern.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Informasjonen må være tilstrekkelig strukturert og ha gode metadata, slik at tilgangen kan begrenses til det som er relevant.
- Gode og oppdaterte autorisasjonskilder, som personregister, helsepersonellregister, fastlegeregister og virksomhetsinformasjon.
- Identitets- og autentiseringsløsninger av tilstrekkelig kvalitet.

Funksjonalitet EH7.1.5: Logg og logganalyse over tilganger og innsyn

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for å logge og analysere hvem som bruker sine tilganger til å se hvilke opplysninger og når.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH7.1.5.1	Logg over innsyn. Alle oppslag i behandlingsrettede helseregistre loggføres automatisk med hvem som har brukt sin tilgang til å se hvilke opplysninger og når.
EH7.1.5.2	Varsling ved avvik og unormale bruksmønstre. Det er varsling ved avvik og unormale bruksmønstre.
EH7.1.5.3	Innbygger har tilgang til logg. Innbygger har rett til innsyn i logg over hvem som har tilgang til sine helseopplysninger, og hvem som har gjort hvilke oppslag. Det bør tilrettelegges for at dette innsynet kan skje elektronisk.
EH7.1.5.4	Korrelert med innbyggerens kontakthistorikk. Loggen kan fremstilles korrelert med pasientens kontakthistorikk, slik at pasient/annen bruker kan se bruk av informasjon i relasjon med hvor i helse- og omsorgstjenesten pasienten har vært. F.eks. kan en mulig utforming være at en pasient som har vært på legevakten logge seg inn når han/hun er hjemme og se at sykepleier A som han snakket med på telefon har registrert opplysninger, legen har lest fem av åtte notater og ordinert legemiddel og registrert opplysninger, mens sykepleier B har sett økonomisk oppgjør.
EH7.1.5.5	Ivaretagelse av helsepersonells personvern. Tilgang til logg bør utformes med avveining også for personvern for helsepersonell sitt personvern. Eksempelvis kan en vurdere virkemidler som kun fornavn eller tidsforsinkelse ved visning av logg.
EH7.1.5.6	Varsling om oppdateringer i logg til innbygger. Det kan settes regler slik at en oppføring i loggen fører til e-post- eller SMS-varsling, slik at innbygger

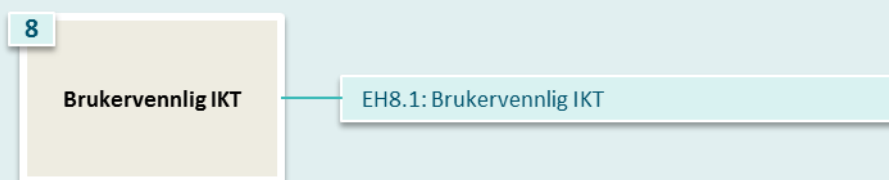
Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Oppfylle lovpålagte rettigheter og funksjoner for ivaretagelse av innbyggers personvern.
- Funksjonaliteten bidrar til forebyggende konfidensialitetsøkning, gjennom at innbygger får økt kontroll.
- Kan ha en forebyggende effekt mot smoking.

2.9 E-helsekapabilitet 8: Brukervennlig IKT

Løsningene skal være brukervennlige for både helsepersonell, pasienter og innbyggere og andre brukergrupper. Hva som defineres som en brukervennlig løsning, vil avhenge av brukernes hverdag, digitale kompetanse og personlige preferanser. Det vil likevel være nødvendig med gode rutiner og systematisk kompetansebygging for helsepersonell. Det er avgjørende at brukerne involveres i utvikling av løsningene, og brukervennligheten bør måles jevnlig.

Figur 38. E-helsekapabilitet med underkapabiliteter: Brukervennlig IKT



2.9.1 EH8.1: Brukervennlig IKT

Funksjonalitet EH8.1.1: Enkelhet i bruk

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for brukervennlige og intuitive løsninger, tilpasset brukergruppens behov.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH8.1.1.1	Brukervennlige, intuitive og tilpasset brukergruppens behov. Løsningene er intuitive, slik at det er enkelt å bruke de riktig. Løsningene oppleves som helhetlige og er gjenkjennbare på tvers av nivåer og tjenestoområder.
EH8.1.1.2	Gode søkemuligheter. Det er enkelt å finne frem og gjøre gode søk i løsningen.
EH8.1.1.3	Enkel pålogging og sømløse overganger. Det er enkelt å logge seg på løsningene (single sign-on), og det er sømløse overganger mellom de underliggende IKT-systemene. Unødvige pålogginger unngås.
EH8.1.1.4	Funksjonalitet for spesialistområder er tett integrert med helsepersonells arbeidsverktøy. Funksjonalitet for spesialistområder fremstår sømløst med øvrig funksjonalitet.
EH8.1.1.5	Universell utforming. Løsningene tilfredsstiller krav til universell utforming.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Brukervennlige løsninger er mer effektive, reduserer mulighet for feil og gir mer fornøyde brukere.
- Reduserer tid til opplæring.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Brukermedvirkning.

Utredning av «En innbygger – én journal»

E-helsekapabiliteter

Funksjonalitet EH8.1.2: Løsning uavhengig av lokasjon og tilpasset ulike brukerflater

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for mobile løsninger uavhengig av lokasjon og tilpasset ulike brukerflater.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH8.1.2.1	Registrering én gang og mest mulig automatisk registrering. Data registreres kun én gang og mest mulig automatisk. Dataene kan gjenbrukes både til primær- og sekundærformål, i henhold til formål og tilganger.
EH8.1.2.2	Tilgjengelige og mobile. Løsningene er tilgjengelige der brukerne befinner seg, og må tilfredsstille brukernes behov for mobilitet i hverdagen. For helsepersonell betyr dette at informasjon og løsninger er tilgjengelige i den aktuelle behandlingssituasjonen, også utenfor institusjon og uten stabilt nettverk. For innbygger betyr dette at informasjonen skal kunne nås der hun befinner seg.
EH8.1.2.3	Ulike kanaler/mobile enheter. Løsningen er tilgjengelig gjennom ulike kanaler/mobile enheter, så som pc, nettbrett og smarttelefoner.
EH8.1.2.4	Tilpasset brukerflate. Brukerflatene, med informasjons- og funksjonalitetstilgang er tilpasset de enkelte brukergrupper. Unødvendig informasjon og funksjonalitet vises ikke. Tilpasning kan gjøres både per helsepersonellkategori, spesialisering og/eller rolle.
EH8.1.2.5	Tilpasset fysiske omgivelser/smitte/sterilitet. Fysisk utforming kan tilpasses økte krav for smitte/sterilitet, f.eks. på operasjonsstue og høyrisiko infeksjonspost.

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Ulike brukergrupper har ulike behov for funksjonalitet og informasjonstilgang.
- Behov for mobile løsninger som gir tilgang til løsningen der brukerne befinner seg.

Hvilke forutsetninger må være tilstede for funksjonaliteten

- Strukturert og standardisert dokumentasjon.

Funksjonalitet EH8.1.3: Løsning tilpasset organisering, rolle og arbeidsprosess

Kort beskrivelse av funksjonaliteten

Funksjonalitet for at løsningen kan tilpasses organisering av helsehjelpen, arbeidsprosesser og roller.

Hvilke egenskaper bør funksjonaliteten ha

EH8.1.3.1	Tilpasset organisering av helsehjelpen, blant annet teamorientert. Løsningen kan tilpasses ulik organisering av helsehjelp, på tvers av enheter og nivå. Det er blant annet støtte for teamorganisering, og også personer utenfor helse- og omsorgstjenesten kan få tilgang.
------------------	--

Hvorfor er det behov for funksjonaliteten

- Organiseringen av helsehjelp er i kontinuerlig utvikling, og løsningen må understøtte dette. Det er blant annet økt grad av teamorganisering.

3 Bibliografi

1. **Open Group.** *The Exploration & Mining Business Capability Reference Map: Concepts and definitions.* 2014. ISBN 1-937218-49-2.
2. **Stabell, Charles B og Fjeldstad, Øystein D.** Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks. *Strategic Management Journal.* Vol. 19, 1998, Vol. 1998.
3. **World Health Organization.** Cancer pain relief and palliative care. Report of a WHO Expert Committee. *WHO Technical Report Series.* 804, 1990.
4. —. World Health Organization. *Cancer. WHO Definition of Palliative Care.* [Internett] [Sisert: 08 juni 2015.] <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>.
5. **Helse- og omsorgsdepartementet.** *Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.* 2012.
6. **Helsedirektoratet.** *Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet.* 2012.
7. **Helsebiblioteket.** [Helsebiblioteket.no](http://www.helsebiblioteket.no). *Kvalitetsforbedring - Samhandling. Behandlingslinjer.* [Internett] [Sisert: 27 mai 2015.] <https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/samhandling/metoder-og-verkt%C3%B8y/behandlingslinjer>.
8. **Helse- og omsorgsdepartementet.** *Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).* 2001.
9. —. *Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar.* 2013.
10. —. *Prop. 59 L (2014–2015) Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog).* 2015.
11. **Helsedirektoratet.** *Samhandlingsstatistikk 2013–14.* 2015.
12. **Statistisk Sentralbyrå.** *Helseregnskap, 2014.* [Internett] [Sisert: 19. juni 2015.] <https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/helsesat>.
13. **Helse- og omsorgsdepartementet.** *Helse- og omsorgstjenester i kommunene.* [Internett] [Sisert: 26. mai 2015.] <https://www.regjeringen.no/nb/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/omsorgstjenesten/id426407/>.
14. **Helsedirektoratet.** *Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren.* [Internett] 2014. [Sisert: 23 April 2015.] <https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkeltall-for-helsesektoren>.
15. —. *Helsedirektoratet.no. Finansieringsordninger. Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet.* [Internett] [Sisert: 12 juni 2015.] <https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet>.
16. **Kommunal- og moderniseringsdepartementet.** *Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.* [Internett] 2015.

<https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-14-2014-2015/id2401505/?q=tannhelse&docId=STM201420150014000DDDEPIS&ch=1>.

17. **Helse- og omsorgsdepartementet.** *Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet.*

18. **Statistisk sentralbyrå.** Private institusjoner i spesialisthelsetjenesten. *Høyest vekst for ideelle sykehus.* [Internett] 2009. [Sisert: 15 mai 2015.] <http://ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/hoyest-vekst-for-ideelle-sykehus>.

19. **Helsedirektoratet.** Aktivitetsdata for avtalespesialister 2014. *Norsk pasientregister.* [Internett] [Sisert: 15 mai 2015.] <https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/959/Aktivitetsdata%20for%20avtalespesialister%202014.pdf>.

20. **Statistisk sentralbyrå.** Pleie- og omsorgstenester, 2014, førebelse tal. [Internett] [Sisert: 24 juni 2015.] <https://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige/2015-06-24#content>.

21. **Helsedirektoratet.** Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel - Årsrapport 2014. [Internett] 2014. [Sisert: 29 April 2015.] <https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/990/%C3%85rsrapport%202014%20Helse-%20og%20omsorgstjenester%20til%20innsatte%20i%20fengsel%20IS-2359.pdf>.

22. **Legemiddelverket.** Apotekstatisitikk 2013. [Internett] [Sisert: 28 Mai 2015.] http://www.legemiddelverket.no/Import_og_salg/apotekokonomi/apotekstatistikk/Documents/Apotekstatistikk%202013_endelig.pdf.

23. **Statistisk sentralbyrå.** Helse- og sosialpersonell. [Internett] 2013. [Sisert: 28 April 2015.] <http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar/2014-06-13?fane=tabell&sort=nummer&tabell=179950>.

24. **Den norske legeforening.** Legeforeningen. *Spesialiteter.* [Internett] [Sisert: 09 juni 2015.] <http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/>.

25. **Helsedirektoratet.** Utviklingsstrategi for jordmortjenesten. Tjenestekvalitet og kapasitet. [Internett] 2010. [Sisert: 29 April 2015.] <https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingsstrategi-for-jordmortjenesten-tjenestekvalitet-og-kapasitet>.

26. **Statistisk sentralbyrå.** Kommunehelsetenesta, 2013. [Internett] 2014.

27. **Helsenorge.** Helsenorge.no. Hjelpetilbud i kommunen. *Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.* [Internett] [Sisert: 12 juni 2015.] <https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner>.

28. **Statistisk sentralbyrå.** Pleie- og omsorgstenester, 2013, førebelse tal. [Internett] [Sisert: 19 juni 2015.] <https://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige/2014-07-08?fane=tabell&sort=nummer&tabell=186129>.

29. **Helsenorge.** Frisklivssentral. [Internett] [Sisert: 29 April 2015.] <https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/frisklivssentral>.

30. **Direktoratet for forvaltning og IKT.** *Veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester.* 2013.
31. **Helse- og omsorgsdepartementet.** Slik er spesialisthelsetjenesten bygd opp. [Internett] 2014. [Sisert: 11 April 2015.] <http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/nokkeltall-og-fakta---ny/slik--er-spesialisthelsetjenesten-bygd-o.html?id=528748>.
32. **Statistisk Sentralbyrå.** Spesialisthelsetjenesten, tabell 03720. *ssb.no*. [Internett] 2012. [Sisert: 7 April 2013.] <https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveelections.asp>.
33. **Helse- og omsorgsdepartementet.** De regionale helseforetakene. [Internett] [Sisert: 15 mai 2015.] <https://www.regjeringen.no/nb/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nokkeltall-og-fakta---ny/de-regionale-helseforetakene/id528110/>.
34. **Statistisk Sentralbyrå.** Spesialisthelsetjenesten. *www.ssb.no*. [Internett] 19 Juni 2013. [Sisert: 11 April 2013.] <https://www.ssb.no/speshelse>.
35. **Helse- og omsorgsdepartementet.** Nøkkeltall og fakta. *Sykehus*. [Internett] [Sisert: 15 mai 2015.] <https://www.regjeringen.no/nb/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nokkeltall-og-fakta---ny/id528109/>.
36. **Luftambulansetjenesten ANS.** Historie og om oss. [Internett] [Sisert: 18 mai 2015.] <http://www.luftambulanse.no/historie-og-om-oss>.
37. **Arbeidstilsynet.** Bedriftshelsetjeneste (BHT). [Internett] [Sisert: 29 april 2015.] <http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78175>.
38. **Helsedirektoratet.** Alternativ behandlingsloven. [Internett] 2015. [Sisert: 29 april 2015.] <https://helsedirektoratet.no/lover/alternativ-behandlingsloven>.
39. —. Nøkkeltall: Brukerperspektivet. [Internett] [Sisert: 6 mai 2015.] <https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-brukerperspektivet>.
40. **Pasient- og brukerombudet.** *Årsmelding 2014*.
41. **Fylkesmannen.** Fylkesmannen.no. [Internett] [Sisert: 6 Mai 2015.] fylkesmannen.no.
42. **Helsenorge.** Kontrollkommisjonen. [Internett] [Sisert: 6 mai 2015.] <https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/psykisk-helsevern/kontrollkommisjonen>.
43. —. Hjelpebehov i skolen i et helseperspektiv . [Internett] <https://helsenorge.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/rettigheter-ved-sjeldne-diagnoser/hjelpetilbud-i-skolen-opplaring>.
44. —. Behandling hos logoped eller audiopedagog. [Internett] [Sisert: 15 mai 2015.] <https://helsenorge.no/behandlere/behandling-hos-logoped-eller-audiopedagog>.
45. **Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet .** Saksgang i barnevernet. [Internett] 2014. [Sisert: 29 April 2015.] <https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/barnevern/barnevern-ansvarsfordeling1/saksgang-i-barnevernet/id2353985/>.

46. **Kunnskapsdepartementet.** Pedagogisk-psykologisk tjeneste. [Internett] 2014. [Sisert: 29 April 2015.] <https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-/id699010/>.
47. **Statens Barnehus.** [Internett] [Sisert: 9 oktober 2015.] <http://www.statensbarnehus.no/>.
48. **Helsedirektoratet.** *Beslutningsstøtte. Definisjoner, status og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støtte.* 2014.
49. **Lövström R, Hoffman M, Gustaffson LL.** Kliniska beslutsstöd kan ge hjälp i den komplexa vården. *Läkartidningen.* 2014.
50. **Haggerty JL, Reid RJ, Freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R.** Continuity of care: a multidisciplinary review. *British Medical Journal.* 327, 2003.
51. **Sykehuspartner.** *Lukket legemiddelsløyfe og gjennomgående kurve i Helse Sør-Øst.* 2013.
52. **Helsebiblioteket.** Helsebiblioteket.no. *Retningslinjer. Ord og begreper.* [Internett] [Sisert: 17 desember 2015.] <https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/ord-og-begreper>.



Helsedirektoratet

Postadresse: Pb. 7000,
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: +47 810 20 050
Faks: +47 24 16 30 01
E-post: postmottak@helsedir.no

www.helsedirektoratet.no



Direktoratet for e-helse

Postadresse: Pb. 6737,
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: +47 21 49 50 70
E-post: postmottak@ehelse.no

www.ehelse.no